



MINISTERIO
DE SANIDAD

AMIR

PRUEBAS SELECTIVAS CUADERNO DE EXAMEN

MEDICINA - VERSIÓN: 0
SIMULACRO 20

NÚMERO DE MESA:

NÚMERO DE EXPEDIENTE:

Nº DE D.N.I. O EQUIVALENTE PARA EXTRANJEROS:

APELLIDOS Y NOMBRE:

ADVERTENCIA IMPORTANTE

ANTES DE COMENZAR SU EXAMEN, LEA ATENTAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES

- 1. MUY IMPORTANTE:** Compruebe que este Cuaderno de Examen, lleva todas sus páginas y no tiene defectos de impresión. Si detecta alguna anomalía, pida otro Cuaderno de Examen a la Mesa. **Realice esta operación al principio**, pues si tiene que cambiar el cuaderno de examen posteriormente, se le facilitará una versión "0", que no coincide con su versión personal en la colocación de preguntas y **no dispondrá** de tiempo adicional.
- El cuestionario se compone de 200 preguntas más 10 de reserva. Tenga en cuenta que hay 30 **preguntas que están ligadas a una imagen**. Todas las imágenes están en un cuaderillo de imágenes separado.
- Compruebe que el **número de versión** de examen que figura en su "Hoja de Respuestas", **coincide** con el número de versión que figura en el cuestionario. Compruebe también el resto de sus datos identificativos.
- La "Hoja de Respuestas" está nominalizada. Se compone de dos ejemplares en papel autocopiativo que deben colocarse correctamente para permitir la impresión de las contestaciones en todos ellos. Recuerde que debe firmar esta Hoja.
- Compruebe que la respuesta que va a señalar en la "Hoja de Respuestas" corresponde al número de pregunta del cuestionario. **Sólo se valoran** las respuestas marcadas en la "Hoja de Respuestas", siempre que se tengan en cuenta las instrucciones contenidas en la misma.
- Si inutiliza su "Hoja de Respuestas" pida un nuevo juego de repuesto a la Mesa de Examen y **no olvide** consignar sus datos personales.
- Recuerde que el tiempo de realización de este ejercicio es de cuatro horas y media improrrogables y que están prohibidos el uso de calculadoras y la utilización de teléfonos móviles, o de cualquier otro dispositivo con capacidad de almacenamiento de información o posibilidad de comunicación mediante voz o datos.
- No se entregarán**, en ningún caso, **los cuestionarios** con las preguntas de examen. Las distintas versiones de los cuadernos de examen se publicarán en la Web del Ministerio de Sanidad, al cierre de la última mesa de examen.

1. Pregunta vinculada a la imagen nº 1:

La lesión del parénquima pulmonar que se aprecia en la imagen 1 puede afectar varias regiones anatómicas del pulmón, pero, atendiendo exclusivamente a los hallazgos radiológicos, se puede afirmar con rotundidad que se encuentra al menos en una de las siguientes localizaciones:

1. Lígula.
2. Lóbulo superior.
3. Lóbulo medio.
4. Lóbulo inferior.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Este es el denominado signo de la silueta en las radiografías de tórax. Más que de anatomía es una pregunta de radiología, pero en algún sitio hay que clasificarla. Cuando una masa borra la silueta cardíaca, dicha masa se sitúa en el mismo plano que el corazón, es decir, en el lóbulo medio en el pulmón derecho o en la lígula si se trata del lado izquierdo (opción 1 correcta). Cuando la masa se sitúa superpuesta al corazón (se ve claramente el contorno de ambos) debemos localizarla en un plano posterior al corazón, es decir en los lóbulos inferiores de ambos pulmones.

2. Pregunta vinculada a la imagen nº 2:

Mujer de 51 años de edad, que consulta por debilidad generalizada y visión doble de 3 meses de evolución. Se le realiza un test de Edrofonio y una Electromiografía que permiten un diagnóstico de Miastenia Gravis. Se realiza una radiografía posteroanterior de tórax que se muestra en la imagen 2. ¿Qué patología mediastínica debemos sospechar como más probable?:

1. Bocio endotorácico.
2. Timoma.
3. Teratoma.
4. Linfoma.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Siempre en paciente con miastenia gravis y masa mediastínica (la Rx de tórax casi nos da igual por lo típico del caso, pero se aprecia un ensanchamiento mediastínico debido a la aparición de una masa retroesternal) debemos pensar automáticamente en un timoma. Recordad que en pacientes jóvenes y en formas generalizadas suele realizarse timentomía.

3. Pregunta vinculada a la imagen nº 3:

Enfermo de 50 años de edad que refiere que hace unos 5 años le aparecen en distintas

zonas de la superficie cutánea una placas eritematosas, algunas con ligera descamación y picor. Posteriormente le aparecen de forma sucesiva placas infiltradas eritematosas y en los últimos meses lesiones como la que se muestra en la imagen 3. ¿Cuál de los diagnósticos que a continuación se enumeran es el más correcto?:

1. Melanoma metastásico.
2. Histiocitosis X.
3. Neurofibromatosis.
4. Micosis fungoide.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La imagen muestra una lesión tumoral ulcerada, típica de la tercera fase de la micosis fungoide. Se trata de un linfoma cutáneo de células T que aparece en adultos de 55-60 años, y evoluciona lentamente. Cursa en tres fases, como nos describen en la pregunta: -Fase macular: manchas descamativas y eritematosas. Su tratamiento se basa en esteroides tópicos. -Fase infiltrativa o de placas: placas infiltradas, con una histología específica que debemos recordar (epidermotropismo de células T atípicas con núcleo cerebriforme y microabscesos de Pautrier). Se pueden beneficiar de tratamiento con PUVA. -Fase tumoral: desaparece el epidermotropismo y aparecen grandes acúmulos dérmicos de linfocitos atípicos. Su tto es más agresivo, con poliQT, RT, retinoides. El caso clínico de la pregunta se ajusta a la clínica de la micosis fungoide, (respuesta 4 correcta). El resto de opciones no concuerdan con la información que nos cuentan en el caso clínico.

4. Pregunta vinculada a la imagen nº 4:

Un paciente de 65 años, sin antecedentes de interés, excepto cirrosis hepática por virus C, consulta por disnea de esfuerzo. La gasometría muestra: pH 7.42; pCO₂ 35 mmHg; pO₂ 58 mmHg y pO₂ (A-a) 48, sin mejoría tras oxigenoterapia. La radiografía de tórax se muestra en la imagen. ¿Cuál es, entre los siguientes, el trastorno subyacente responsable?:

1. Alteraciones de la pared torácica.
2. Shunt intrapulmonar.
3. Enfermedad intersticial pulmonar.
4. Enfermedad vascular pulmonar.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La radiografía de tórax es normal, y la pregunta se contesta sin mirarla. Es una clásica pregunta del algoritmo de la hipoxemia. El primer paso es la presencia o ausencia de hipercapnia como reflejo directo de la hipoventilación alveolar; este caso no tiene hipercapnia, se descarta hipoventilación y por tanto la opción 1. El segundo paso es valorar si el problema es intraparenquimatoso o extraparenquimatoso con el gradiente alveoloarterial

de oxígeno. Un valor normal, <15 , descarta enfermedad parenquimatosa, mientras que un valor elevado como éste (48) implica afectación parenquimatosa (volvemos a descartar la opción 1). Cuando el gradiente alveoloarterial está alterado, se debe hacer una prueba de respuesta al oxígeno al 100%. La ausencia de mejoría implica la existencia de un mecanismo tipo shunt, que puede deberse a colapso alveolar (atelectasia), ocupación alveolar (neumonía, edema, distrés) o la presencia de un shunt vascular auténtico. La mejoría con oxígeno es propia de los trastornos de la difusión y de las alteraciones de la concordancia ventilación-perfusión. En el caso clínico, hay normocapnia (descarta hipoventilación) con gradiente aumentado sin respuesta a oxigenoterapia (descarta trastornos ventilación-perfusión como las enfermedades vasculares o intersticiales), lo que implica un trastorno tipo shunt, siendo la única respuesta válida la existencia de shunt intrapulmonar. Probablemente se trate de un síndrome hepatopulmonar, un tipo de shunt que aparece en los cirróticos muy avanzados.

5. Pregunta vinculada a la imagen nº 5:

Un paciente de 30 años habitante de un pueblo de Cantabria, no fumador, que trabaja por las mañanas en una cantera de granito y por las tardes ayuda en su casa al cuidado del ganado vacuno, acude al médico por disnea de esfuerzo y un patrón intersticial. La TAC torácica se muestra en la imagen 5. El diagnóstico más probable es de:

1. Neumonitis por hipersensibilidad.
2. Proteinosis alveolar.
3. Sarcoidosis.
4. Silicosis.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

La TC torácica confirma el patrón intersticial visto en la radiografía de tórax, y además objetiva imágenes de vidrio esmerilado de tipo mosaico. La clínica nos da un antecedente propio de silicosis (cantera) y uno de neumonitis de hipersensibilidad (ganadero), pero esa imagen de vidrio deslustrado no se da en la silicosis, así que optamos por la neumonitis de hipersensibilidad. La silicosis cursaría con afectación nodular en la placa de tórax y TAC, así que no nos concuerda. La neumonitis por hipersensibilidad o alveolitis alérgica extrínseca es un grupo de enfermedades producidas por reacción inmunológica contra polvos orgánicos, generalmente en relación con exposiciones laborales. Cursan con infiltración intersticial por linfocitos y macrófagos, típicamente con citoplasma espumoso. Hay una forma aguda, relacionada con exposiciones intensas al antígeno, que aparece a las pocas horas con una clínica similar a una neumonía bacteriana: fiebre, mialgias, malestar, tos no productiva; cursa con neutrofilia y marcada linfopenia en sangre periférica, y en la placa de tórax es habitual un infiltrado retículo-nodular bibasal. Hay una forma crónica tras exposiciones prolongadas de baja intensidad, que

cursa con disnea de larga evolución y tos (que puede ser productiva), similar a una bronquitis crónica. De hecho, por su asociación a bronquiolitis obliterante puede cursar con patrón obstructivo espirométrico, lo que puede retrasar el diagnóstico. En la radiografía muestra un patrón retículo-nodular de predominio apical, y en el CT torácico se observa afectación intersticial con engrosamiento de septos y afectación nodulillar, y áreas de vidrio emeralado que son las zonas de actividad inflamatoria. Es característica la presencia de granulomas en la biopsia, y linfocitosis en el LBA, con predominio de linfocitos CD8 y por tanto cociente CD4/CD8 bajo. Responden a la retirada del estímulo antigénico y corticoides, pero si hay lesiones crónicas pueden ser no reversibles.

6. Pregunta vinculada a la imagen nº 6:

Varón de 76 años, exfumador y con antecedentes de HTA, diabetes mellitus, y EPOC con FEV1 del 45%. Acude al servicio de urgencias por palpitaciones de 5 horas de evolución. Refiere episodios similares, autolimitados, de horas de evolución desde hace semanas. TA 135/75. Se realiza ECG (imagen 6), que corresponde con:

1. Flutter auricular común con conducción ventricular 2:1.
2. Fibrilación auricular con respuesta ventricular no controlada.
3. Taquicardia ventricular monomorfa sostenida.
4. Taquicardia por reentrada intranodal.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

En el ECG observamos una taquicardia de QRS estrecho regular a 150 lpm. La línea de base es la típica “en dientes de sierra” que producen las ondas F del flutter auricular, común en este caso (ondas F negativas en cara inferior y positivas en V1), conducidas 2 a 1 al ventrículo (es decir, las aurículas van a 300 lpm y los ventrículos a 150 lpm). Como datos orientativos tenemos el antecedente de EPOC, dado que el flutter es muy típico en este tipo de pacientes por la hipertensión pulmonar asociada y la dilatación de aurícula derecha (donde se asienta el circuito de macrorreentrada del flutter, que si es común, como en este caso, involucra al mismo cavotricuspidé, pudiéndose ablacionar esta zona en el laboratorio de electrofisiología). Recuerda que en el MIR, ante una taquicardia a 150 lpm, el flúter es SIEMPRE una opción que debes tener muy presente.

7. Pregunta vinculada a la imagen nº 7:

A las 4 de la madrugada le avisa su residente pequeño de la guardia para valorar el registro cardiotocográfico que aparece en la imagen y que se obtuvo mediante monitorización externa. Se trata de una secundigesta, con un parto instrumental anterior, con serología positiva para rubéola, toxoplasma y VHB, que ingresó

por rotura prematura de membranas hace 3 horas. La exploración en el momento actual es de 6 cm de dilatación, borrado completamente, con un feto en cefálica, posición oblicua iliaca anterior izquierda en III plano de Hodge. El líquido amniótico continúa claro. ¿Cuál de las siguientes considera la actitud más correcta?:

1. Dejar evolucionar el parto, dada la buena variabilidad del registro.
2. Realizar una prueba de Posse para objetivar el registro del feto cuando sometemos a éste a estrés.
3. Realizar una microtoma de sangre fetal para valorar el pH, a pesar de ser portadora del VHB.
4. Finalizar la gestación, dado el mal aspecto del registro cardiotocográfico.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

El registro muestra desaceleraciones de tipo II. El siguiente paso por tanto es realizar una microtoma. Nos debemos fijar primero en que la dilatación del cérvix nos lo permita. Aunque sea portadora de VHB se puede realizar el pH, la contraindicación para la microtoma son la infección por VHC y el VIH.

8. Pregunta vinculada a la imagen nº 8:

¿Qué le sugeriría encontrarse, en un frotis de sangre periférica, el agrupamiento de hematíes mostrado en la imagen 8?:

1. Hemólisis.
2. Leucemia mieloide.
3. Inflamación crónica.
4. Paraproteíemia.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

El apilamiento de hematíes en pilas de moneda ("Rouleaux") se debe a hematíes "pegados" por presencia de paraproteína; para detectarla se debe hacer proteinograma, que mostrará probablemente un pico monoclonal.

9. Pregunta vinculada a la imagen nº 9:

Un paciente de 25 años, sin antecedentes personales de interés, y con antecedentes familiares de psoriasis, acude a su consulta refiriendo que, tras la vuelta del viaje de fin de carrera en la Rivera Maya, le han aparecido unas lesiones distribuidas por todo el tronco, que son asintomáticas y se muestran en la imagen (a la izquierda). Con la luz de Wood las lesiones muestran fluorescencia amarillenta y al realizar tinción de unas escamas se aprecia una imagen como la que se muestra (a la derecha). Con lo descrito, ¿cuál sería el diagnóstico?:

1. Psoriasis vulgar.
2. Pitiriasis rosada.
3. Pitiriasis versicolor.
4. Sarna.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La pitiriasis versicolor es una micosis superficial muy frecuente; está causada por hongos del género *Malassezia* (*M. furfur*, *M. globosa*...) y se caracteriza por la aparición de máculas de coloración variable (marrones, hipocrómicas, etc) generalmente asintomáticas, con predominio por la afectación del tronco. Es característico el signo de la uña (descamación de las máculas al ser raspadas), y si se tiñen las escamas obtenidas se obtiene la típica imagen en espaguetis y albondiguillas como la mostrada en la imagen. Se trata en general con antifúngicos tópicos (salvo en inmunodeprimidos donde es necesario el tratamiento por vía oral, también se podría considerar en infecciones recidivantes o en afectaciones muy extensas).

10. Pregunta vinculada a la imagen nº 10:

Acude al servicio de urgencias un varón de 23 años que refiere un traumatismo casual en miembro inferior derecho mientras practicaba patinaje. A la exploración física presenta tumefacción grave, deformidad y dolor a la palpación del tercio medio y distal de la pierna derecha. La radiografía realizada se muestra en la imagen. Respecto a la lesión que presenta el paciente señale las medidas terapéuticas a realizar:

1. Se trata de una fractura que puede ser tratada de forma conservadora, luego el tratamiento más oportuno sería la colocación de un yeso cerrado y alta hospitalaria.
2. Tras descartar alteraciones neurovasculares distales se procederá a realizar una reducción abierta y fijación interna de forma Urgente.
3. Tras descartar alteraciones neurovasculares distales y si el paciente no presenta enfermedades que contraindiquen la cirugía se procederá a realizar una reducción cerrada y enclavado endomedular.
4. Tras descartar alteraciones neurovasculares distales y si el paciente no presenta enfermedades que contraindiquen la cirugía se procederá a realizar una reducción y osteosíntesis mediante fijación externa circular.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta sencilla acerca del tratamiento de una fractura diafisaria de tibia. En el caso de no recordar el tratamiento exacto de este tipo de fracturas, hemos de recordar que el tratamiento de una fractura diafisaria cerrada es el enclavado endomedular. Respecto al resto de las opciones 1. Se podría

realizar tratamiento conservador si el paciente tuviera tal comorbilidad que contraindicara el tratamiento quirúrgico 2. El tratamiento de esta fractura no es necesario realizarlo de forma urgente, esto no quiere decir que si podemos operarla en las primeras horas no lo hagamos, pero en la inmensa mayoría de los centros hospitalarios no es así. Además no estaría indicada la reducción abierta de la fractura 3. Es el tratamiento de elección. Reducción cerrada y enclavado endomedular. 4. La fijación externa se realizaría en caso de que fuera una fractura abierta grado IIIB o superior o como tratamiento provisional hasta que el estado de las partes blandas permita realizar el enclavado.

11. Pregunta vinculada a la imagen nº 11:

Recién nacido pretérmino de 32 semanas de edad gestacional que comienza, tras el inicio de tolerancia oral con fórmula artificial, con cuadro de distensión abdominal, y sangre en heces. A la exploración física presenta mala perfusión, palidez mucocutánea, taquicardia y TA en el límite bajo. Se realiza radiografía de abdomen que muestra la imagen; los principales hallazgos se marcan con flechas. ¿Cuál es el factor protector más importante de la patología que presenta el paciente?:

1. Administración de ranitidina con las tomas.
2. Alimentación con lactancia materna.
3. Inicio precoz de la alimentación oral.
4. Poliglobulia.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Rx de abdomen: edema de la pared intestinal, distensión de asas con ausencia de aire distal, neumatos intestinal (cabeza de flecha) y gas en vena porta (flecha). Se presenta un caso de enterocolitis necrotizante. El dato clave es la prematuridad y la clínica digestiva. El enunciado nos dice que el paciente comienza con el cuadro tras la introducción de alimentación con fórmula artificial. Esto nos induce a pensar que la lactancia artificial es un factor de riesgo y por tanto la lactancia materna un factor protector (respuesta 2 correcta).

12. Pregunta vinculada a la imagen nº 12:

¿Qué se objetiva en esta gammagrafía de tiroides?:

1. Captación difusa típica de enfermedad de Graves.
2. Bocio multinodular.
3. Nódulo tóxico.
4. Nódulo frío.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Se objetiva nódulo frío (hipocaptante) en el polo superior del lóbulo tiroideo izquierdo.

13. Pregunta vinculada a la imagen nº 13:

Un varón de 37 años acude a la consulta consultando por unas lesiones cutáneas de unos meses de evolución en codos, rodillas, zona baja de la espalda y glútea y extremidades inferiores. En la exploración física se aprecian lesiones características que se muestran en la fotografía adjunta. ¿Cuál es la patología de sospecha?:

1. Liquen plano.
2. Pitiriasis rosada de Gilbert.
3. Lupus cutáneo subagudo.
4. Psoriasis vulgar.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La imagen muestra placas eritematosas y descamativas bien delimitadas con descamación superficial, típicas de la psoriasis.

14. Pregunta vinculada a la imagen nº 14:

En cuanto a la patología que presenta la paciente de la imagen, indique la respuesta verdadera:

1. La causa más probable de su patología es un tumor en la glándula suprarrenal.
2. En los casos de origen suprarrenal es frecuente que el paciente se encuentre hiperpigmentado.
3. Probablemente la paciente tenga una patología que le haya obligado a seguir tratamiento con corticoides.
4. En caso de seguir tratamiento corticoideo crónico, deberíamos retirarlo inmediatamente para evitar la progresión del síndrome.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Se trata de una paciente con síndrome de Cushing. Presenta obesidad de predominio abdominal y cara en luna llena, además de estrías rojo vinosas abdominales gruesas (típicas del Cushing), equimosis cutánea... La causa más probable de Sd Cushing es el tratamiento exógeno con corticoides (3 correcta y 1 falsa). En un paciente que siga tratamiento crónico con corticoides en caso de poder retirarse debe realizarse de forma escalonada para evitar una crisis suprarrenal. (4 falsa). Si se tratara de un Cushing suprarrenal el paciente no estaría hiperpigmentado porque es una causa de Cushing ACTH independiente y por tanto con ACTH suprimida (la ACTH es la responsable directa de la hiperpigmentación, por lo que sólo los Cushing ACTH-dependientes pueden cursar con este signo).

15. Pregunta vinculada a la imagen nº 15:

Hombre de 56 años evaluado porque en una radiografía de tórax realizada para un estudio preoperatorio de hernia inguinal aparecen

los hallazgos que se muestran en la imagen 2. El paciente se encuentra asintomático. ¿Cuál considera usted que es el dato a conocer?:

1. Indagar antecedentes de tuberculosis.
2. Interrogar sobre la existencia de animales domésticos.
3. Buscar la existencia de alteraciones articulares en la exploración física.
4. Interrogar sobre la historia laboral.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La radiografía de tórax muestra engrosamientos pleurales bilaterales a nivel de los campos medios pulmonares. Dichos engrosamientos se encuentran calcificados, de ahí su alta densidad. Estos hallazgos son compatibles con placas pleurales, típicas de la exposición al asbesto. La exposición laboral al asbesto era relativamente frecuente antes de que se descubriera su potencial carcinogénico: hoy día debe sospecharse en fontaneros (revestimiento de tuberías y calderas) y automoción (fabricación de zapatas de frenos), aunque es rara debido a los controles laborales. La exposición al asbesto puede originar alteraciones pleurales, con placas pleurales y en ocasiones derrame pleural benigno; en el parénquima pulmonar puede originar atelectasias redondas. Cualquiera de estos hallazgos revela exposición y no es indicativo por sí mismo de patología por el asbesto. La asbestosis es una afectación intersticial, caracterizada radiológicamente por infiltración reticular basal (acompañada de hallazgos de exposición a asbesto) y en la espirometría por un patrón restrictivo con descenso de la DLCO.

16. Pregunta vinculada a la imagen nº 16:

Mujer de 65 años, con antecedentes de asma crónico y crisis frecuentes que precisan tratamiento con glucocorticoides por vía sistémica, la última hace 15 días. Una semana antes de ingresar en el hospital comienza con tos, expectoración amarillenta, en ocasiones con sangre, seguido de fiebre y aparición de disnea, que no mejora a pesar del tratamiento con amoxicilina - clavulánico. La placa de tórax al ingreso en el hospital se muestra en la imagen. De los diagnósticos siguientes, ¿cuál es el más probable?:

1. Neumonía viral.
2. Infección por *Aspergillus fumigatus*.
3. Infección por *Streptococcus pneumoniae*.
4. Infección por *Legionella pneumophyla*.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La radiografía de tórax muestra un infiltrado intersticial y nodular bilateral y parcheado, bastante inespecífico,

pero que en el contexto clínico de inmunosupresión y no respuesta a antibióticos sugiere infección por hongos. El tratamiento con corticoides sistémicos aumenta el riesgo de infecciones por herpesvirus, CMV, hongos, reactivación de TBC y algunas bacterias como *Nocardia*, *Listeria*, *S. aureus*. En nuestro paciente la presencia de neumonía bilateral con patrón intersticial y nodular y sin más datos específicos es compatible con *Aspergillus*. La neumonía viral tiene un patrón alveolar y rara vez se cavita.

17. Pregunta vinculada a la imagen nº 17:

Un hombre de 70 años con hipercolesterolemia, estenosis mitral reumática y con antecedentes de infarto de miocardio presenta el ECG mostrado en la imagen. ¿Cuál de estos signos exploratorios NO estará presente?:

1. Primer tono fuerte.
2. Onda a.
3. Soplo diastólico de llenado.
4. Chasquido de apertura.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

El ECG muestra fibrilación auricular a unos 78 lpm, ondas Q de necrosis septal (V1-V2; suponemos que los antecedentes de CP isquémica se referirán a un IAM septal antiguo), y alteración difusa de la repolarización con ondas T aplanadas en muchas derivaciones. Pregunta muy fácil y además muy típica en el MIR, que la repiten año tras año. Debes recordar la fisiopatología de la EM y las características del soplo (que se pueden deducir si conoces la fisiopatología). Recuerda que la causa más frecuente de EM es la fiebre reumática, que por un proceso reparativo produce engrosamiento, fibrosis y progresiva calcificación de los velos y del aparato subvalvular. Así, la válvula engrosada y fibrosa es más rígida y al cerrarse suena más (primer ruido fuerte). A continuación viene la sístole, que salvo mucha evolución, con afectación de cámaras derechas (insuficiencia tricúspide) no presenta ruidos patológicos. A continuación viene el segundo ruido. Lógicamente, si hay hipertensión pulmonar, lo oiremos desdoblado (por retraso del cierre pulmonar) y se oirá más fuerte el componente pulmonar. Comienza la diástole y, cuando la presión de la AI es mayor que la del VI, se abre la válvula mitral. De igual forma, la válvula es más rígida y suena al abrirse y es lo que produce el chasquido de apertura (no olvides que si la válvula está muy calcificada, ni se abre ni se cierra bien y puede ocurrir que el primer ruido sea débil y el chasquido no se oiga). A continuación del chasquido viene el soplo diastólico de llenado (retumbo mitral) y, SI EL PACIENTE ESTÁ EN RITMO SINUSAL, al final de la diástole, con la contracción auricular el soplo se incrementa (arrastre o reforzamiento presistólico). Pero la paciente está en fibrilación auricular, así que no tiene ondas "a" en su pulso venoso (en la FA no hay contracción auricular) y no tendrá acentuación presistólica del soplo. Repásate la auscultación en el dibujo del manual.

18. Pregunta vinculada a la imagen nº 18:

Hombre de 45 años de edad diagnosticado de úlcera péptica duodenal a los 25 años, y que presenta reagudizaciones estacionales que trata con Ranitidina. Coincidiendo con una fase aguda se realiza endoscopia oral que demuestra a nivel bulbar gástrico la lesión que se muestra en la imagen. La prueba de ureasa antral es positiva. ¿Cuál, entre los siguientes, le parece el tratamiento más conveniente?:

1. Clavulánico + Ciprofloxacino + Bismuto coloidal durante 7 días.
2. Ciprofloxacino + Bismuto Coloidal+ Pantoprazol durante 10 días.
3. Amoxicilina + Bismuto Coloidal + Omeprazol durante 20 días.
4. Amoxicilina + Claritromicina + Pantoprazol durante 10-14 días.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La imagen muestra una úlcera péptica a nivel bulbar, con fondo de fibrina (blanquecino) lo que indica un bajo riesgo de sangrado. Una de las indicaciones de tratamiento erradicador de *H. pylori* es que haya una úlcera péptica demostrada (como es paciente del caso). Pregunta algo desactualizada ya que a día de hoy se realiza tratamiento con 3 atb y 1 IBP. La pauta más utilizada es OCAM durante 14 días y la respuesta que más se parece a dicha pauta es la respuesta 4.

19. Pregunta vinculada a la imagen nº 19:

Hombre de 70 años de edad con antecedentes de demencia senil, estreñimiento crónico y abuso de laxantes que presenta náuseas y dolor abdominal. A la exploración el abdomen está distendido y doloroso a la palpación, sobre todo en el flanco izquierdo, con percusión timpánica y ruidos “metálicos”. La radiografía de abdomen se muestra en la imagen. El diagnóstico más probable en este paciente es:

1. Síndrome de Ogilvie.
2. Diverticulitis aguda.
3. Vólvulo de ciego.
4. Vólvulo de sigma.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta fácil. La imagen muestra una gran distensión del colon, que se incurva produciendo una imagen en “grano de café” a nivel del sigma, lo cual se corresponde con un vólvulo (opción 4 correcta). Se sabe que es del sigma y no del ciego, porque por transparencia se ven asas de ciego normales, pero no de sigma (en marco cólico izquierdo). Añadir que los otros datos del enunciado también apoyan

el diagnóstico: - La edad avanzada, los laxantes, el encamamiento, el megacolon, el dolico-sigma y la cirugía abdominal previa son factores predisponentes para la presentación de vólvulos. - La distensión abdominal, el dolor sobretodo en flanco izquierdo y los ruidos metálicos es una clínica totalmente compatible.

20. Pregunta vinculada a la imagen nº 20:

Un paciente de 80 años acude al médico tras haber presentado un síncope brusco mientras subía un tramo de escaleras. La exploración física muestra un soplo sistólico eyectivo 3 sobre 6, y el electrocardiograma se muestra en la imagen. Es su primer síncope, nunca ha presentado dolor torácico y tiene una buena clase funcional. ¿Qué exploración diagnóstica solicitaría en primer lugar?:

1. Un test de mesa basculante.
2. Un Holter de 24 horas.
3. Un ecocardiograma-Doppler.
4. Una prueba de esfuerzo.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta que no debes fallar. El ECG muestra taquicardia sinusal a unos 105 lpm y signos de hipertrofia del ventrículo izquierdo (voltajes de la R muy altos en V4-V6 y voltajes de la S muy altos en V2-V3. Clásicamente, si la suma de la R de V5 y la S de V2, o bien de la R de V4 y de la S de V3 da más de 35 mm -7 cuadrados grandes- es altamente probable que el paciente tenga hipertrofia del VI). En el ECG aparecen además alteraciones difusas de la repolarización, que son secundarias a la hipertrofia ventricular (y es importante que las reconozcáis como tales). Si se tratara de cardiopatía isquémica, las alteraciones de la repolarización serían focales, afectando de manera selectiva al territorio isquémico. Nos presentan un caso clínico con los suficientes datos para sospechar una estenosis aórtica: anciano, soplo sistólico eyectivo y con hipertrofia ventricular izquierda (recuerda que la hipertrofia concéntrica es el mecanismo compensador de la sobrecarga de presión al ventrículo, para reducir la tensión de pared -ley de Laplace-). Además ha presentado uno de los síntomas capitales de la estenosis aórtica severa: síncope de esfuerzo, que se produce porque con el ejercicio hay disminución de las resistencias periféricas para demandar un aumento del gasto cardíaco, que no es posible compensar debido a la obstrucción que produce la válvula aórtica. Con ello, disminuye el flujo cerebral y se produce el síncope. Así pues, la prueba diagnóstica de elección para confirmar la presencia y la severidad de una valvulopatía es el ecocardiograma-Doppler transtorácico. Si por cualquier motivo en el examen no recuerdas nada de la estenosis aórtica...la puedes sacar pensando que el paciente presenta un síncope de perfil cardiológico (brusco) con un ECG que no es normal y que requiere descartar cardiopatía orgánica. La única prueba para ello es el ecocardiograma. No olvides que la prueba de esfuerzo en una estenosis aórtica severa

sintomática está contraindicada. El test de mesa basculante se solicita para el estudio de los síncope vasovagales (diferentes al descrito en la pregunta, habitualmente con pródromos, en situaciones de estrés emocional o en el postesfuerzo) y el Holter de 24 horas ante la sospecha de eventos arrítmicos.

21. Pregunta vinculada a la imagen nº 21:

Una mujer de 72 años, diabética, acude a Urgencias con un dolor torácico de características anginosas, de inicio en reposo y de 4 horas de evolución. El ECG se observa en la imagen. ¿Cuál de las siguientes opciones terapéuticas NO es adecuada?:

1. Enoxaparina.
2. Atorvastatina.
3. Acido acetilsalicílico.
4. Activador tisular del plasminógeno (t-PA).

Respuesta correcta: 4

Comentario:

El cuadro clínico que nos presentan es el de una paciente con un dolor anginoso prolongado y datos en el electrocardiograma compatibles con isquemia miocárdica NO TRANSMURAL; por tanto estamos ante un síndrome coronario agudo sin elevación del ST (SCASEST). En el ECG existe ritmo sinusal y evidentes alteraciones de la repolarización: ondas T negativas en cara inferior-II, III y AVF. en I y de V2 a V6 (recordad que la onda T negativa en V2 puede ser fisiológica en las mujeres), lo cual asociado al cuadro clínico es compatible con cardiopatía isquémica. Es decir, se trata de un angor inestable (larga duración) de alto riesgo (cambios electrocardiográficos), probablemente por una placa ateromatosa complicada con trombo que NO ocluye la luz del vaso de forma completa. En este último caso, encontraríamos en el electrocardiograma elevación del segmento ST, lo que indicaría reperfusión urgente. Así, de las medidas propuestas todas son correctas (antiagregación con ácido acetilsalicílico (posteriormente un segundo antiagregante) y anticoagulación con heparinas de bajo peso molecular o heparina no fraccionada), salvo la fibrinólisis con activador tisular del plasminógeno (opción 4 incorrecta), que no ha mostrado beneficio más que en las oclusiones agudas completas (manifestadas en el ECG con elevación del ST).

22. Pregunta vinculada a la imagen nº 22:

Un paciente de 22 años de edad, sin antecedentes patológicos y sin hábitos tóxicos presenta un cuadro de 8 días de evolución de fiebre y dolor centrotorácico intenso que aumenta con la inspiración y los movimientos respiratorios. El ecocardiograma se muestra en la imagen; para su más fácil interpretación se han añadido los nombres de las cavidades cardiacas (VI = ventrículo izquierdo; VD = ventrículo derecho; AI = aurícula izquierda; AD = aurícula

derecha). La PA es de 110/60 mmHg y la presión venosa yugular es normal. ¿Cuál sería su primer diagnóstico?:

1. Pericarditis aguda idiopática.
2. Pericarditis tuberculosa.
3. Pericarditis purulenta.
4. Taponamiento cardíaco.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

El ecocardiograma muestra derrame pericárdico importante circunferencial, más evidente a nivel de la AD lo cual es lo habitual. El derrame no produce compresión de la AD ni del VD, por lo que ecocardiográficamente no produce signos de compromiso hemodinámico. Además el paciente está normotenso y con PA normal, lo que descarta taponamiento. Las enfermedades del pericardio no son muy preguntadas en el MIR y es suficiente con que domines unos pocos aspectos. Debes saber identificar un caso clínico de pericarditis aguda, la clínica y el diagnóstico del taponamiento cardíaco y el diagnóstico diferencial entre la pericarditis constrictiva y la miocardiopatía restrictiva. Éste es un caso sencillo sobre una pericarditis aguda, fácil de identificar por la clínica de fiebre, dolor centrotorácico de características pleuríticas y la presencia de derrame pericárdico. La ausencia de compromiso hemodinámico nos lleva a descartar la opción de taponamiento cardíaco (opción 4). Ante una pericarditis aguda, la etiología más frecuente con mucho es la idiopática, sobre todo en sujetos jóvenes de sexo masculino. Esto nos llevaría a descartar el resto de opciones, ya que otras etiologías de pericarditis aguda son más infrecuentes. Se cree que la pericarditis aguda idiopática está en relación con infección por virus Coxackie B. La clínica debida a la inflamación pericárdica suele ir precedida de una infección de vías respiratorias altas.

23. Pregunta vinculada a la imagen nº 23:

Una campesina de 30 años no fumadora y sin antecedentes de haber inhalado otras sustancias nocivas presenta disnea progresiva desde hace meses; y tres semanas antes sufrió un pequeño neumotórax espontáneo que se resolvió de forma conservadora. Presenta la radiografía de tórax de la imagen. Se completa el estudio con TC pulmonar que muestra además un pequeño derrame pleural. El diagnóstico más probable es:

1. Neumonitis por hipersensibilidad.
2. Sarcoidosis.
3. Histiocitosis X.
4. Linfangioleiomiomatosis.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La radiografía de tórax muestra un patrón intersticial difuso de apariencia difusamente quística, junto con aumento de volumen pulmonar. En el MIR hay dos

enfermedades intersticiales que debes estudiar y recordar emparejadas, y que puedes recordar como “raras”, aparte de por su baja prevalencia, por varios rasgos diferenciales. Son la Histiocitosis X y la linfangiomiomatosis. Debes recordar que pueden ser obstructivas en lugar de restrictivas, que no debutan con disnea progresiva sino con derrame pleural o neumotorax, que su patrón radiológico es típicamente quístico en vez de reticular, y que no responden a corticoides. La linfangiomiomatosis es una enfermedad propia de mujeres jóvenes, con un importante componente estrogénico, y que condiciona neumotórax y derrames de repetición. Cursa con patrón obstructivo en la espirometría, y con imagen quística de predominio basal en la radiografía (a diferencia de la histiocitosis X, que es apical y noduloquística). Suele dar derrames de tipo quilotorax, por acumulación de linfa, dado que el trastorno primario es una proliferación anormal del músculo liso vascular de los vasos linfáticos. Se asocia a angiomiolipomas, siendo típico el renal. En su patogenia interviene el tono estrogénico; por lo que su tratamiento comprende privación estrogénica e inmunomoduladores como el sirolimus.

24. Pregunta vinculada a la imagen nº 24:

Paciente de 65 años, fumador de 25 paquetes/año, de profesión ingeniero, sin antecedentes de interés. Presenta disnea de esfuerzo progresiva y tos seca desde hace 1 año. A la exploración presenta acropaquias y estertores crepitantes, bilaterales y persistentes, sin otros hallazgos relevantes. La exploración funcional pulmonar únicamente presenta: capacidad de difusión (DLCO, 43% referencia; SaO₂, 94 % en reposo, y 72% al esfuerzo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?:

1. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
2. Fibrosis pulmonar idiopática.
3. Neumonía eosinófila crónica.
4. Alveolitis alérgica extrínseca.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La radiografía de tórax de este paciente también muestra un patrón intersticial, pero a diferencia de la anterior tiene predominio bibasal con imágenes reticulonodulillares y reducción de los campos pulmonares. El paciente muestra la clínica típica de fibrosis pulmonar idiopática. Es una enfermedad de predominio masculino en la 5ª-7ª década, y origen desconocido. Representa en torno al 25- 30% del total de los casos de neumopatía intersticial en nuestro medio. Clínicamente se caracteriza por disnea progresiva, de inicio insidioso, acompañada de tos no productiva. En la exploración destaca la presencia de acropaquias y de crepitantes bibasales rudos, de tipo velcro. En la placa de torax o el CT de alta resolución se encuentra típicamente patrón intersticial reticular o reticulo-nodulillar, junto con extensiones variables de áreas de panalización. En la espirometría es habitual encontrar un patrón restrictivo parenquimatoso, con descenso de todas las capacidades

y volúmenes, presiones inspiratorias y espiratorias conservadas, flujos conservados, y descenso de la capacidad de difusión. Como tiene importante afectación de la difusión, cursan con hipoxemia con el ejercicio físico. En el lavado broncoalveolar se obtienen abundantes polimorfonucleares, y es posible encontrar eosinofilia.

25. Pregunta vinculada a la imagen nº 25:

Una radiografía de tórax con lesiones como las señaladas con flechas en la imagen es bastante típica de:

1. Berilosis.
2. Silicosis.
3. Asbestosis.
4. Talcosis.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Las adenopatías con calcificación en cáscara de huevo son una manifestación muy orientativa pues muy pocas patologías las producen. Concretamente, la silicosis, sarcoidosis y tuberculosis, por lo que su aparición en un caso clínico real o del MIR nos puede dar el diagnóstico de forma directa, como en este caso. De las tres patologías, la que más se asocia a cáscaras de huevo (riesgo relativo) es la sarcoidosis, que es también la menos prevalente. La más prevalente de las tres es la tuberculosis, que es la que menos las produce (menor riesgo relativo). La principal causa a nivel poblacional de adenopatías en cáscara de huevo (riesgo atribuible poblacional) es la silicosis, que de todas formas es la única posible de las ofrecidas.

26. Pregunta vinculada a la imagen nº 26:

Hombre de 85 años de edad con antecedentes de hemorragia cerebral hace 2 años. Ingresó por cuadro agudo de hemiparesia derecha y somnolencia. En el TAC urgente con contraste se objetiva los hallazgos que se muestran en la imagen. El paciente no es hipertenso. ¿Cuál, entre las siguientes, es la etiología más probable de la episodio actual del paciente?:

1. Metástasis.
2. Aneurisma.
3. Angiopatía amiloide.
4. Tóxicos o medicamentos.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La imagen muestra un gran hematoma intraparenquimatoso de localización frontal izquierda. La causa más frecuente de hemorragia cerebral espontánea es la hipertensión y su localización más frecuente es profunda, en ganglios de la base. En pacientes ancianos con hemorragias de repetición y localización lobar siempre hay que pensar en angiopatía amiloide (más aún si presentan demencia).

27. Pregunta vinculada a la imagen n° 27:

En el reconocimiento médico a un hombre de 18 años, de 180 cm de altura y 92 kg. de peso, se descubren los hallazgos físicos y morfológicos de la imagen. El tamaño testicular es de 1,5 cm³. En las pruebas complementarias se confirma una elevación de la LH y la FSH y un azoospermia. ¿Cuál sería la conducta a seguir?:

1. Esperar a que cumpla 21 años y repetir el estudio.
2. Iniciar sin más pruebas un tratamiento con testosterona.
3. Se debería hacer un cariotipo.
4. Determinar la concentración de cloro en el sudor.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

En la imagen se aprecian hombros estrechos, una distribución ginoide de la grasa, ausencia de vello facial y corporal, y ginecomastia. El cuadro clínico describe un proceso de feminización masculina que bien puede ser debido a un exceso de estrógenos (tumores testiculares fundamentalmente) o bien a un defecto de andrógenos. Centrándonos en esta última posibilidad y dado que se trata de un hipogonadismo primario (gonadotropinas altas) las causas que hemos de buscar se han de centrar en el testículo. Los motivos de la insuficiencia gonadal pueden ser alteraciones cromosómicas, disgenesias gonadales, o bien alteraciones moleculares en la producción o en los receptores de testosterona. Dado que lo más común y más fácilmente diagnosticable son las primeras este tipo de estudios suelen comenzar con un cariotipo para excluir por ejemplo que se trate de un síndrome de Klinefelter (XXY).

28. Pregunta vinculada a la imagen n° 28:

En el caso de una paciente de 45 años de edad con historia de 6 meses de evolución, consistente en artritis simétrica que incluye muñecas, rigidez matutina de 2 horas y una radiología simple (se muestra en la imagen) donde se aprecian erosiones en carpo. ¿Cuál de los siguientes hallazgos inmunológicos NO se correlaciona con el cuadro clínico descrito?:

1. Aumento en el compartimento sinovial de factor de necrosis tumoral alfa.
2. Presencia en suero de inmunoglobulinas con efecto anti-inmunoglobulina G.
3. Presencia de HLA-DR6 en la superficie de los linfocitos B presentes en el infiltrado inflamatorio.
4. Aumento en el compartimento sinovial de linfocitos T con marcadores de activación en la superficie.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La radiografía muestra artritis erosiva (erosiones óseas) en los huesos del carpo; fíjase en cómo los espacios articulares se pierden y los huesos del carpo aparecen superpuestos. La presencia de artritis erosiva junto al cuadro clínico presentado es muy sugerente de artritis reumatoide. La etiopatogenia de la AR es desconocida, pero día a día se estudia más el mecanismo fisiopatológico que causa la enfermedad. En esencia, lo que debes saber acerca del infiltrado inflamatorio en el compartimento sinovial es: - el infiltrado inflamatorio de la membrana sinovial está constituido por linfocitos T (predominando los CD4 sobre los CD8), linfocitos B (capaces de diferenciarse a células plasmáticas), fibroblastos, mastocitos y células del estroma. En la liberación de moléculas inflamatorias destacan IL 1, IL 6 y TNF alfa (recuerda que son diana terapéutica de algunos fármacos biológicos que debes estudiar en este tema) - los haplotipos HLA DR 4 y DR1 son los más frecuentes entre los pacientes de AR.

29. Pregunta vinculada a la imagen n° 29:

Una enferma de 55 años presenta dolor intenso en columna lumbar sin trauma o esfuerzo violento previo. Al practicar radiografías se observan los hallazgos de la imagen. ¿Cuál será la causa más frecuente de esta lesión?:

1. Tuberculosis vertebral.
2. Metástasis.
3. Enfermedad de Paget.
4. Infección vertebral.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La imagen muestra un aplastamiento vertebral de una vértebra lumbar, que aparece con forma de cuña con vértice anterior. El dato clave aquí es la ausencia de traumatismo previo. La causa más frecuente de fracturas patológicas (sin traumatismo) múltiples en una mujer postmenopáusica es la osteoporosis. No nos dan esta opción, y teniendo en cuenta que las infecciones vertebrales en occidente son muy raras y que el Paget es poco frecuente, sólo nos quedan los tumores. Recuerda que en el hueso son más frecuentes las metástasis que los tumores óseos primarios. Recuerda también que la fractura osteoporótica más frecuente es la vertebral.

30. Pregunta vinculada a la imagen n° 30:

Enfermo de 70 años que consulta refiriendo la aparición desde hace dos años de las lesiones que aparecen en la imagen, que son asintomáticas y desaparecen espontáneamente en dos o tres semanas. Las lesiones continúan apareciendo desde entonces sin periodicidad fija. El diagnóstico más probable es:

1. Vasculitis leucocitoclástica.
2. Eczema xerodérmico.
3. Angiosarcoma de Kaposi.
4. Púrpura senil.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La imagen muestra lesiones maculosas violáceas en dorso de antebrazos, irregulares y de 1-5 cm de diámetro aproximado; estas lesiones, que son asintomáticas y autolimitadas en pocas semanas, pero que recidivan, constituyen una púrpura senil. Pregunta de dificultad media, que en su día sorprendió mucho y falló la mayoría. En el manual hay un recuerdo dedicado a esta pregunta en el tema 3: la púrpura senil es debida a la fragilidad capilar de los ancianos (por eso aparece en las zonas expuestas a traumatismos: dorso de antebrazos y manos) y no requiere tratamiento ya que es autoinvolutivo. Es más frecuente en pacientes que toman anticoagulantes o que toman corticoterapia. No pueden ser ni eczema xerodérmico ni liquen plano, porque éstos no son asintomáticos; además, tanto el angiosarcoma de Kaposi como la vasculitis dan lesiones sobrelevadas, palpables y no máculas como la púrpura senil.

31. ¿Cuál de las siguientes situaciones no aumenta la poscarga?:

1. Estenosis aórtica.
2. Tromboembolismo pulmonar.
3. Hipertensión arterial.
4. Miocardiopatía hipertrófica.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La poscarga es la tensión o estrés de la pared que sufre determinada estructura (en este caso, los ventrículos), con intención de vencer la resistencia que tienen por delante (aorta o arteria pulmonar) a fin de expulsar la sangre. La estenosis aórtica y la HTA hacen que haya un obstáculo para expulsar la sangre a través del ventrículo izquierdo y que por tanto, aumente mucho la poscarga. Lo mismo ocurre con una embolia de pulmón o en la hipertensión pulmonar pero en el ventrículo derecho. Recuerda que el mecanismo de compensación es la hipertrofia (en el TEP suele cursar con dilatación porque el ventrículo derecho fracasa ante un aumento brusco de la poscarga). La miocardiopatía hipertrófica NO aumenta poscarga (no existe obstrucción fija y continuada al flujo sanguíneo), la hipertrofia está presente por la propia miocardiopatía.

32. Respecto a la Diabetes, señale la correcta:

1. Dentro de la microangiopatía, la cardiopatía isquémica es muy frecuente.
2. El consumo de cannabis es causa de cetoacidosis diabética.
3. Puede haber hipopotasemia con hipernatremia por acidosis tubulorenal tipo IV.
4. No se aconseja el doble trasplante páncreas-riñón por la alta inmunosupresión que precisa.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Aunque la cardiopatía isquémica es frecuente en estos pacientes, es una complicación macro vascular (respuesta 1 falsa). Una de las alteraciones renales que puede sufrir el paciente diabético es una ATR-IV, pero esta cursa con hiperpotasemia e hiponatremia (respuesta 3 falsa). Se aconseja el trasplante de páncreas cuando también se va a hacer de riñón, la inmunosupresión nos sirve para ambos (respuesta 4 falsa). En estudios recientes se ha relacionado el consumo de cannabis con el desarrollo de cetoacidosis diabética (respuesta 2 correcta).

33. ¿Cuál de las siguientes NO es una causa de hipercalcemia?:

1. Hiperparatiroidismo 1º.
2. Hiperparatiroidismo 2º.
3. Ingesta excesiva de vitamina A.
4. Silicosis.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

El hiperparatiroidismo 2º es la elevación de la PTH como consecuencia de una hipocalcemia o de una situación que predispone a hipocalcemia ("hiperparatiroidismo secundario a hipocalcemia"), y por definición NO puede ser una causa de hipercalcemia. Es habitual en la enfermedad renal crónica, donde es frecuente ver hipocalcemia y/o hiperfosfatemia. Cuando un hiperPTH 2º de la enfermedad renal crónica progresa hasta dar hipercalcemia (por excesiva secreción de PTH), deja de considerarse un hiperPTH 2º y pasa a ser un hiperPTH 3º. El resto de opciones si pueden ser causantes de hipercalcemia.

34. La resistencia insulínica no solo implica a rutas metabólicas concretas sino también al funcionamiento integral de ciertas organelas celulares. Tan solo una de las siguientes se ha descrito como factor causal de la resistencia insulínica:

1. Disfunción oxidativa mitocondrial, que empeora la resistencia insulínica al aumentar ácidos grasos libres y ceramidas.
2. Estrés del retículo endoplásmico, que conduce a mal plegamiento de proteínas con disfunción de las ISR.
3. Disfunción de los microtúbulos, que altera la secreción hormonal de insulina.
4. Alteración de la expresión génica a nivel nuclear.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

No se ha descrito disfunción específica de los microtúbulos, aunque sí hay alteración de la secreción de hormonas y neuropéptidos en la resistencia insulínica y diabetes. En la resistencia insulínica se produce secundariamente alteración de la expresión génica (por ejemplo, descenso de la expresión

de GLUT4) y además aparece el llamado “estrés del RE”, que conduce a mal plegamiento proteico, lo que provoca la UPR (“unfolding protein response”) con disminución de la síntesis proteica, aumento de la degradación intraRE y aumento de las chaperonas. La disfunción mitocondrial es a la vez causa y consecuencia de la resistencia insulínica; por una parte cuando hay disfunción mitocondrial aumentan los ácidos grasos libres (que, por ejemplo, activan los receptores TLR2 y TLR4) y las ceramidas (que inhiben la actividad Akt), contribuyendo a la resistencia insulínica, y por otra parte la resistencia insulínica provoca descenso de la biogénesis y función mitocondrial.

35. Una de las siguientes no se corresponde con las neoplasias endocrinas múltiples (MEN), señálela:

1. A todo paciente diagnosticado de carcinoma medular de tiroides se le debe hacer una determinación del protooncógeno RET.
2. El hiperparatiroidismo en el MEN 2-B es frecuente.
3. El prolactinoma es el tumor hipofisario más frecuente en el MEN-1.
4. En los MEN-2 el feocromocitoma suele ser intraadrenal.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

En el MEN 2-B, la presencia de hiperparatiroidismo, aunque es posible, en realidad es muy rara (respuesta 2 incorrecta). En familiares de primer grado con MEN 2-A, 2-B o CMT familiar debe hacerse detección de protooncógeno RET; también se debe hacer a los CMT esporádicos (respuesta 1 correcta) y si éste es positivo obliga al estudio del resto de familiares de primer grado. En el MEN-1 los tumores hipofisarios están presentes en el 50-60% de los pacientes siendo el prolactinoma el más frecuente (respuesta 3 incorrecta) seguido del productor de GH. En los MEN-2 el feocromocitoma suele ser intraadrenal (respuesta 4 incorrecta), lo que hace que se produzca más adrenalina que noradrenalina, por lo que hay menor tendencia a la hipertensión.

36. Respecto al insulinoma, una de las siguientes respuestas es correcta, señálela:

1. Se diagnostica bioquímicamente haciendo una sobrecarga oral de glucosa. Tras su administración se ha de determinar cada 6 horas los niveles de insulina, glucosa y péptido C. El diagnóstico se logra si se objetivan niveles altos de insulina cuando la glucemia es normal.
2. Suelen ser personas con sobrepeso e ingestas elevadas de alimentos diarias.
3. En ocasiones pueden tener diarreas abundantes con deshidratación que puede llevar a alteraciones hidroelectrolíticas y del pH.

4. La mayoría acaban malignizando y causando metástasis, siendo típica la invasión de la vena mesentérica inferior.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

El insulinoma se diagnostica bioquímicamente tras la realización de un test de ayuno de 72 horas, midiendo niveles de insulina, glucosa y péptido C. Se establece el diagnóstico cuando hay niveles elevados de insulina con glucemias bajas (<45 mg/dL) (respuesta 1 falsa). La mayoría son tumores pequeños, únicos, localizados en el páncreas y de crecimiento benigno (respuesta 4 falsa). Por el hiperinsulinismo, las personas aumentan el consumo de alimentos para evitar la hipoglucemia y aumentan de peso (respuesta 2 correcta). La diarrea secretora con deshidratación y alteraciones hidroelectrolíticas y del pH ha de hacernos pensar en un Vipoma (respuesta 3 falsa).

37. La histerectomía radical incluye:

1. Cuerpo y cuello de útero.
2. Parametrios.
3. Tercio superior de vagina.
4. Todas las anteriores.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La histerectomía radical incluye el útero (cuerpo y cuello), los parametrios y un rodete de cúpula vaginal. Es el tipo de histerectomía indicada en los casos de cáncer de cérvix que cumplen criterios de resecabilidad.

38. ¿Qué es cierto sobre los inhibidores de la PARP (olaparib, niraparib)?:

1. Son parte de la quimioterapia neoadyuvante del cáncer de ovario.
2. Están aprobados como tratamiento de mantenimiento sólo en pacientes BRCA mutadas.
3. Bloquean la reparación de las roturas de cadena simple del ADN.
4. Su administración es independiente de la respuesta a platino.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Los iPARP inducen la muerte celular impidiendo la reparación de las roturas de cadena simple del ADN (3 correcta). Están aprobados en pacientes BRCAmut o en su defecto Homologous Recombination deficient (HRd), siempre y cuando haya habido respuesta al menos parcial al platino (2 y 4 falsas). Se administran tras haber finalizado la quimioterapia (1 falsa).

39. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente una diferencia clave entre las

células dendríticas foliculares (FDC) de las células dendríticas interdigitantes (IDC)?:

1. Las FDC presentan antígenos procesados a los linfocitos T, mientras que las IDC presentan antígenos no procesados a los linfocitos B.
2. Las FDC se originan en la médula ósea, mientras que las IDC derivan de células vasculares especializadas.
3. Las FDC están ampliamente distribuidas en todos los tejidos, mientras que las IDC se encuentran sólo en los folículos linfoides.
4. Las células dendríticas interdigitantes, como principales presentadoras de antígenos a los linfocitos T, son clave en la inmunovigilancia contra el cáncer, y su manipulación en vacunas de células dendríticas busca potenciar la respuesta antitumoral al activar eficazmente el sistema inmune adaptativo.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Las células dendríticas interdigitantes actúan como células profesionales presentadoras de antígenos y exponen péptidos procesados en MHC a las células T, mientras que las dendríticas foliculares guardan antígenos intactos en forma de inmunocomplejos y los exponen de forma MHC-independiente a células B. Las IDC son derivados hematopoiéticos, al igual que la gran mayoría de células del sistema inmune, mientras que las FDC presentan un origen mesenquimal. Las FDC están presentes únicamente en el folículo linfoide, capturando y reteniendo antígenos para facilitar la maduración de la afinidad y la selección de linfocitos B con receptores de alta afinidad y regulando las poblaciones de células B de memoria, mientras que las interdigitantes migran por todo el cuerpo recogiendo antígenos y recirculando hasta los órganos linfoides para presentarlos y activar una respuesta inmune adaptativa. La cuarta opción es simplemente definitoria del papel fundamental de las células dendríticas en la presentación de antígenos tumorales, y explica el fundamento de las vacunas de células dendríticas, instiladas en cultivo con mRNA de antígenos tumorales o con extractos proteicos de los mismos, para después ser reintroducidas en el huésped. Sus resultados son limitados hasta la fecha, probablemente por el ambiente inmunosupresor peritumoral, pero su combinación con otros inhibidores de checkpoint ha mostrado resultados prometedores.

40. Respecto a los fármacos inhibidores de los Check points y sus implicaciones en el tratamiento de tumores y distintas enfermedades señale la FALSA:

1. Pembrolizumab y nivolumab se unen de manera selectiva a PD-1 en el linfocito T e impiden la unión con PD-L1 inhibiendo una respuesta Th reguladora.

2. Atezolizumab y avelumab se unen selectivamente a PD-L1 en la célula que presenta el antígeno tumoral inhibiendo su unión con PD-1 y la respuesta Th Reguladora.
3. Dupilumab inhibe la IL-4 y la IL-13 que estimulan la síntesis de IgE.
4. Ipilimumab y tremelimumab se unen selectivamente a CTLA4 en el linfocito T e impiden su unión con CD28 inhibiendo una respuesta Th regulado.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

41. Una mujer de 35 años acude a consulta de consejo genético porque tiene antecedentes familiares de discapacidad intelectual. En su análisis genético se detecta una premutación en el gen FMR1. Se le informa de que sus hijos podrían tener un fenotipo más severo de enfermedad. ¿Qué concepto explica este fenómeno?:

1. Disomía uniparental.
2. Impronta génica.
3. Anticipación.
4. Heteroplasmia.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

El síndrome del X frágil es un ejemplo clásico de anticipación debida a la expansión progresiva de tripletes en sucesivas generaciones. El síndrome del X frágil es una enfermedad ligada al X RECESIVA causada por la expansión del triplete CGG en el gen FMR1. Presenta fenómeno de anticipación que implica la aparición de la enfermedad a edades más tempranas y/o con mayor gravedad en generaciones sucesivas debido a la expansión progresiva de tripletes. Las mujeres con premutación pueden transmitir una mutación completa a sus hijos, sobre todo a los varones quienes presentan mayor afectación clínica (al ser recesiva ligada a X). Las hijas pueden ser portadoras o tener fenotipo variable por inactivación del X (hipótesis de Lyon).

42. Con respecto al proceso de envejecimiento, señale la respuesta correcta:

1. El envejecimiento conlleva una disminución de la producción de células hematopoyéticas en la médula ósea, lo cual supone un descenso en el número de linfocitos T y B naive así como en las proteínas inflamatorias derivadas (interleuquinas, interferón...).
2. El balance nitrogenado negativo en el anciano se compensa fisiológicamente con un aumento de los nitratos.

3. El estado de inflamación crónica es secundario al aumento en la producción de proteínas inflamatorias, así como por la existencia de un endotelio disfuncional.
4. En el envejecimiento el proceso de catabolismo metabólico predomina frente al anabolismo.

Respuesta correcta: 3**Comentario:**

La única respuesta verdadera es la 3. Efectivamente durante el envejecimiento observamos un estado de inflamación crónica debido a que, pese a que existe un descenso en la producción de linfocitos T y B, los productos de dichas células están aumentados (interleuquinas, proteínas inflamatorias, interferón, FNT...), favoreciéndose un estado de inflamación crónica (respuesta 3 verdadera y respuesta 1 falsa). La respuesta 2 es falsa porque aunque en el anciano sí que hay un balance nitrogenado negativo (predomina el catabolismo al anabolismo), esto no tiene nada que ver con los nitratos, que son un vasodilatador generado por el endotelio vascular que también ve reducida su producción debido a la disfunción endotelial. Por último, en los ancianos predomina el efecto catabólico (destrucción proteica) que anabólico (producción proteica) lo cual se debe principalmente a la inmovilización.

43. Una de las siguientes no es una función del riñón:

1. Regulación del equilibrio ácido base.
2. Regulación de la tensión arterial.
3. Regulación de la volemia.
4. Regulación de la presión oncótica.

Respuesta correcta: 4**Comentario:**

Respuesta 4: la presión oncótica viene determinada principalmente por la albumina y su síntesis depende principalmente del hígado. El resto son ciertas.

44. ¿Cuál de los siguientes trastornos tubulares es menos frecuente en paciente con nefritis tubulointersticial aguda?:

1. Descenso en la reabsorción de sodio, bicarbonato, úrico y fósforo en el túbulo contorneado proximal.
2. Aumento de la secreción de potasio y ácido en el túbulo distal.
3. Descenso de la respuesta a vasopresina en el túbulo colector.
4. Descenso de la reabsorción de glucosa y aminoácidos.

Respuesta correcta: 2**Comentario:**

Respuesta 2: En la nefritis tubulointersticial aguda existen grados variables de daño tubular. En todo caso existe una atrofia de las células tubulares por lo que tanto la función de la corteza como de la médula se ven afectadas. En caso de disfunción del túbulo proximal puede aparecer un síndrome

de Fanconi (con glucosuria, aminoaciduria, bicarbonaturia, fosfaturia y síndrome pierde sal). En caso de disfunción del túbulo distal suele verse afectada la excreción de potasio e hidrogeniones por lo que estos pacientes suelen tener una hiperpotasemia desproporcionada respecto al grado de insuficiencia renal (de ahí que la respuesta 2 sea la manifestación menos frecuente, suele haber un descenso en la secreción de potasio). Así mismo dado que hay menor reabsorción de sodio a nivel del asa de Henle y la nefrona distal no se forma el gradiente corticomedular, es decir que se pierde la hipertonicidad medular y por lo tanto la capacidad de respuesta a la vasopresina o ADH es menor.

45. La hipoxemia inducida por el ejercicio en un paciente con normoxemia basal sugiere:

1. Hipoventilación.
2. Alteración de la difusión.
3. Shunt.
4. Intoxicación por CO.

Respuesta correcta: 2**Comentario:**

La hipoxemia en las patologías que alteran la difusión puede estar compensada en reposo, pero con el ejercicio se descompensa.

Esto se debe a que el tiempo de tránsito de la sangre por el capilar pulmonar es de ~0,75 segundos. En una persona sana el O₂ difunde completamente en los primeros 0,25 segundos, por tanto, incluso si la difusión está parcialmente alterada la sangre aún tiene tiempo de captar el O₂ necesario, es por esto que la PaO₂ puede ser normal o casi normal en reposo.

En el ejercicio el tiempo de tránsito capilar se reduce a ~0,25 segundos o menos (porque aumenta el gasto cardíaco). Eso es justo el límite para que el O₂ difunda en condiciones normales. En pacientes con alteración de la difusión, ese proceso ya está ralentizado por lo que no da tiempo a que difunda el O₂ a la sangre. Resultado: la sangre sale del pulmón con menor PaO₂ → hipoxemia inducida por el ejercicio.

46. En la fisiología respiratoria, ¿cuál de los siguientes mecanismos es responsable de la redistribución del flujo sanguíneo pulmonar hacia áreas bien ventiladas durante la hipoxemia?:

1. Vasoconstricción pulmonar.
2. Vasodilatación pulmonar.
3. Hipercapnia.
4. Taquipnea.

Respuesta correcta: 1**Comentario:**

De cara al MIR es importante recordar las características de la circulación pulmonar. Una de las más importantes es la vasoconstricción con la hipoxia, es decir, en condiciones en las que existan unidades alveolares peor ventiladas, el flujo sanguíneo se va a distribuir hacia alveolos mejor ventilados, produciendo una vasoconstricción de los capilares adyacentes a dichas unidades alveolares peor ventiladas.

47. Un varón de 83 años con antecedentes de síndrome coronario crónico revascularizado, fibrilación auricular permanente en tratamiento con apixaban y bisoprolol, bloqueo de rama derecha y estenosis aórtica severa conocida, hasta el momento asintomática, consulta por síncope de esfuerzo. Tras valoración del caso en el Heart-Team se decide implante de prótesis aórtica biológica de forma percutánea (TAVI). Durante el procedimiento presenta bloqueo auriculoventricular completo que persiste tras el mismo, por lo que se decide implantar un marcapasos definitivo. El predictor más importante de bloqueo auriculoventricular completo tras el implante de una TAVI es:

1. El bloqueo de rama derecha previo.
2. Padecer síndrome coronario crónico.
3. Ser tomador de betabloqueante.
4. Fibrilación auricular.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Por la localización de la válvula aórtica, al implantar una válvula de manera percutánea que “inflamamos” con balón se pueden lesionar las estructuras adyacentes (en este caso, la rama izquierda del haz de His). Por eso es bastante frecuente la aparición de bloqueo de rama izquierda tras el implante de TAVI, que puede ser reversible o definitivo. Si el paciente ya tenía bloqueo de rama derecha, y si lesionamos la rama izquierda, el paciente no podrá transmitir la electricidad desde las aurículas a los ventrículos por ninguna vía, produciéndose el bloqueo AV completo, por lo que sabemos que es el mayor predictor de BAV completo tras el implante de TAVI.

48. Si un contraste de hipótesis con un nivel de significación α ha llevado al rechazo de la hipótesis nula, ¿qué interpretación positiva se puede hacer?:

1. Se ha evitado cometer un error de tipo II con una probabilidad de $(1-\beta)$.
2. Se ha encontrado evidencia estadística a favor de la hipótesis alternativa, con una probabilidad de error de α al rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera.
3. La probabilidad de que la hipótesis nula sea verdadera es $(1-\alpha)$.
4. Podemos decir que la potencia estadística $(1-\alpha)$ ha sido suficiente para aceptar la hipótesis alternativa.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Cuando se rechaza la hipótesis nula con un nivel de significación α , esto implica que la probabilidad de haber observado los datos si la hipótesis nula fuera cierta es menor que α . Por lo tanto, se considera que hay evidencia

estadística suficiente para favorecer la hipótesis alternativa; respuesta 2 correcta. El resto de opciones son incorrectas. $(1-\beta)$ representa la potencia estadística, que es la probabilidad de rechazar correctamente una hipótesis nula falsa (en el manual tenéis la fórmula “potencia + beta = 1”). El error de tipo II ocurre cuando no se rechaza una hipótesis nula que es falsa, y nuestra decisión actual ya es un rechazo. Haber rechazado la hipótesis nula no implica necesariamente que se haya evitado cometer un error de tipo II. $(1-\alpha)$ representa el nivel de confianza, que está relacionado con la probabilidad de que un intervalo de confianza contenga el verdadero parámetro poblacional, pero no es la probabilidad de que la hipótesis nula sea verdadera después de realizar la prueba. La respuesta 4, como hemos dicho antes, es falsa porque la potencia estadística de un estudio se define como $(1-\beta)$, no $(1-\alpha)$.

49. La probabilidad pretest de una determinada enfermedad es muy elevada. ¿Cuál de los siguientes parámetros aumentará en mayor medida?:

1. Sensibilidad.
2. Especificidad.
3. Valor Predictivo Negativo.
4. Valor Predictivo Positivo.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Recordad, en el MIR probabilidad pre-test = prevalencia de la enfermedad en la población. A mayor Prevalencia mayor VPP y menor VPN. La sensibilidad y especificidad (parámetros intrínsecos del test) no se modifican con la prevalencia de enfermedad.

50. El Número Necesario de pacientes a Tratar (NNT) es un concepto que hace referencia a la eficacia de un fármaco. A mayor NNT:

1. Mayor eficacia del fármaco.
2. Menor eficacia del fármaco.
3. Mayor efectividad del fármaco.
4. Menor efectividad del fármaco.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

NNT: número necesario de pacientes a tratar $(100/\text{RAR})$. Cuanto mayor sea el NNT, más pacientes tengo que tratar para curar a uno, luego menor eficacia del fármaco. No podemos hablar de efectividad, sino de eficacia.

51. Existe confusión acerca del tratamiento de una enfermedad. Como a menudo ocurre en medicina, no se sabe bien cuál es el mejor tratamiento, así que hay muchas opciones. El ibuprofeno es el más empleado, pero un grupo de investigadores quiere comparar también la amitriptilina y el tapentadol. Para ello quieren hacer una síntesis estadística de la evidencia

disponible, pero se encuentran con el siguiente problema: solo existen estudios que comparen directamente la amitriptilina con el ibuprofeno y el tapentadol con el ibuprofeno, pero ninguno compara la amitriptilina con el tapentadol. ¿Qué deben hacer los investigadores?:

1. Un metaanálisis en red.
2. En estos casos, no queda otra opción que hacer un ensayo clínico o un estudio observacional para hacer la comparación.
3. Solo podrán hacer una revisión sistemática e indicar la necesidad de ulterior investigación.
4. Una solución a dicho problema es la realización de un test de Kolmogórov-Smirnov.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

El metaanálisis en red se emplea clásicamente cuando se quiere comparar mediante un metaanálisis dos tratamientos que no se han comparado directamente en la literatura. Por ejemplo, si se quiere comparar un tratamiento B con un tratamiento C, pero en la literatura solo hay estudios que comparan los tratamientos A-B y A-C, se puede hacer un metaanálisis en red (network), que incluye toda la "red" de estudios, y hacer no solo las comparaciones directas que se han publicado, sino también comparaciones indirectas (B-C, en este caso) e incluso mixtas. El test de Kolmogorov-Smirnov se utiliza para determinar si una variable sigue una distribución normal: compara la distribución de la variable con la normal y hace un contraste de hipótesis. Si el resultado es significativo ($p < 0,05$), la variable no sigue una distribución normal. No tiene nada que ver con el enunciado, está para despistar.

52. En un estudio de cohortes, se estudia la asociación entre el consumo de bebidas energéticas y fibrilación auricular, y se obtiene un $RR=2$. No obstante, se cree que el consumo de alcohol puede ser una fuente de sesgo, por lo que se realiza un análisis estratificado de los resultados según el consumo de alcohol. En el grupo de consumidores de alcohol, se observa un $RR=3$, mientras que en el grupo de abstemios se observa un $RR=1,3$. Señale la respuesta CORRECTA:

1. Se trata de un sesgo por factor de confusión.
2. Es posible corregir el sesgo mediante un análisis multivariante.
3. El alcohol y el consumo de bebidas energéticas tienen un efecto aditivo sobre el riesgo de fibrilación auricular.
4. Se debe repetir el estudio, con una correcta aleatorización que minimice el riesgo de volver a incurrir en el presente sesgo.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Se trata de un sesgo de selección, causado por un factor modificador del efecto (FME). Se trata de una variable en la que se diferencian los dos grupos de estudio y que altera el resultado del mismo. Al igual que el sesgo por factor de confusión (FC), puede detectarse a posteriori mediante un análisis estratificado. En el caso del FME, como su propio nombre indica, veremos que el RR en el grupo expuesto y no expuesto es diferente: el efecto del factor de riesgo que estudiamos se modifica por el FME. Esto ocurre porque tiene un efecto sinérgico o anérgico, pero no aditivo con el factor de riesgo a estudio (no es simplemente la suma de ambos efectos). A diferencia del sesgo por FC, el sesgo por FME no puede corregirse a posteriori. Es necesario repetir el estudio y hacer una buena aleatorización para minimizar las posibilidades de que ocurra.

53. Un hombre de 52 años con antecedentes de trasplante renal hace 5 años, en tratamiento con tacrolimus y micofenolato de mofetilo, consulta por debilidad progresiva en extremidades derechas, disartria y alteración cognitiva de un mes de evolución. La resonancia magnética cerebral muestra lesiones desmielinizantes multifocales sin realce ni efecto de masa, y en el LCR se detecta un virus JC por PCR en títulos elevados. Se establece el diagnóstico de leucoencefalopatía multifocal progresiva (LMP). Ante la falta de alternativas terapéuticas y la progresión neurológica del paciente, ¿cuál sería el siguiente paso más adecuado en su manejo?:

1. Suspender tratamiento inmunosupresor y administrar ganciclovir.
2. Iniciar plasmaféresis para eliminar la inmunosupresión y considerar inhibidores de PD-1.
3. Agregar aciclovir y continuar el tratamiento inmunosupresor.
4. Administrar inmunoglobulina intravenosa y antibióticos de amplio espectro.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La LMP ocurre por reactivación de virus JC en pacientes inmunosuprimidos. No hay tratamiento antiviral eficaz por lo que la estrategia clave es restaurar la respuesta inmune. Se ha propuesto el uso de inhibidores de PD-1 (pembrolizumab, nivoluman) para potenciar la inmunidad antiviral en casos avanzados de LMP sin otra opción terapéutica. Ganciclovir y aciclovir no tiene actividad anti JC.

54. Acude a Urgencias un varón de 24 años con mal estado general tras emplear un AINE ante un episodio de cefalea tensional. La tensión arterial a su llegada a urgencias es 103/65mmHg, la frecuencia cardíaca es 112lpm, la SatO2: 94%

con 24rpm. En la exploración destacan lesiones maculopapulares pruriginosas, espiración alargada y sibilancias dispersas. El paciente refiere haber presentado un cuadro similar hace años. Señale la respuesta FALSA respecto a la entidad que sospecha y su manejo:

1. El tratamiento de elección es adrenalina intramuscular (0,01mg/kg en niños o 0.3-0.5mg en adultos) pudiendo repetirse su administración hasta 3 veces.
2. Debe solicitarse una determinación de triptasa sérica a la hora y otra a las 4-6 horas para confirmar el diagnóstico con su curva de descenso.
3. Dado el curso bifásico de la reacción anafiláctica se recomienda observación hospitalaria de al menos 8 horas.
4. Los fármacos ayudantes incluyen broncodilatadores de acción corta, corticoides sistémicos y antihistamínicos.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Nos presentan un caso de anafilaxia / shock anafilático. El tratamiento de elección es adrenalina intramuscular a dosis de 0,01mg/kg en niños y 0.3-0.5mg en adultos pudiendo repetirse su administración hasta 3 veces (1 correcta). En caso de refractariedad puede considerarse el empleo de una perfusión de adrenalina en la UCI. Los fármacos ayudantes incluirán broncodilatadores de acción corta en caso de broncoespasmo, corticoides sistémicos y antihistamínicos (4 correcta). Debe solicitarse una determinación de triptasa sérica a la hora y otra a las 4-6 horas para confirmar el diagnóstico con su curva de ascenso (2 falsa). Dado el curso bifásico de la reacción anafiláctica se recomienda observación hospitalaria de al menos 8 horas.

55. Con relación a la pneumonitis inmunomediada como complicación del uso de inhibidores de checkpoint inmunológicos, señale la FALSA:

1. La incidencia es mayor en pacientes fumadores.
2. Los principales síntomas son tos no productiva y disnea, siendo la sospecha clínica suficiente para iniciar el tratamiento inmunosupresor.
3. El 25% de los casos no se visualizan en radiografía de tórax, por lo que en caso de sospecha es preciso realizar un TC torácico.
4. Su patrón radiológico más frecuente es el de neumonía organizada, con opacidades en vidrio deslustrado de distribución periférica o perilobar, con signo del halo inverso y distribución multifocal asimétrica.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Es fundamental descartar mediante todas las pruebas necesarias la etiología infecciosa, siendo recomendada

la realización de broncoscopia, pues de lo contrario el tratamiento inmunosupresor podría agravar severamente la evolución del cuadro. La incidencia es mayor en pacientes con enfermedad pulmonar preexistente, edad avanzada (>65 años), tabaquismo activo, radioterapia torácica previa. El patrón radiológico más frecuente en TC de tórax es el de neumonía organizada, siendo otros como la NIU mucho más raros.

56. Un paciente fumador de 52 años consulta en Urgencias por episodios de dolor torácico en reposo (no relacionados con los esfuerzos), mal definidos y no irradiados. El ECG no muestra alteraciones y los marcadores de daño miocárdico no están elevados. No presenta otros factores de riesgo cardiovascular. Es valorado por la Unidad de Dolor Torácico que toma la siguiente decisión:

1. Solicitar coronariografía directa.
2. Solicitar ergometría convencional.
3. Solicitar angioTAC de arterias coronarias.
4. Solicitar ecocardiograma de estrés físico.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Nos presentan un paciente con dolor torácico de riesgo intermedio-bajo (15-50%, aproximadamente), ya que es fumador pero los dolores son atípicos (en reposo). En este escenario lo ideal sería realizar una prueba anatomía no invasiva, es decir, el TAC de arterias coronarias (coronariografía no invasiva). Reservaremos los test de detección de isquemia para aquellos episodios de dolor con probabilidad intermedia-alta (ecocardiograma de esfuerzo, gammagrafía de perfusión miocárdica o RM de estrés farmacológico). Si la sospecha fuera muy alta (>85%), directamente coronariografía para ver la anatomía y decidir si tratar o no en función del número de lesiones coronarias y su anatomía. Recuerda que la prueba de esfuerzo convencional o ergometría simple NO se recomienda actualmente para detectar isquemia por su baja sensibilidad y especificidad. .

57. ¿En qué paciente sospecharía usted de la presencia de amiloidosis con afectación cardíaca?:

1. Varón de 85 años con hipertrofia ventricular severa, voltajes elevados en ECG sin trastornos de la conducción y ausencia de hipertensión arterial.
2. Mujer de 78 años ingresada por primer episodio de insuficiencia cardíaca, FA de reciente diagnóstico, bajos voltajes en derivaciones de miembros y patrón de pseudoinfarto anterior (QS en V1-V3).
3. Varón de 45 años con enfermedad renal crónica, afectación neurológica y manchas rojo cereza en la zona del bañador.

4. Mujer de 65 años que tras un disgusto emocional presenta dolor torácico y en ECG presenta ondas T negativas profundas simétricas en prácticamente todas las derivaciones. En el ecocardiograma destaca una acinesia apical extensa.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La amiloidosis es una enfermedad sistémica por depósito de amiloide en diferentes órganos. La amiloidosis con afectación cardíaca es mayoritariamente por depósito de amiloide-TTR (transtirretina), mientras que como segunda etiología se encuentra la amiloidosis AL o de cadenas ligeras. Como consecuencia de la infiltración de amiloide las paredes se vuelven gruesas, con restricción en la diástole y en estadios finales dilatación y FEVI reducida, aunque no es lo característico. Es habitual encontrar voltajes bajos en el electrocardiograma (el miocardio se ve infiltrado por amiloide y este último no se despolariza, es acelular) y como consecuencia del depósito del amiloide en las válvulas y sistema de conducción cardíaco estenosis valvular (fundamentalmente aórtica) y alteraciones de la conducción (BAV, FA, bloqueos de rama.). La opción 1 es compatible con una miocardiopatía hipertrófica, la opción 3 con la Enfermedad de Fabry y la opción 4 con un Síndrome de Tako-Tsubo.

58. En un recién nacido con cianosis, corazón ovalado en radiografía de tórax que debe tratarse inicialmente con infusión de prostaglandinas y atrioseptostomía tipo Rashkind hasta la corrección definitiva debemos pensar que se trata de:

1. Tetralogía de Fallot.
2. Truncus arterioso.
3. Transposición de grandes vasos.
4. Ductus arterioso persistente.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Nos describen una transposición de grandes vasos, que precisa mantener abierto el ductus arterioso y realizar una atrioseptostomía de Rashkind para mejorar la oxigenación de la circulación sistémica. Recuerda que el corazón ovalado en la radiografía de tórax se asocia a transposición de grandes vasos, el de "zueco" a tetralogía de Fallot y el de muñeco de nieve a drenaje pulmonar venoso anómalo total.

59. El tratamiento de elección en pacientes con taquicardia ventricular polimorfa en contexto de QT largo (Torsades de Pointes) de presentación incesante es:

1. Sulfato de magnesio.
2. Betabloqueantes de corta duración.
3. Amiodarona.
4. Flecainida.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

La taquicardia ventricular polimórfica en contexto de QT largo (Torsades de Pointes) se trata con magnesio IV y corrigiendo las situaciones que provocan la prolongación del QT (hipomagnesemia, hipocalcemia, hipopotasemia; bradicardia, fármacos, isquemia.).

60. Además del ácido acetilsalicílico, el segundo antiagregante de elección tras un síndrome coronario agudo en un paciente con alto riesgo hemorrágico es:

1. Tirofiban.
2. Clopidogrel.
3. Prasugrel.
4. Ticagrelor.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La evidencia actual es a administrar en el contexto de un síndrome coronario agudo (SCA) el primer antiagregante (AAS), y esperar administrar el segundo hasta ver la anatomía coronaria y decidir estrategia de revascularización, normalmente se administra el segundo antiagregante en la propia sala de hemodinámica. De elección es el prasugrel, en segundo lugar el ticagrelor (cuando el prasugrel está contraindicado por edad >75 años, peso <60kg o antecedente de ictus de cualquier tipo). Dejaremos el clopidogrel para aquellos pacientes con alto riesgo hemorrágico, ya que de los segundos antiagregantes es el menos potente. Recuerda que un SCA tratado de forma conservadora también debe ir con doble antiagregación, pudiendo utilizarse ticagrelor o clopidogrel, este último si el riesgo hemorrágico es alto (que suele serlo en aquellos pacientes que por fragilidad se decide estrategia conservadora).

61. Anciano de 91 años con antecedentes de fibrilación auricular permanente, hipertensión arterial y hernia de hiato que es trasladado por sus familiares a Urgencias por síncope mientras estaba sentado. En el ECG presenta fibrilación auricular bloqueada a 35lpm, con escape de QRS ancho, sin datos de isquemia en curso. No toma ningún fármaco más que omeprazol y amlodipino, presenta fracaso renal agudo sin diselectrolitemia. En el ecocardiograma presenta FEVI conservada y sin valvulopatías significativas. ¿Cuál es la actitud más adecuada?:

1. Implante de marcapasos definitivo VVI.
2. Iniciar isoproterenol en perfusión continua y valorar si presenta mejoría del ritmo. En caso de recuperación del mismo, alta a domicilio.
3. Implante de marcapasos definitivo DDD.
4. Administrar sueroterapia para corregir el fracaso renal, ya que éste sea probablemente el motivo del bloqueo auriculoventricular y por lo tanto es una causas potencialmente reversible.

Respuesta correcta: 1**Comentario:**

Nos presentan un paciente con FA bloqueada (FC lenta y regular, recuerda que la FA es siempre irregular salvo que haya BAV completo), sintomática. No hay evidencia de alteraciones potencialmente reversibles, por lo que tiene indicación de marcapasos definitivo. Entre el monocameral (VVI) o bicameral (DDD), nos decantaremos por el primero, ya que no tiene sentido estimular la aurícula en un paciente que tiene FA permanente (nunca conseguiremos capturar la aurícula, está en FA). Por ello, estimulando al paciente desde el ventrículo derecho conseguiremos evitar frecuencias lentas y que no esté sintomático.

62. Un paciente de 68 años presenta insuficiencia cardíaca congestiva con FEVI conservada en relación a estenosis aórtica severa. Presenta un diámetro de aorta ascendente de 48mm. En la coronariografía prequirúrgica se objetiva una lesión severa en la descendente anterior media. El caso se presenta en Heart-Team, decidiéndose:

1. Implante de un stent farmacoactivo en la descendente anterior media y posteriormente cirugía para recambio valvular aórtico con prótesis aórtica biológica.
2. Cirugía de revascularización coronaria con arteria mamaria interna, sustitución valvular aórtica con válvula biológica y sustitución de aorta ascendente.
3. Implante de un stent farmacoactivo en la descendente anterior media y posteriormente cirugía para recambio valvular aórtico con prótesis aórtica mecánica.
4. Cirugía de revascularización coronaria con arteria mamaria interna y sustitución valvular aórtica con válvula mecánica.

Respuesta correcta: 2**Comentario:**

Paciente con estenosis aórtica severa sintomática (insuficiencia cardíaca) que precisa sustitución valvular aórtica (SVAo). Asumiendo un riesgo quirúrgico bajo y edad <75 años, irá para cirugía y no para TAVI. Además, presenta una dilatación de aorta ascendente de >45mm, por lo que en pacientes con cirugía sobre la válvula aórtica en este escenario requieren recambio de la porción aneurismática en el mismo tiempo. Además, como en la coronariografía prequirúrgica presenta enfermedad coronaria, la trataremos también quirúrgicamente, aunque se pudiera tratar percutáneamente. Recuerda que actuaremos sobre la dilatación de raíz de aorta o aorta ascendente si tiene más de 55mm (>52mm si riesgo quirúrgico bajo), en aquellos que vayan a someterse a cirugía cardíaca que no afecte a la válvula aórtica si mide >50mm o si mide >45mm y vamos a intervenir la válvula aórtica).

63. En la evaluación inicial del síncope, no se debe realizar:

1. Electrocardiograma de 12 derivaciones.
2. Test de ortostatismo si la sospecha es de síncope ortostático.
3. Test de mesa basculante.
4. Anamnesis detallada.

Respuesta correcta: 3**Comentario:**

Lo fundamentan en la evaluación del síncope es la anamnesis. Entre las pruebas iniciales no se encuentra la mesa basculante (la utilizaremos en caso de dudas o cuando queramos saber el mecanismo exacto del síncope). Es una prueba con baja especificidad.

64. ¿Cuál de las siguientes circunstancias debe hacernos en un paciente descartar la candidatura a trasplante cardíaco?:

1. Hipertensión pulmonar con resistencias vasculares pulmonares no elevadas.
2. Enfermedad arterial periférica severa.
3. Enfermedad renal crónica estadio 3A.
4. Infección por VIH.

Respuesta correcta: 2**Comentario:**

La enfermedad arterial periférica severa es una contraindicación absoluta para el trasplante cardíaco. La infección por VIH es una contraindicación relativa hoy en día (ten en cuenta que el paciente necesitará tratamiento inmunosupresor), pero no una contraindicación absoluta. La enfermedad renal crónica no severa está presente en la mayoría de los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada (síndrome cardiorenal). El tener una resistencias pulmonares elevadas puede contraindicar el trasplante ya que el ventrículo derecho recién implantado fracasará por el aumento brusco de la poscarga que padecerá.

65. En una paciente con colelitiasis y síntomas de colecistitis aguda, ¿cuál es el hallazgo más típico en la ecografía?:

1. Vesícula colapsada.
2. Engrosamiento de la pared vesicular >3 mm.
3. Dilatación del colédoco.
4. Hepatomegalia.

Respuesta correcta: 2**Comentario:**

El hallazgo más típico en una colecistitis es el engrosamiento de la pared vesicular >3 mm. La vesícula se suele ver distendida y no colapsada. La dilatación del colédoco no es típica de la colecistitis y suele aparecer cuando existe colangitis asociada a la misma. La hepatomegalia tampoco es un hallazgo típico de la colecistitis.

66. Una de las siguientes enfermedades no se asocia con malabsorción de hierro. Señale cuál:

1. Gastritis atrófica.
2. Cirugía bariátrica.
3. Enfermedad celíaca.
4. Diverticulosis.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

El hierro se absorbe en el duodeno y la parte proximal del yeyuno. Las patologías que afectan a la mucosa intestinal o reducen la superficie de absorción, como la enfermedad celíaca o la cirugía bariátrica, pueden causar malabsorción de hierro. El hierro ferroso se absorbe mejor cuando el medio es ácido; la hipoclorhidria de la gastritis atrófica puede causar su malabsorción por este motivo. La diverticulosis no es causa de malabsorción de hierro.

67. Paciente sin antecedentes de interés ingresa con un primer episodio de pancreatitis aguda leve. La ecografía abdominal solicitada al ingreso no muestra hallazgos de interés. El paciente niega consumo de alcohol, fármacos u otros tóxicos. ¿Cuál es la causa más probable del cuadro clínico?:

1. Alcohol.
2. Litiasis biliar.
3. Páncreas divisum.
4. Fibrosis quística.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta aparentemente tramposa, pero bajo la cual subyace un concepto importante. La causa principal de la pancreatitis aguda es la litiasis, seguida en segundo lugar del consumo de alcohol. Tanto es así que, ante un estudio inicial negativo y descartadas razonablemente otras opciones, el nivel de sospecha de un falso negativo de la ecografía tiene que ser muy alto. Con frecuencia, una prueba de imagen avanzada (ecoendoscopia o colangioRMN, según disponibilidad) mostrará microlitiasis que no se habían visto en la ecografía.

68. Varón de 63 años, fumador, con pérdida de peso y dolor epigástrico irradiado a dorso. TC abdominal muestra una masa en la cabeza pancreática, con contacto <180° con arteria mesentérica superior y sin metástasis. ¿Qué técnica es más útil para completar el estadiaje local antes de decidir resecabilidad?:

1. CPRE.
2. PET-TC.
3. Ecoendoscopia (USE).
4. Resonancia magnética.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La ecoendoscopia (EUS) permite evaluar con precisión el contacto vascular y realizar punción para confirmar malignidad. Es clave en el estadiaje local del cáncer de páncreas.

69. La clasificación que se utiliza para clasificar endoscópicamente al esófago de Barret es:

1. Clasificación de París.
2. Clasificación de Praga.
3. Clasificación de los Ángeles.
4. Clasificación de Forrest.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La clasificación que se utiliza para clasificar el Barret de manera endoscópica es la de Praga que se basa en dos mediciones principales: .

C: extensión circunferencial de la metaplasia (en centímetros).

M: extensión máxima de la metaplasia, incluyendo las lengüetas más allá de la extensión circunferencial (en centímetros). La clasificación de París se utiliza en endoscopias para caracterizar pólipos y lesiones cancerosas del tubo digestivo. La clasificación de los Ángeles es la clasificación endoscópica de la esofagitis péptica y la de Forrest de la úlcera péptica.

70. En la clasificación Chicago IV de los trastornos motores esofágicos, se incluye la medida de la integral de la relajación de presiones (IRP) que evalúa la relajación de la unión esofagogástrica. Respecto a esta medida, es cierto:

1. En la acalasia el IRP suele ser superior a 15 mmHg.
2. El esófago hipercontráctil se caracteriza por un IRP superior a 15 mmHg.
3. Los trastornos de obstrucción al flujo de salida de la unión esofagogástrica cursan con IRP normal.
4. La acalasia tipo III se caracteriza por un IRP patológico, asociado a una ausencia de peristalsis y presurización panesofágica en ≥ 20% de las degluciones.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Con los avances continuos en las técnicas manométricas, las clasificaciones de los TME (trastornos motores esofágicos) han ido evolucionando. Chicago v.4.0. engloba a todos los TME en dos categorías principales: .

- Trastornos del flujo de salida de la UEG: todos ellos tienen en común una IRP aumentada (>15 mmHg), diferenciándose en la presencia o no de peristalsis conservada. Distinguimos dentro de este grupo la acalasia y la obstrucción funcional de la UEG.

- Trastornos de la peristalsis: en estos casos, la IRP será normal porque no existe una alteración en la relajación del EEI, y según la patología, habrá diferencias en el resto de índices. En esta categoría se encuentran la ausencia de peristalsis, espasmo esofágico distal, esófago hipercontráctil y motilidad esofágica inefectiva.

De todos los TME, para el MIR, el de mayor importancia es la acalasia, en la que además de una IRP >15 mmHg,

se produce un fallo en la peristalsis. Diferenciamos 3 tipos según la anomalía en la peristalsis .

-- Tipo I: presenta aperistalsis o peristalsis fallida en el 100% de las degluciones (DCI <100 mmHg/seg/cm), sin presurización.

-- Tipo II: peristalsis fallida en el 100% de las degluciones, y presencia de presurización panesofágica en $\geq 20\%$ de las degluciones.

-- Tipo III: aperistalsis y presencia de contracciones prematuras y simultáneas en $>20\%$ de las degluciones (LD <4.5 seg), con contractilidad normal (DCI > 450 mmHg/seg/cm).

71. Ante un paciente séptico con hallazgo de coledocolitiasis múltiple en la ecografía abdominal realizada en Urgencias, debemos solicitar:

1. Colangiorresonancia magnética.
2. Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica.
3. Ecoendoscopia terapéutica.
4. Interconsulta a Cirugía para valoración de colecistectomía.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta fácil. La ecoendoscopia y la colangioRMN son dos opciones excelentes para la detección de litiasis biliar por su mayor sensibilidad, pero no permiten drenaje del colédoco. Dado que la ecografía ha sido concluyente, no nos ayudan en este caso. La CPRE es la maniobra terapéutica que nos va a proporcionar drenaje de la vía biliar y control la sepsis biliar. La colecistectomía es una excelente idea en este paciente una vez controlada la sepsis, con el objetivo de evitar la recurrencia, pero no tiene papel en el control del cuadro actual.

72. Un paciente de 73 años, anticoagulado por una FA, acude al servicio de Urgencias por hematoquecia abundante y malestar general. A su llegada las constantes vitales son TA 90/65 y FC 110 lpm, con recuperación rápida tras reposición de volemia con 1000 cc de suero salino. Se realiza un angioTC como primera exploración en Urgencias, el cual no logra identificar el origen del sangrado. Señale la actitud más adecuada a tomar a continuación:

1. Transfusión sanguínea hasta lograr Hb 9 mg/dl.
2. Colonoscopia urgente.
3. Gastroscopia urgente.
4. Embolización.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Recuerda este caso clínico como el paradigma del paciente que puede beneficiarse de una gastroscopia ante una hemorragia digestiva de presentación en forma de HDB: presentación con inestabilidad hemodinámica, con

reestabilización posterior, y ausencia de hallazgos en el angioTC. No se puede indicar embolización si el angioTC no ha logrado identificar el punto de sangrado. En cuanto a la colonoscopia, no existe evidencia que demuestre un mejor resultado cuando se realiza urgente, por lo que cuando se realiza se hace a lo largo del ingreso, de manera no urgente y siempre previa preparación adecuada.

73. Una paciente de 48 años acude a urgencias por hematemesis, a la cual asiste como médico de urgencias. Tras canalizar 2 vías venosas periféricas y asegurar un adecuado estado hemodinámico de la paciente, instaura tratamiento farmacológico con inhibidores de la bomba de protones. Tras comentar el caso con el gastroenterólogo de guardia, se indica administrar eritromicina intravenosa, con la siguiente finalidad:

1. Prevención de infecciones relacionadas con la traslocación bacteriana como la peritonitis bacteriana espontánea.
2. Por su efecto hemostático sobre la mucosa del aparato digestivo.
3. Para mejorar los resultados de la endoscopia digestiva alta por su efecto procinético.
4. Por su efecto vasoactivo para mantener estabilidad hemodinámica.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La eritromicina, a pesar de ser un antibiótico de la familia de los macrólidos, se utiliza en casos de hemorragia digestiva alta grave por su efecto procinético, ya que aclara la sangre en la cámara gástrica y permite visualizar la causa del sangrado con mayor claridad cuando se administra previamente a una endoscopia digestiva alta.

74. En relación con los efectos adversos de las tiopurinas, señale la opción correcta:

1. La pancreatitis inducida por tiopurinas es un efecto adverso dosis-dependiente.
2. Las molestias digestivas son efectos adversos raros en este grupo de fármacos.
3. La presencia de algunos polimorfismos en la enzima tiopurina metiltransferasa incrementa el riesgo de mielosupresión.
4. Las neoplasias cutáneas asociadas a tiopurinas suelen ser melanomas.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Las tiopurinas (fundamentalmente azatioprina y 6-mercaptopurina) son inmunosupresores ampliamente utilizados en la enfermedad inflamatoria intestinal como tratamiento de mantenimiento. Producen algunos eventos adversos: efectos adversos idiosincrásicos como molestias gastrointestinales (lo más frecuente) o la pancreatitis

aguda, otros dosis-dependiente como la mielosupresión (especialmente si hay un polimorfismo genético de la enzima tiopurina metiltransferasa; obliga a realizar analíticas seriadas) y tumores (neoplasias de piel no melanoma, neoplasias hematológicas).

75. Mujer de 19 años que acude urgencias por dolor abdominal de 48 horas de evolución en FID y fiebre. La paciente ha sido operada de apendicitis aguda perforada hace 11 días . Durante la cirugía se observó una perforación de la base del apéndice y una gran cantidad de pus en la fosa iliaca derecha. A la exploración la paciente tiene dolor en el punto de Mcburney y tiene picos de fiebre de 38,5. Las heridas no tienen signos de flogosis ¿Cuál es el diagnóstico más probable?:

1. Apendicitis del muñón.
2. Plastrón apendicular.
3. Absceso postquirúrgico.
4. Enfermedad inflamatoria pélvica.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta de dificultad moderada del tema de apendicitis aguda. La complicación más frecuente después de una apendicetomía son la infección de las heridas quirúrgicas, sin embargo la complicación sobre la que más tenemos que advertir a los pacientes y tener un alto grado de sospecha es el absceso después de la apendicetomía. Este suele aparecer tras operar apendicitis evolucionadas como la de la paciente. Además presenta una clínica típica: Paciente que es dada de alta con buen estado y a los 10-15 días empieza con un dolor similar al de la apendicitis (Como si no la hubiesen operado) y fiebre. La primera prueba tras la exploración, la analítica y la alta sospecha es una ecografía o TAC para confirmar el diagnóstico. En caso de confirmarlo hay que medir el absceso porque los de más de 5 cm se benefician de ser drenados. Una vez confirmado el absceso y haya o no que drenarlo que hay que hacer es pautar antibióticos intravenosos de amplio espectro sino tenemos antibiograma previo e ingresar al paciente unos días hasta confirmar mejoría analítica y radiológica. .

76. Mujer de 40 años sin antecedentes médicos de interés acude a consulta por dolor anorrectal persistente de varios meses de evolución. Refiere dolor sordo, no relacionado con la defecación, que empeora al estar sentada y mejora al caminar. No presenta rectorragia ni secreción. A la exploración física se evidencia dolor a la palpación profunda del músculo puborrectal y elevador del ano. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?:

1. Proctalgia fugax.
2. Dolor anorrectal crónico.
3. Neuralgia del pudendo.
4. Síndrome del elevador del ano.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Clásico cuadro clínico de dolor funcional del suelo pélvico, concretamente del síndrome del elevador del ano, caracterizado por dolor profundo y sordo que empeora al estar sentado y mejora al caminar. La exploración física muestra dolor a la palpación del músculo elevador del ano. A diferencia de la proctalgia fugax, este dolor no es paroxístico y de segundos de duración, sino persistente. La neuralgia del pudendo también cursa con dolor al sentarse, pero con características urentes, afectación genital y disfunción urinaria o sexual. El diagnóstico es clínico, apoyado por exploración y, en casos complejos, manometría o bloqueo diagnóstico.

77. Paciente de 76 años con antecedentes personales de dislipemia, infarto agudo de miocardio y diabetes mellitus tipo 2, con cirrosis hepática de origen alcohólico con un MELD 17 que ha precisado 6 paracentesis evacuadoras en los últimos 3 meses, sin episodios de encefalopatía hepática previos ni otras descompensaciones. En analítica de rutina destaca una hipertrigliceridemia de 300 mg/dl y un proBNP de 6000 pg/ml. En este escenario ¿cuál sería el mejor tratamiento para nuestro paciente?:

1. Trasplante hepático.
2. TIPS (prótesis intrahepática percutánea transyugular).
3. Paracentesis evacuadoras.
4. TIPS como puente al trasplante hepático.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Se trata de un paciente con cirrosis y ascitis refractaria en el que el trasplante hepático estaría contraindicado por la edad y que ha tenido un infarto y presenta un proBNP de 6000 lo que predice que el paciente pueda tener cardiopatía subyacente incompatible con la colocación de un TIPS, por lo que la respuesta correcta sería realizar paracentesis evacuadoras.

78. Varón de 60 años con cirrosis hepática Child B 8 que acude a urgencias por dos episodios de hematemesis. Se instaura tratamiento médico con perfusión de somatostatina y omeprazol, ceftriaxona profiláctica y se le realiza endoscopia en la que se observan 3 cordones varicosos grandes, uno de ellos con sangrado activo. ¿Cuál sería la actitud más adecuada a continuación?:

1. Realizar ligadura endoscópica con bandas y mantener perfusión de somatostatina hasta cumplir 5 días de tratamiento y posteriormente profilaxis secundaria.
2. Dado que el paciente presenta sangrado activo colocar prótesis esofágica como puente al TIPS (prótesis intrahepática percutánea transyugular).

3. Realizar ligadura endoscópica con bandas y en las próximas 72 horas colocar TIPS.
4. Esclerosis endoscópica de las varices y mantener perfusión de somatostatina hasta cumplir 5 días de tratamiento y posteriormente profilaxis secundaria.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Ante un cuadro de hemorragia digestiva alta por varices el tratamiento endoscópico de elección es la ligadura con bandas pero además dado que el paciente es un Child B>7 y presenta sangrado activo en la endoscopia se debe colocar un TIPS preventivo en las próximas 72 horas esto es el concepto conocido como preventive TIPS.

79. Varón de 55 años, con antecedentes de cirrosis hepática por hepatitis C, sometido a trasplante hepático ortotópico hace 4 semanas. Evolucionaba favorablemente, pero en los últimos días presenta coluria, prurito intenso y leve ictericia. La analítica muestra elevación de FA, GGT y bilirrubina directa, con transaminasas dentro de la normalidad. Se realiza una ecografía abdominal en la que se evidencia dilatación de la vía biliar intrahepática, sin signos de litiasis ni líquido libre. Teniendo en cuenta la principal sospecha diagnóstica ¿cuál es la prueba más adecuada a realizar seguidamente?:

1. CPRE.
2. TC abdominal con contraste.
3. Ecoendoscopia.
4. Biopsia hepática.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Este paciente presenta una colestasis postrasplante con dilatación de la vía biliar intrahepática, lo que sugiere una estenosis de la anastomosis biliar, complicación frecuente tras el trasplante hepático. La CPRE es la prueba de elección porque permite confirmar y tratar esta complicación (dilatación y colocación de prótesis). El TC abdominal no es la mejor prueba para evaluar la vía biliar. La ecoendoscopia no está indicada; la evolución clínica, analítica y ecográfica hace altamente sospechoso el diagnóstico de estenosis de la anastomosis no siendo necesario una mejor caracterización de la misma. En este contexto y la biopsia hepática solo sería útil si se sospechara afectación parenquimatosa como rechazo, lo cual no se evidencia aquí.

80. Paciente de 59 años intervenido hace 10 días mediante hemicolecotomía. Consulta por enrojecimiento y dolor en la zona de la herida quirúrgica, con salida de pus por un punto lateral. ¿Qué actitud es correcta?:

1. Antibioterapia empírica oral.
2. Cierre inmediato de la herida con puntos nuevos.

3. Apertura de la herida y curas locales.
4. Solicitar TC para valorar absceso profundo.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Las infecciones de herida quirúrgica superficial se tratan con apertura de la herida, drenaje si hay supuración, y curas locales. Añadiremos antibiotico en caso de que la infección este produciendo afectación sistémica o mucha celulitis. Pero lo que tenemos que hacer es abrir la herida y lavarla.

81. Mujer de 53 años diagnosticada de cáncer de mama tratada con mastectomía radical modificada de Halsted. Está valorando opciones de reconstrucción mamaria inmediata. ¿Cuál de las siguientes técnicas se asocia con mejores resultados estéticos y menor tasa de complicaciones cuando hay que radioterapia postoperatoria?:

1. Reconstrucción con colgajo TRAM.
2. Implante protésico submuscular directo.
3. Reconstrucción diferida con lipofilling.
4. Reconstrucción con colgajo DIEP.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Al ser inmediata la reconstrucción podemos descartar la respuesta C. Por lo tanto nos quedan los colgajos y la prótesis. En pacientes que van a recibir RT postoperatoria la recomendación es o una reconstrucción diferida o una inmediata con reconstrucción autóloga. En caso de elegir una reconstrucción inmediata con prótesis, en vez de colocar inicialmente la prótesis se prefiere una estrategia en dos tiempos colocando primero un expansor y luego en un segundo tiempo la prótesis (Aunque hay que recordar que por definición la RT postquirúrgica no es contraindicación absoluta de prótesis inmediata; si hay que individualizar los riesgos). Por lo tanto los colgajos son los que mejor toleran la RT. Entre el colgajo TRAM y DIEP tenemos que recordar que el colgajo TRAM se lleva consigo el musculo recto abdominal dejando un defecto musculoponeurótico en la pared baja del abdomen, lo que asocia mayor morbilidad y un postoperatorio de más dolor (además está en desuso por estas razones, eligiéndose en caso de que la paciente no sea candidata a microcirugía (el TRAM vs el DIEP no requiere microcirugía de tan alta especialización)). Nuestra respuesta es el DIEP. El colgajo DIEP (deep inferior epigastric perforator) preserva el músculo recto anterior y tiene mejores resultados funcionales y estéticos en comparación con el TRAM. Es especialmente útil en pacientes que recibirán radioterapia, ya que la tolerancia tisular es superior a la de los implantes, tiene menor tasa de complicaciones a largo plazo, pero necesita microcirugía.

82. Paciente varón de 85 años que acude remitido desde la residencia donde se encuentra institucionalizado por cuadro de lesiones de aproximadamente 2 meses de evolución,

consistentes en placas eritematoedematosas pruriginosas y aparición de ampollas de predominio en tronco y extremidades. No presenta lesiones en mucosas y su estado general es bueno salvo por el prurito referido. Entre sus antecedentes destaca hipertensión, diabetes, dislipemia y deterioro cognitivo leve-moderado. Está en tratamiento con enalapril, sitagliptina y simvastatina, con buen control de sus patologías. Respecto a la entidad que sospechamos en este paciente, ¿qué es cierto?:

1. Es imprescindible realizar tratamiento al personal de la residencia que mantenga contacto más estrecho con el paciente, ya que es altamente contagioso.
2. Para confirmar el diagnóstico, deberíamos realizar una biopsia en formol y en fresco, donde observaríamos un despegamiento de la epidermis a nivel suprabasal con inmunofluorescencia directa positiva con patrón en panal de abeja.
3. Deberíamos realizar un cambio en su medicación habitual, porque posiblemente uno de esos fármacos haya actuado como desencadenante del cuadro, aunque su retirada no asegura la resolución completa y definitiva.
4. Es altamente probable que precise ingreso e incluso atención en unidad de cuidados intensivos.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Nos están contando un caso de penfigoide ampollar, típico de personas de edad avanzada que presentan placas eritematodermatosas con ampollas tensas de contenido serohemático y que suelen asociar prurito.

No es contagiosa, por lo que la opción 1 es falsa.

La opción 2 nos está describiendo los hallazgos que encontraríamos en un caso de pénfigo vulgar.

La opción 4 es falsa ya que normalmente los pacientes con penfigoide ampolloso no suelen precisar ingreso para el control de sus brotes y mucho menos en unidad de cuidados intensivos.

La opción 3 es correcta, ya que se han descrito casos relacionados con fármacos, y más concretamente con los inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4 (DPP-4), las gliptinas, por lo que en casos en los que se sospecha su asociación se recomienda sustituirlo por otro antidiabético.

- 83. Varón de 15 años que acude a su consulta por percatarse de una zona alopécica redondeada en cuero cabelludo con prurito y descamación asociada. El paciente refiere que uno de sus amigos tiene algo similar. No ha realizado tratamiento. ¿Qué actitud sería la más adecuada?:**

1. Exploraría al paciente de forma completa, fijándome especialmente en muñecas y lateral de dedos, y si mi sospecha se confirma, trataría con permetrina o ivermectina oral.
2. Pediría una analítica con perfil tiroideo, glucemia, y niveles de hierro, y en función de los resultados pautaría tratamiento.
3. Dada la alta sospecha de infección fúngica preguntaría si tiene contacto con animales y pautaría ketoconazol gel.
4. Realizaría cultivo y plantearía tratamiento con antifúngico oral.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Recientemente se han descrito brotes epidémicos de tiña en cuero cabelludo asociados a peluquerías. Los afectados son en su mayoría varones jóvenes con el cabello rasurado, que acuden con relativa frecuencia a peluquerías donde no ha habido una esterilización adecuada del material empleado. Ante la sospecha se debe realizar un cultivo, siendo el responsable más habitual el *Trichophyton tonsurans*. Dado que afecta a cuero cabelludo, el tratamiento debe ser oral.

- 84. Mujer de 42 años a la que se le extirpa un melanoma de extensión superficial escapular derecho, ulcerado y con un índice de Breslow de 2,5 mm. Los márgenes de resección están libres de lesión. A la exploración física la paciente presenta una adenopatía axilar derecha palpable. Una punción con aguja fina demuestra la presencia de células malignas compatibles con metástasis de melanoma. Las pruebas de imagen no muestran metástasis a distancia. ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta?:**

1. Es suficiente con realizar una ampliación de márgenes de 2 cm.
2. El tratamiento de elección es una ampliación de márgenes de 1 cm junto con linfadenectomía axilar derecha.
3. Además de una ampliación de márgenes de 2 cm podría considerarse el tratamiento neoadyuvante con inmunoterapia seguida de linfadenectomía y posterior tratamiento adyuvante de acuerdo con la respuesta patológica.
4. Realizaríamos únicamente una linfadenectomía axilar derecha.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Se trata de una paciente joven con un melanoma ulcerado con alto índice de Breslow que presenta una metástasis ganglionar regional macroscópica, sin enfermedad a distancia. Estará indicado realizar una ampliación de 2 cm, por lo que la opción 2 y la opción 4 no son correctas. Debemos tratar la

enfermedad ganglionar también, por lo que la opción 1 no es correcta. Hasta finales de 2024 el tratamiento de elección de los pacientes con metástasis ganglionares regionales macroscópicas (detectadas clínicamente o en una prueba de imagen) era la linfadenectomía seguida de tratamiento adyuvante. En las últimas guías, se recomienda considerar la neoadyuvancia con inmunoterapia en estos pacientes. Este esquema de tratamiento hace posible evaluar la respuesta patológica, medida como el porcentaje de células tumorales viables en los ganglios extirpados, lo que puede ser de utilidad para seleccionar el mejor tratamiento adyuvante.

85. Un varón de 46 años con antecedente de hipertensión arterial y cardiopatía isquémica de diagnóstico reciente es derivado a su consulta de Dermatología en un hospital público por un cuadro de pérdida de densidad capilar de predominio en vértex y regiones frontotemporales, de años de evolución. No observa una mayor cantidad de cabellos desprendidos en la ducha o en el lavabo, pero le insiste en que el cuadro ha progresado a raíz del estrés secundario a las comorbilidades mencionadas y le solicita tratamiento con “unas pastillas” que, según refiere han funcionado muy bien a varios conocidos suyos. ¿Qué actitud adoptaría usted en este momento?:

1. Se trata de un efuvio telógeno agudo. Prescribiría tratamiento con combinación de minoxidil oral a dosis de 2.5 mg/día y dutasterida 0.5 mg/día y realizaría seguimiento dadas sus comorbilidades.
2. Se trata de una alopecia androgénica de patrón masculino (MAGA-M). Iniciaría tratamiento con combinación de minoxidil oral, indicado para su hipertensión arterial, y finasterida oral, que podría ser útil para una probable hiperplasia benigna de próstata incipiente.
3. Se trata de una alopecia androgénica común a todos los varones para la que no existe ningún tratamiento efectivo por lo que explicaría al paciente que no hay nada que hacer salvo el trasplante capilar y le daría el alta con seguimiento en Atención Primaria.
4. Se trata de una alopecia androgénica. Evaluaría las posibilidades de tratamiento de acuerdo con la evidencia existente, considerando sus posibles contraindicaciones y explicando su uso fuera de ficha técnica, así como la imposibilidad de seguimiento en el ámbito del sistema sanitario público.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta de tremenda actualidad que se responde con sentido común. El paciente presenta una alopecia androgénica de patrón masculino o calvicie común (respuesta 1 incorrecta) y no un efuvio (caída brusca y transitoria sin predilección por áreas sensibles a andrógenos, en la que los pacientes suelen

observar una mayor cantidad de cabello desprendido). Si bien el uso de minoxidil e inhibidores de la 5-alfa-reductasa como la finasterida o la dutasterida han demostrado ser útiles en este tipo de alopecia, su uso no está aprobado (ni financiado) para esta indicación, siendo una mala praxis su prescripción justificándolos por medio de otras indicaciones para las que el paciente no los precisa (respuesta 2 incorrecta). Por ello, si finalmente y bajo responsabilidad del médico se indican, el paciente debe comprender su uso fuera de ficha técnica, así como las posibles contraindicaciones (cautela con el minoxidil y la cardiopatía) y efectos adversos (respuesta 4 correcta). Por otra parte, de acuerdo con la legislación vigente, los procesos cuya repercusión sea exclusivamente estética no son candidatos de tratamiento ni seguimiento en el Sistema Nacional de Salud, tampoco en Atención Primaria (opción 3 incorrecta).

86. Mujer de 29 años sin antecedentes de interés que consulta a su médico de familia por manchas blancas asintomáticas localizadas en la cara, de más de 2 años de evolución. No refiere haber notado otra sintomatología y en su familia no existen antecedentes de enfermedades autoinmunes. A la exploración física presenta dos manchas acrómicas ovaladas, de unos 3 cm de diámetro mayor localizadas en el mentón y la zona supraciliar izquierda, sin descamación ni otros cambios epidérmicos. En relación con la enfermedad que sospecha, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta?:

1. El propionato de clobetasol al 0,5% en pomada sería el tratamiento de elección para esta paciente.
2. Sería conveniente realizar una analítica incluyendo una determinación de cortisol basal, con el objetivo de descartar una insuficiencia suprarrenal.
3. Los linfocitos T CD4+ son las células responsables de la destrucción de los melanocitos en las lesiones cutáneas.
4. El ruxolitinib al 1,5% en crema es un inhibidor de JAK1 y JAK2 que se ha aprobado recientemente como tratamiento de formas no segmentarias de esta enfermedad.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Nos presentan el caso de una paciente con vitiligo. El clobetasol no sería el corticoide tópico de elección para el área facial, dado el riesgo de atrofia, ni la pomada sería el vehículo más adecuado en esta zona, donde se suelen utilizar geles, cremas o emulsiones, cosméticamente mejor tolerados. Aunque el vitiligo puede asociarse a diversas enfermedades autoinmunes, incluyendo la insuficiencia suprarrenal primaria de origen autoinmune, no estaría indicado realizar un cortisol basal en esta paciente sin otra sintomatología. Las guías de práctica clínica recomiendan la determinación de anticuerpos anti-TPO y TSH como

cribado de rutina. En pacientes que presenten datos clínicos o analíticos que sugieran enfermedades autoinmunes adicionales o historia familiar, podríamos considerar realizar exploraciones complementarias adicionales o remitir para evaluación a otros especialistas. La opción 3 no es correcta, pues la destrucción de los melanocitos en las lesiones de vitíligo está mediada por linfocitos T citotóxicos CD8+. El ruxolitinib es un inhibidor de JAK1 y JAK2 aprobado como tratamiento del vitíligo no segmentario.

87. Un hombre de 52 años fue intervenido de carcinoma papilar de tiroides de 3 cm mediante tiroidectomía total, seguido de ablación con radioyodo y tratamiento con levotiroxina a dosis supresoras. Un año después, se realiza una valoración dinámica en la que presenta tiroglobulina estimulada por TSH <0,1 ng/mL, anticuerpos antitiroglobulina negativos, ecografía cervical sin adenopatías ni otras alteraciones estructurales, y rastreo corporal total con radioyodo negativo. ¿Cuál de las siguientes medidas sería menos adecuada en el seguimiento de este paciente?:

1. Disminuir gradualmente la dosis de levotiroxina para mantener TSH en rango bajo-normal.
2. Continuar seguimiento anual con ecografía cervical.
3. Solicitar PET-TC de cuerpo entero para descartar metástasis ocultas.
4. Realizar seguimiento anual de niveles séricos de tiroglobulina.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

El paciente presenta una estratificación dinámica de bajo riesgo, debido a una excelente respuesta terapéutica tras tratamiento inicial, evidenciada por tiroglobulina estimulada indetectable, anticuerpos negativos, rastreo corporal total negativo y ausencia de alteraciones en la ecografía cervical. En esta situación, no está indicado realizar un PET-TC, ya que este estudio se reserva para pacientes con sospecha clínica o analítica clara de enfermedad recurrente o metastásica, situaciones ausentes en este caso.

88. Mujer de 67 años, hipertensa, que consulta por debilidad muscular progresiva en miembros inferiores y episodios intermitentes de parálisis muscular, especialmente tras comidas abundantes. En analítica presenta potasio de 2,4 mEq/L y TSH suprimida con T4L elevada. ¿Cuál es el diagnóstico más probable en este caso?:

1. Síndrome de Conn.
2. Parálisis periódica tirotóxica.
3. Miastenia gravis asociada a hipertiroidismo.
4. Tiroiditis autoinmune silente con hipokalemia secundaria.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La parálisis periódica tirotóxica es una manifestación rara del hipertiroidismo, más frecuente en mujeres asiáticas y que cursa con episodios intermitentes de debilidad muscular severa por desplazamiento intracelular del potasio, provocando hipokalemia importante tras desencadenantes como ingesta de carbohidratos o estrés.

89. Recién nacido de 7 días de vida que acude por vómitos persistentes, rechazo de tomas y pérdida ponderal importante. En la exploración destaca deshidratación severa, hipotensión, virilización genital y pigmentación de piel aumentada. Se sospecha hiperplasia suprarrenal congénita clásica por déficit de 21-hidroxilasa. ¿Qué patrón bioquímico confirmaría esta sospecha diagnóstica?:

1. Elevación de ACTH, elevación de 17-OH progesterona, hipernatremia, hipopotasemia.
2. Elevación de ACTH, elevación de 17-OH progesterona, hiponatremia, hiperpotasemia.
3. Elevación de ACTH, disminución de 17-OH progesterona, hipernatremia, hipopotasemia.
4. Disminución de ACTH, disminución de 17-OH progesterona, hiponatremia, hiperpotasemia.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La hiperplasia suprarrenal congénita más frecuente (95%) es por déficit de la enzima 21-hidroxilasa. Esta enzima es clave para la síntesis de cortisol y aldosterona. Su déficit provoca acumulación de metabolitos previos como la 17-OH progesterona (muy elevada), insuficiencia suprarrenal (cortisol bajo y ACTH elevada, responsable de la pigmentación cutánea) y pérdida de sodio con retención de potasio (hiponatremia e hiperpotasemia). Además, el exceso de precursores deriva en una producción aumentada de andrógenos suprarrenales causando virilización genital desde el nacimiento.

90. Una paciente de 38 años con diagnóstico de microprolactinoma hipofisario, de 7 mm de diámetro, es remitida a su consulta para una segunda opinión médica. La información más adecuada en este momento sería:

1. Se trata de una microprolactinoma, tumor con escasa tendencia al crecimiento (<5%). Si no presenta síntomas ni deseo gestacional no requiere tratamiento ni seguimiento.
2. Se trata de una microprolactinoma, tumor con escasa tendencia al crecimiento (<5%). Si no presenta síntomas ni tiene deseo gestacional no precisa tratamiento, tan solo seguimiento.
3. Se trata de una microprolactinoma, tumor con escasa tendencia al crecimiento (<5%). Se recomienda el tratamiento médico con agonistas

dopaminérgicos en microprolactinomas de >6 mm diámetro.

4. Se trata de una microprolactinoma, tumor con escasa tendencia al crecimiento (<5%). Se recomienda el tratamiento médico con agonistas dopaminérgicos en todos los casos.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta sencilla. El microprolactinoma es un tumor con escasa tendencia al crecimiento, inferior al 5% en el seguimiento a 5 años, por lo que no precisa tratamiento de entrada en ausencia de síntomas o deseo gestacional. Se recomienda seguimiento periódico durante 5-6 años, y en caso de crecimiento significativo iniciar tratamiento, y de no crecimiento suspender seguimiento. El tratamiento de primera elección, en caso de estar indicado, será el uso de agonistas dopaminérgicos.

91. Es verano y acude a su Centro de Salud de Gandía (Comunidad Valenciana) de urgencia un hombre de 70 años, natural de Parla (Comunidad de Madrid), con antecedentes personales de DM-2 e hiperplasia benigna de próstata. Está en tratamiento con un fármaco “para que se haga la próstata pequeña” y desde hace 2 meses está tomando dos medicamentos “para el azúcar” que no los recuerda. Le comenta que ha estado ingresado hasta hace 2 semanas en el Hospital de Parla por una infección de orina que “fue muy bien”. No aporta informes. El paciente refiere actualmente prurito genital y dolor. A la exploración presenta edema en prepucio y lesiones eritematosas dolorosas con secreción blanquecina en el glande. Le hace una tira de orina en la que no hay nitritos ni leucocitos, pero sí una alteración que le llama la atención. Dicha alteración en la orina junto con la clínica del paciente le hace pensar en un tratamiento que pudiera estar recibiendo, señálelo:

1. Dapagliflozina.
2. Dutasteride/tamsulosina.
3. Tirzepatida.
4. Serenoa repens.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Estamos ante un paciente diabético y con HBP en tratamiento para ambos, el problema es que no nos da información. Ha padecido una infección urinaria y acude a nuestro centro de salud por lesiones en el pene, que por la descripción podrían corresponder a una balanitis por Candida. Entre los fármacos que debemos recordar que favorecen las infecciones urinarias y candidiasis están los iSGL2, por tanto, es probable que este paciente esté con dapagliflozina (respuesta 1 correcta, resto incorrectas). Es muy probable que la alteración en orina de la que nos hacen referencia sea la presencia de glucosuria abundante (recordemos que estos medicamentos son “glucosúricos”).

92. ¿Cuál de los siguientes tratamientos para la obesidad ha demostrado una mayor reducción en el peso corporal?:

1. Semaglutida.
2. Liraglutida.
3. Tirzepatida.
4. Gastrectomía tubular.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta sencilla. Los nuevos tratamientos farmacológicos de la obesidad consiguen pérdidas de peso muy importantes (hasta ~20% de peso corporal en el caso de la tirzepatida, el fármaco más potente), y que en muchos casos consiguen evitar la indicación quirúrgica. No obstante, la cirugía bariátrica sigue siendo más efectiva (a costa de mayores complicaciones y efectos secundarios, claro). La gastrectomía tubular consigue aproximadamente un 30% de pérdida de peso, y por tanto sigue siendo superior a cualquier fármaco.

93. Valora usted en su consulta a un varón de 72 años con antecedentes de extabaquismo, glucemia alterada en ayunas, HTA y obesidad. Hace dos años tuvo un accidente isquémico transitorio (AIT), por lo que está en seguimiento por Neurología. Recibe tratamiento con AAS 100, atorvastatina 80 mg, enalapril/hidroclorotiazida, metformina, y omeprazol. En la analítica, presenta un perfil lipídico con colesterol total 190 mg/dL; HDLc 45 mg/dL; triglicéridos 220 mg/dL; LDLc 110 mg/dL. ¿Cuál de los siguientes considera que el cambio en el tratamiento hipolipemiente más adecuado?:

1. Añadir ezetimiba.
2. Añadir inclisiran.
3. Cambiar atorvastatina por rosuvastatina.
4. Añadir ácido bempedoico.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Se trata de un paciente con enfermedad vascular establecida (AIT), por lo que estamos en un escenario de prevención secundaria con objetivo LDL < 55 mg/dL. En este contexto, una LDLc > 100 a pesar de la máxima dosis tolerada de estatina (como es el caso) es indicación de terapias dirigidas a la PCSK-9 como inclisiran, o evolocumab, no siendo necesario que el paciente esté en tratamiento con ezetimiba.

94. Si dos variables continuas siguen distribuciones normales con igual promedio, pero distinta variabilidad, ¿qué significa una menor dispersión en una de ellas?:

1. Menor probabilidad de observar valores alejados del centro.
2. Distribución con menor curtosis.
3. Distribución necesariamente asimétrica.

4. Mayor concentración de los datos alrededor de su media.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Una menor dispersión se relaciona con una menor desviación estándar. Por tanto, indica que los datos están más agrupados alrededor de la media. En una distribución normal, esto se traduce en una mayor concentración de probabilidad cerca del promedio, respuesta 4 correcta. Las otras opciones son incorrectas: una menor dispersión implica una menor probabilidad de observar valores extremos, podría estar asociada a una mayor curtosis (distribución más “picuda”), y las distribuciones normales son inherentemente simétricas.

- 95. Una de las siguientes actitudes no contribuye al parto de mínima intervención, señálela:**

1. Piel con piel.
2. Monitorización fetal externa.
3. Alumbramiento dirigido.
4. Pinzamiento precoz del cordón.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

El protocolo de parto de mínima intervención se basa en la amniorrexis artificial lo más tardía posible, monitorización fetal externa, alumbramiento dirigido, piel con piel, uso de métodos no invasivos de analgesia y pinzamiento tardío de cordón (cuando deje de latir), evitando la realización de pinzamiento precoz de cordón (a menos que exista alguna condición que contraindique el clampaje tardío).

- 96. Señale la causa más frecuente de hemorragia puerperal tardía:**

1. Retención de restos placentarios.
2. Atonía uterina.
3. Lesiones del canal del parto.
4. Coagulopatías.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

La hemorragia postparto tardía tiene lugar entre las 24 horas y las 6 semanas postparto. La causa más frecuente es la retención de restos placentarios. Se denomina hemorragia puerperal precoz aquella que tiene lugar en las primeras 24 horas postparto, y la causa más frecuentes es la atonía uterina, seguida de la retención de restos placentarios, las lesiones del canal del parto y las alteraciones de la coagulación.

- 97. Paciente de 32 años con test de gestación positivo y amenorrea de 9 semanas. Consulta por hiperémesis gravídica de 6 días de evolución y metrorragia escasa de 3 horas de evolución. En la exploración se comprueba sangrado escaso de cavidad uterina y útero aumentado como gestación de 14 semanas. En el estudio ecográfico presenta imagen intrauterina en “copos de**

nieve” y ausencia de saco gestacional intraútero. La determinación de B-HCG es de 110.000 mUI/mL. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?:

1. Aborto en curso, dado el sangrado y la ausencia de saco gestacional.
2. Gestación ectópica de localización desconocida, dada la ausencia de saco gestacional intraútero.
3. Mola hidatiforme, dada la clínica y los hallazgos ecográficos.
4. Coriocarcinoma, dados los niveles de HCG-BETA.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Se trata de un caso clínico de enfermedad trofoblástica gestacional. No debemos sospechar una neoplasia en primera instancia, dada su infrecuencia (respuesta 4 falsa). Los niveles tan elevados de HCG-BETA son los responsables de la clínica de la paciente, no compatibles con un aborto o un ectópico (respuestas 1 y 2 falsas).

- 98. Mujer de 38 años, primigesta, sin antecedentes médicos de interés, acude a su primera consulta obstétrica en la semana 7 de gestación. ¿Cuál sería la actitud más adecuada respecto al cribado de diabetes gestacional según las recomendaciones vigentes en España?:**

1. Realizar un test de O’Sullivan en la semana 24-28 como parte del cribado universal.
2. Realizar un test de O’Sullivan en la analítica del primer trimestre de control gestacional.
3. Indicar una sobrecarga oral de glucosa de 100 g en la primera visita como parte de la estrategia en un solo paso.
4. Solicitar una HbA1c basal en esta visita como prueba de cribado precoz en mujeres de riesgo.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La opción 2 es la correcta. Según la SEGO y el Ministerio de Sanidad, las gestantes con factores de riesgo para diabetes gestacional —como edad materna ≥ 35 años, obesidad, antecedentes personales o familiares de diabetes, historia obstétrica adversa, entre otros— deben ser sometidas a un cribado precoz desde el primer trimestre, mediante un test de O’Sullivan (50 g de glucosa, no en ayunas, con glucemia 1h ≥ 140 mg/dL como punto de corte para realizar SOG 100 g). La estrategia en dos pasos, utilizada en España, consiste en: Paso 1: Test de O’Sullivan (screening). Paso 2: Si es positivo, realizar una sobrecarga oral de glucosa de 100 g en ayunas (diagnóstico), con al menos 2 valores alterados para confirmar diabetes gestacional. La opción 1 es incorrecta, ya que, si bien el cribado universal con test de O’Sullivan se realiza entre 24–28 semanas, esta paciente tiene un factor de riesgo (edad >35), por lo que debe hacerse cribado precoz en la primera visita. La opción 3 es falsa; la estrategia en un paso como rutina implica directamente una SOG de 75 g en

ayunas y diagnóstico con 1 solo valor alterado. Recordad que su uso es controvertido puesto que algunas guías nacionales e internacionales refieren sobrediagnosticar a pacientes de Diabetes Gestacional si utilizamos dicha estrategia. La opción 4 también es incorrecta: la HbA1c no es una herramienta válida ni recomendada para el cribado de diabetes gestacional según la SEGO, ni en gestantes de riesgo ni en cribado universal. Su uso se limita al seguimiento de pacientes diabéticas pregestacionales o en sospecha de DM2 previa.

99. Mujer de 32 años diagnosticada de síndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH), con cariotipo 46,XX y función ovárica normal. Desea ser madre pero sabe que no tiene útero funcional. Según la legislación española vigente, ¿cuál de las siguientes opciones es actualmente legal y viable para lograr la maternidad?:

1. Fecundación in vitro con ovocitos propios seguida de gestación subrogada en España.
2. Fecundación in vitro con ovocitos de donante y transferencia embrionaria en útero neovaginal.
3. Adopción legal tras proceso regulado por los servicios sociales y autonómicos.
4. Trasplante uterino seguido de fecundación in vitro y gestación propia.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La opción 3 es la correcta según el marco legal español. Las mujeres con síndrome de Rokitansky, al no disponer de útero funcional, no pueden gestar. Aunque médicamente pueden aportar ovocitos propios, la gestación subrogada está prohibida en España (Ley 14/2006 sobre técnicas de reproducción humana asistida). Por tanto, la única vía legal y viable para alcanzar la maternidad en nuestro país es la adopción, regulada por las comunidades autónomas y coordinada por los servicios sociales, con protocolos específicos de idoneidad. La opción 1 es falsa porque la gestación subrogada está legalmente prohibida en España, aunque algunas personas recurren a ella en el extranjero. Sin embargo, el enunciado pregunta por lo permitido según la legislación española vigente. La opción 2 también es incorrecta. Aunque pueda realizarse una neovagina funcional quirúrgicamente, no tiene capacidad uterina y no es un órgano gestante, por lo que una transferencia embrionaria en ese contexto es inviable. La opción 4, aunque contiene un elemento cierto, en 2020 se realizó el primer trasplante uterino en España en el Hospital Clínic de Barcelona y en 2023 se logró el primer nacimiento exitoso, esta técnica sigue siendo experimental, solo se ofrece en contextos de ensayos clínicos autorizados y no está disponible para la práctica clínica general. Por tanto, no puede considerarse una opción terapéutica real en la práctica asistencial habitual.

100. Se encuentra ante una paciente de 56 años, menopáusica desde los 53 años y con antecedentes de obesidad (IMC 35) y DM tipo II,

que ha sido estudiada por un sangrado genital. La biopsia endometrial por aspirado muestra una hiperplasia con atipias. La ecografía transvaginal es anodina. Usted considera que lo más apropiado en este caso es:

1. Programar una histerectomía con anexectomía bilateral.
2. Realizar un estudio de extensión con RM pélvica.
3. Repetir la biopsia endometrial, pero guiada por histeroscopia.
4. Colocar un DIU de levonorgestrel a altas dosis con biopsias periódicas de control.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

El tratamiento de elección de la hiperplasia endometrial con atipias es la histerectomía total con anexectomía bilateral, por su elevado riesgo de progresión a carcinoma. Al ser una lesión preneoplásica no precisa en principio un estudio de extensión prequirúrgico.

101. Tiene citada en consulta para resultados postquirúrgicos a una paciente que hace un mes fue sometida a una histerectomía total con anexectomía bilateral y BSGC pélvico bilateral por laparoscopia en contexto de un carcinoma endometriode de endometrio de bajo grado. El estudio definitivo de la pieza quirúrgica confirma la presencia de este tipo histológico de cáncer, estadio FIGO IA. El estudio molecular muestra un patrón no específico (NSMP). Es cierto que:

1. Ese patrón molecular aumenta el estadio y ensombrece por tanto el pronóstico.
2. Habría que completar la cirugía con una linfadenectomía pélvica y paraaórtica.
3. Precisa tratamiento adyuvante con radioterapia y quimioterapia.
4. Ninguna es correcta.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Se trata de un carcinoma de endometrio de bajo grado en estadio inicial IA. La cirugía ha sido completa. El subtipo molecular NSMP no afecta a la estadificación, a diferencia de POLEmut o p53abn. Por tanto, esta paciente no precisa más tratamiento (4 correcta).

102. Con respecto a los tipos de cirugía en el cáncer de ovario, señale la CORRECTA:

1. La cirugía de estadificación es aquella que se realiza en los estadios avanzados de la enfermedad.
2. La citorreducción primaria es aquella que se realiza tras finalizar la quimioterapia neoadyuvante.

3. La cirugía de intervalo es aquella que se realiza tras 3-4 ciclos de quimioterapia neoadyuvante, en pacientes no resecables al diagnóstico.
4. Todas son correctas.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La cirugía de estadificación es la que se realiza en los cánceres en estadio INICIAL. La citorreducción primaria es la cirugía que se realiza ANTES de la quimioterapia, de entrada tras el diagnóstico. La cirugía de intervalo es la que se realiza a mitad de quimioterapia, en pacientes no resecables de inicio pero que han respondido a la neoadyuvancia (3 correcta).

103. Avisan de paritorio por un parto de un recién nacido de 38 semanas de edad gestacional con riesgo de pérdida de bienestar fetal en registro cardiotocográfico. Nace un recién nacido sin esfuerzo respiratorio, hipotónico y con cianosis generalizada. Se traslada a la cuna de reanimación donde se seca, se estimula y se aspiran secreciones con escasa respuesta. Se inicia ventilación con presión positiva intermitente (VPPI) con inicio de llanto. Al minuto de vida persiste dificultad respiratoria importante con frecuencia cardíaca de 170 lpm iniciando tos al aspirar secreciones con la sonda. Objetiva también en ese momento coloración azulada de extremidades con leve flexión de las mismas. ¿Cuál sería su puntuación en el test de Apgar?:

1. 6.
2. 7.
3. 5.
4. 8.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta sencilla sobre el test de Apgar. Recién nacido término que presenta al minuto de vida dificultad respiratoria (1 punto), frecuencia cardíaca > 100 lpm (2 puntos), tos con estímulos (2 puntos), acrocianosis (1 punto) y tono con ligera flexión de extremidades (1 punto). En total tendríamos una puntuación de 7 puntos.

104. Señale la respuesta correcta respecto a las parálisis del plexo braquial:

1. En un niño que presenta clínica de parálisis braquial con reflejo de moro asimétrico lo más probable es que se trate de una parálisis de Erb-Duchenne.
2. La parálisis de Déjerine-Klumpke tiene un excelente pronóstico con recuperación completa en el 85% de los casos.
3. Una de las complicaciones más graves que puede asociar la parálisis de Erb-Duchenne es el síndrome de Horner.

4. En la parálisis de Déjerine-Klumpke se afectan típicamente las raíces C4, C5 y C6.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta sencilla sobre las parálisis del plexo braquial donde intentan confundirnos entre la parálisis de Erb-Duchenne y la de Déjerine-Klumpke. Recordad que la parálisis de Erb-Duchenne tiene mejor pronóstico y afecta a las raíces superiores (C4-C6) con afectación de la musculatura proximal (reflejo de Moro asimétrico y de presión palmar conservado). Su complicación más grave es la parálisis diafragmática por afectación de C4. La parálisis de Déjerine-Klumpke por el contrario afecta a las raíces inferiores (C7-T1) con afectación de musculatura distal (reflejo de Moro simétrico y de presión palmar abolido). Su complicación más grave es el síndrome de Horner por afectación de T1.

105. Lactante de 1 mes de vida que presenta de forma progresiva vómitos proyectivos tras las tomas en número creciente. ¿Cuál de las siguientes sería esperable encontrar en este caso?:

1. Acidosis metabólica.
2. Ecografía con signo del donut.
3. Vómitos biliosos.
4. Irritabilidad.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Caso sencillo sobre la estenosis hipertrófica del píloro. Se trata de un lactante de 1 mes de vida con vómitos proyectivos tras las tomas. Recordad que en la estenosis hipertrófica del píloro los vómitos son proyectivos y no biliosos (respuesta 3 falsa). Además, son niños con importante irritabilidad ya que tienen hambre (respuesta 4 correcta). En las pruebas complementarias podemos encontrar alcalosis metabólica (respuesta 1 falsa) y en la ecografía, que es la prueba diagnóstica de elección, encontraremos engrosamiento del canal del píloro. El signo del donut es típico de la invaginación intestinal (respuesta 2 falsa).

106. ¿Cuál de los siguientes esquemas de vacunación es correcto?:

1. Triple vírica: dosis inicial a los 15 meses y recuerdo a los 3-4 años de edad.
2. Rotavirus: dos dosis separadas entre ellas de un mes a partir de los 12 meses de edad.
3. Polio: 2,4 y 11 meses con dosis de recuerdo a los 6 y los 14 años.
4. Meningitis B: 2, 4 y 12 meses.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La meningitis B ha sido recientemente introducida en el calendario vacunal con pauta de administración a los 2, 4 y 12 meses. De la triple vírica se pone la dosis inicial a los 12 meses con un recuerdo a los 3-4 años (respuesta 1 falsa).

La vacuna del rotavirus consiste en 2 o 3 dosis separadas de 4 semanas entre ellas (según la vacuna utilizada) que se ponen entre los 2 y los 6 meses de edad (respuesta 2 falsa). La vacuna de la polio se pone a los 2,4 y 11 meses, pero únicamente tiene un recuerdo a los 6 años (respuesta 3 falsa).

107. Acude a paritorio para atender a un recién nacido de 41+6 semanas de edad gestacional con bolsa rota prolongada y líquido teñido. Nace impregnado en meconio sin esfuerzo respiratorio, hipotónico y con cianosis generalizada. ¿Cuál sería la actitud a seguir a continuación?:

1. Pasar a cuna de reanimación e iniciar ventilación con presión positiva continua (CPAP) y FiO2 100% durante 30 segundos.
2. Pasar a cuna de reanimación e inicio de ventilación con presión positiva intermitente (VPPI) y FiO2 100% durante 30 segundos.
3. Pasar a cuna de reanimación e intubación orotraqueal para aspiración de secreciones de tráquea.
4. Pasar a cuna de reanimación, secar, calentar, estimular, recolocar vía aérea y aspirar secreciones de orofaringe.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta sobre reanimación neonatal en recién nacido con aguas meconiales. La reanimación en estos recién nacidos ha cambiado de forma importante en los últimos años. Así, antes, ante un recién nacido que nacía sin esfuerzo respiratorio impregnado en aguas meconiales estaba indicada la intubación directa para aspirar secreciones de tráquea (respuesta 3, falsa). Actualmente, la recomendación es tratar a estos recién nacidos según el algoritmo habitual de manera que inicialmente estará indicado secar, calentar, estimular, abrir vía aérea y aspirar secreciones de orofaringe, pero no de tráquea (respuesta 4, correcta). En caso de persistir ausencia de esfuerzo respiratorio se iniciaría VPPI (respuesta 2, falsa) y, si a pesar de esto no evoluciona bien y se sospecha obstrucción traqueal se valoraría intubación y aspiración de tráquea. La CPAP se utiliza cuando existe esfuerzo respiratorio, pero persiste dificultad respiratoria (respuesta 1, falsa).

108. Señale la respuesta correcta respecto a la encefalopatía hipóxico-isquémica:

1. Se trata de una patología típica de los recién nacidos prematuros.
2. Uno de los criterios que se deben cumplir para incluir al niño en hipotermia es que tenga clínica de encefalopatía independientemente de la gravedad de la misma.
3. Para la hipotermia se debe disminuir la temperatura corporal del neonato de forma lenta hasta 33-34°C y el recalentamiento posterior se lleva a cabo en 1-2 horas.

4. Para clasificar la encefalopatía según gravedad se utilizan escalas como la de A. García-Alix o Sarnat.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La encefalopatía hipóxico-isquémica es típica de recién nacidos a término con antecedente de asfixia perinatal (respuesta 1 falsa). El tratamiento para esta patología es, en algunos casos la hipotermia, para ello, el recién nacido debe tener clínica de encefalopatía moderada o severa (respuesta 2 falsa). La gravedad de la encefalopatía se mide con escalas validadas como la de Sarnat o la de A. García-Alix (respuesta 4 verdadera). Para llevar a cabo la hipotermia se enfría al neonato de forma rápida hasta 33-34°C y posteriormente el recalentamiento hay que llevarlo a cabo de forma progresiva (respuesta 3 falsa).

109. Niño de 4 años que acude a Urgencias por cuadro catarral con febrícula, disfonía y tos perruna. A su llegada presenta además estridor inspiratorio en reposo y dificultad respiratoria importante con tiraje universal. Señale la respuesta correcta sobre este cuadro:

1. En algunos casos graves de esta patología está indicado el tratamiento con Helio.
2. Dado el cuadro de dificultad respiratoria importante iniciaría tratamiento con Salbutamol nebulizado y corticoterapia sistémica.
3. Para realizar un adecuado diagnóstico es necesario realizar una exploración física completa incluyendo orofaringe.
4. En casos moderados-graves está indicado el tratamiento con nebulización de atropina.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta de dificultad intermedia sobre laringitis. Nos presentan un caso clínico típico de laringitis grave. Recordad que en estos casos no debemos explorar orofaringe por riesgo a que el niño se agite, produciendo más edema de la vía aérea superior y empeorando el cuadro (respuesta 3 falsa). En cuanto al tratamiento de las laringitis en los casos leves se administra corticoterapia oral (dexametasona) y en los casos moderados-graves se asocia nebulización de adrenalina, no de atropina (respuesta 4 falsa). El salbutamol no está indicado en este caso ya que se trata de patología de la vía respiratoria superior (respuesta 2 falsa). En cuadros de laringitis graves con respuesta insuficiente a la adrenalina nebulizada, se puede probar tratamiento con Helio (se administra junto con oxígeno). Este gas tiene una densidad menor y facilita el paso de aire a través de la vía aérea inflamada (respuesta 1 correcta).

110. Niño de 3 años que acude a Urgencias por fiebre de 6 días (máxima 39,5°C axilar) de evolución junto con aparición en las últimas horas de exantema maculopapular eritematoso

de distribución generalizada. A la exploración llama la atención que el paciente se encuentra irritable y presenta además hiperemia conjuntival bilateral sin secreción, así como labios eritematosos y fisurados y una adenopatía laterocervical izquierda. Ante la sospecha clínica se realiza analítica sanguínea en la que destaca elevación de PCR y VSG, leucocitosis y trombocitosis. ¿Cuál sería la actitud más adecuada en este momento?:

1. El paciente cumple criterios de enfermedad de Kawasaki completo por lo que ingresaría e iniciaría tratamiento con ácido acetil salicílico a dosis antiagregante e inmunoglobulinas IV.
2. El paciente cumple criterios de enfermedad de Kawasaki completo por lo que ingresaría e iniciaría tratamiento con ácido acetil salicílico a dosis antiinflamatoria e inmunoglobulinas IV.
3. El paciente cumple criterios de enfermedad de Kawasaki incompleto por lo que ingresaría y por el momento mantendría actitud expectante hasta confirmar la sospecha diagnóstica.
4. El paciente cumple criterios de enfermedad de Kawasaki incompleto por lo que ingresaría e iniciaría tratamiento con corticoterapia.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta de dificultad media sobre la enfermedad de Kawasaki. Se trata de un caso clínico típico de esta patología. La dificultad de esta pregunta está en primer lugar en reconocer que se trata de un caso de Kawasaki completo (fiebre >5 días junto con 4 criterios clínicos) (respuestas 3 y 4 falsas). Por último, debemos recordar el tratamiento de esta entidad que es ácido acetil salicílico a dosis antiinflamatoria inicialmente junto con inmunoglobulinas IV (respuesta 2 correcta y 1 falsa). El ácido acetil salicílico a dosis antiagregante se utiliza una vez pasadas las 6-8 semanas si existen lesiones coronarias (recordad que a estos pacientes hay que hacerles ecocardiografía por el riesgo de aneurismas coronarios). Por último, los corticoides se utilizan en los casos refractarios a inmunoglobulinas, pero no como primera línea de tratamiento.

111. Varón de 9 años con pancitopenia de 2 años de evolución, que empeora progresivamente. En la EF llama la atención estatura baja, microcefalia y manchas café con leche. Le realiza un frotis y ve que han aparecido blastos de estirpe mieloide, no presentes en estudios previos. ¿Qué patología sospecha y qué tratamiento recomendaría en consecuencia?:

1. Sospecho una hemoglobinuria paroxística nocturna, trataría con eculizumab.
2. El cuadro es sugestivo de anemia de fanconi y la única opción curativa es un trasplante alogénico de médula ósea.

3. Podría ser un cuadro de ataxia telangiectasia y debe realizarse un trasplante alogénico de médula ósea.
4. Sospecho una aplasia medular idiopática y puede beneficiarse de triple terapia inmunosupresora.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La clave de la pregunta reside en identificar el fenotipo típico de la anemia de Fanconi (estatura baja, microcefalia, manchas café con leche). La pancitopenia orienta a aplasia medular asociada y la aparición repentina de blastos debe hacernos sospechar en que quizás esté progresando a una leucemia aguda. La única opción curativa es un trasplante de progenitores hematopoyéticos (opción 2 correcta, opción 1, 3 y 4 incorrectas).

112. Mujer de 35 años grupo 0 Rh-, que le están transfundiendo 1 concentrado de hematíes por una anemia asociada a una leucemia aguda. A los 2 minutos de iniciarse la transfusión, inicia un cuadro de fiebre, lumbalgia y mal estado general. Al comprobar el componente sanguíneo que se está transfundiendo, usted se percata de que estaba destinado realmente a otro paciente y que es del grupo A+. ¿Qué sospecha que está ocurriendo y qué haría a continuación?:

1. Podría tratarse de una neutropenia febril. Policultivo e inicio antibioterapia de amplio espectro que cubra pseudomonas.
2. Se trata de una reacción hemolítica postransfusional por incompatibilidad Rh, debe detenerse la transfusión e iniciarse profilaxis con AntiD. .
3. Se trata de una reacción hemolítica postransfusional por incompatibilidad ABO, debe detenerse la transfusión y proceder a transfundir un concentrado de hematíes que sea compatible.
4. Se trata de una reacción hemolítica por incompatibilidad ABO. Debe detenerse inmediatamente la transfusión, notificarlo a Hemovigilancia, iniciar sueroterapia y monitorizar a la paciente estrechamente en una unidad de cuidados intensivos. A posteriori, debería plantearse también profilaxis antiD.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Esta es la situación más temida en la práctica transfusional, la administración errónea de hematíes ABO incompatibles. La paciente es 0-, por lo que tiene anticuerpos IgM frente a los antígenos AB eritrocitarios de los que carece. La transfusión de hematíes A + en esta paciente ha ocasionado una reacción hemolítica intravascular que puede tener una gravedad extrema que lleve a la defunción de la paciente en muy poco tiempo principalmente por fallo renal debido

a hemoglobinuria masiva. Debe detenerse inmediatamente la transfusión, iniciar medidas de protección renal (sueroterapia) y monitorizar a la paciente en cuidados intensivos, quien probablemente requerirá incluso de diálisis renal. Es fundamental notificar este suceso a hemovigilancia, la sección del banco de sangre que se encarga de identificar errores transfusionales e investigarlos para poder prevenirlos en el futuro (opción 4 correcta). En esta paciente también hay incompatibilidad rh pero es un hecho completamente secundario en este caso (opción 2 incorrecta). En una situación de tan extrema gravedad, no podemos simplemente transfundir otro concentrado compatible y obviar la hemólisis (opción 3 incorrecta). En esta paciente es correcto cubrir con antibioterapia debido a la fiebre y su patología de base, pero no es la causa más probable de este cuadro, dado que claramente estamos ante una reacción hemolítica postransfusional que puede manifestarse también con fiebre (opción 1 incorrecta).

113. Varón de 76 años que acude por astenia intensa y sudoración nocturna profusa de 2 meses de evolución. En la exploración física destaca esplenomegalia de 6 traveses de dedo. En analítica, Hb 8g/dL, N 600/uL, P 20 x 10⁹/L. En el frotis de sangre periférica se observan numerosos dacriocitos y formas granulopoyéticas inmaduras. Con respecto a lo que usted sospecha, señale la CORRECTA:

1. Sospecho un síndrome mielodisplásico, por lo que inicio tratamiento con azacitidina.
2. Parece infiltración metastásica por un tumor de origen desconocido. Hago biopsia de médula y solicito BodyTC.
3. Podría tratarse de una mielofibrosis, planteo tratamiento con ruxolitinib.
4. Parece una tricoleucemia, inicio cladribina.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta de dificultad intermedia. Se trata de un paciente con esplenomegalia, citopenias en analítica, reacción leucoeritroblástica y fibrosis medular. Todo orienta a mielofibrosis, por lo que debería iniciar tratamiento con ruxolitinib (opción 3 correcta). Es imprescindible que nos digan que hay displasia visible para sospechar un SMD (opción 1 incorrecta). La mieloptisis no va con esplenomegalia y en la biopsia de médula no se vería fibrosis sino algún tipo de tumor sólido metastásico (opción 2 incorrecta). En la tricoleucemia habría pancitopenia con esplenomegalia y fibrosis medular, pero no reacción leucoeritroblástica y no se nos hace referencia a los típicos tricoleucocitos (opción 4 incorrecta).

114. Un varón de 55 años consulta por astenia, plenitud abdominal e infecciones respiratorias y urinarias recurrentes. Analíticamente destaca una pancitopenia con reticulocitos disminuidos y en la exploración presenta una esplenomegalia

moderada. El aspirado de médula ósea resulta seco y en la biopsia de médula ósea se identifica una infiltración por células CD19+, CD20+, CD22+, CD25+ y CD103+. ¿Cuál de los siguientes genes es más probable que esté mutado?:

1. BCL2.
2. BRAF.
3. MYC.
4. MYD88.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pancitopenia, esplenomegalia y aspirado seco de médula ósea debe hacernos pensar en tricoleucemia, todo ello reforzado por la expresión de CD103+ en las células neoplásicas, algo prácticamente exclusivo de dicha enfermedad. El gen que con mayor frecuencia se encuentra mutado en este trastorno es el gen BRAF.

115. Indique cuál de estas afirmaciones no es correcta respecto la Gammapatía monoclonal de significado incierto:

1. Siempre deben tratarse ya que hasta el 25% de ellas evolucionan a Mieloma múltiple.
2. Es la forma más frecuente de gammapatía monoclonal.
3. Cuando el componente monoclonal es IgM o IgA existe mayor riesgo de progresión a mieloma.
4. La concentración de proteína monoclonal es factor de riesgo para la progresión a mieloma.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Las opciones 2, 3 y 4 son correctas. Respecto a la opción 1, dado que la GMSI no se considera realmente una enfermedad, no habría que tratarla, simplemente hace un seguimiento para vigilar que no evolucione a mieloma.

116. En cuál de los siguientes pacientes considera menos indicado un estudio de trombofilia o hipercoagulabilidad:

1. Mujer de 35 años con abortos de repetición y muerte fetal en el octavo mes de la gestación.
2. Varón de 50 años que presenta una trombosis venosa profunda durante el tratamiento de un Linfoma del Manto.
3. Mujer de 41 años con antecedentes de TEP sin causa detectable.
4. Varón de 18 años que presenta una TVP en miembro inferior tras inmovilización con escayola por una fractura de tibia, a pesar de tratamiento profiláctico con heparina de bajo peso molecular.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

De los casos clínicos expuestos, debemos sospechar trombofilia en el caso de mujeres con abortos de repetición, trombosis sin causa aparente, y trombosis a pesar de tratamiento con heparina (además de muchas otras situaciones que tenéis en el manual). El cáncer es un factor de riesgo protrombótico, por lo que la opción 2 no requeriría estudio alguno.

117. Un paciente con hemofilia A grave conocida e inhibidor en alto título acude al servicio de Urgencias por cuadro de dolor, impotencia funcional y aumento de volumen en la rodilla izquierda. Se realiza ecografía articular que confirma la presencia de hemartros. Respecto al tratamiento de este paciente, en sesión clínica se plantea el uso de Emicizumab. Señale la afirmación correcta respecto a este fármaco:

1. Se une al FIX activado y al FX para restaurar la función del VIII.
2. Se encuentra indicado para la profilaxis en hemofilia A grave con y sin inhibidor.
3. Se administra de forma subcutánea.
4. Es útil en hemorragias agudas.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Emicizumab es el primer anticuerpo monoclonal aprobado para la Hemofilia A con y sin inhibidor (opción 2 correcta). Se administra de forma subcutánea y actúa simulando la acción del FVIII para permitir la unión entre el FIX y el FX y así activar la vía común (opción 1 y 3 correcta). Sin embargo, Emicizumab solo es útil como prevención de los sangrados. En el caso de que el paciente tenga una hemorragia que requiera tratamiento, habrá que seguir usando concentrados de FVIII (si no tiene inhibidor) o agentes bypass (si tiene inhibidor). La opción que debéis señalar es la 4.

118. ¿Cuál de los siguientes pacientes tiene MENOS indicación de profilaxis para endocarditis infecciosa?:

1. Paciente portador de TAVI que va a someterse a una colonoscopia diagnóstica.
2. Paciente portador de marcapasos que va a ser sometido a un procedimiento odontológico que involucra la encía.
3. Paciente con antecedente de cardiopatía corregida pero con defecto residual que va a ser sometido a broncoscopia diagnóstica.
4. Paciente con válvula aórtica bicúspide que va a ser sometido a un procedimiento odontológico que perfora la mucosa.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Recuerda que hasta las guías de 2023, no se consideraban otros procedimientos fuera de los odontológicos que perforen

la mucosa o involucren la encía o la región periapical del diente. Actualmente sí se consideran procedimientos diagnósticos o terapéuticos genitourinarios, digestivos, respiratorios. Por otro lado se han ampliado los pacientes que se consideran de alto riesgo (TAVI, marcapasos, DAI.), no obstante NO se consideran de alto riesgo las válvulas bicúspide, la CIA, CIV, prolapso mitral. etc.

119. ¿Con respecto a sulbactam/durlobactam cuál de las siguientes afirmaciones es CIERTA?:

1. Es una buena alternativa para el tratamiento de una neumonía adquirida en la comunidad en pacientes con fibrosis quística.
2. El sulbactam es un inhibidor de betalactamasas por lo que no tiene actividad sobre *Acinetobacter baumannii*.
3. Se debe administrar junto con la ampicilina.
4. Es una buena alternativa para el tratamiento de neumonía nosocomial por *Acinetobacter baumannii*.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Sulbactam/durlobactam es un nuevo fármaco para el tratamiento del complejo *Acinetobacter baumannii*, indicado para neumonía bacteriana adquirida en el hospital y neumonía bacteriana asociada a la ventilación mecánica.

120. En cuanto a la duración de la terapia antibiótica en un paciente diagnosticado de neumonía adquirida en la comunidad leve, ¿cuál le parece la afirmación más oportuna?:

1. Se mantendrá la terapia antibiótica hasta que el paciente se encuentre afebril al menos 24 horas antes de suspenderla.
2. La duración vendrá determinada por la situación clínica y la respuesta del paciente al tratamiento antibiótico. En cuadros leves, se estima entre 5 y 7 días.
3. La duración vendrá determinada por la disminución marcada en la analítica de sangre de la PCR. En cuadros leves se estima entre 5 y 7 días.
4. La duración vendrá determinada por la situación clínica y la respuesta del paciente al tratamiento antibiótico. En cuadros leves se estima entre 7 y 10 días.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La duración del tratamiento debe individualizarse y basarse en criterios de estabilidad clínica, con un mínimo de 5 días y pudiéndose suspender tras 48h de ausencia de fiebre y sin signos de inestabilidad. En caso de neumonía necrosante, absceso pulmonar, microorganismos no comunes (*Pseudomonas*, *S. aureus*, anaerobios.) se debe prolongar el tratamiento. La procalcitonina puede ser útil en la toma de

decisiones en la duración del tratamiento. En caso de usar macrólidos las pautas son de 3 días.

121. Varón de 35 años que acude a Urgencias por presentar secreción uretral y disuria de 7 días de evolución. Refiere haber tenido relaciones sexuales de riesgo hace 2 semanas. Dado que en su servicio de Urgencias tiene disponibilidad de recoger muestras microbiológicas, decide hablar con microbiología para que le haga un gram urgente de la muestra uretral. El laboratorio de microbiología le comunica que no observa diplococos gram negativos. Con esta información usted decide administrar la siguiente pauta antibiotica:

1. Ceftriaxona 1 g intramuscular monodosis + 1 gramo de azitromicina por vía oral monodosis.
2. Ceftriaxona 500 mg intramuscular monodosis + doxiciclina 100 mg/12 horas durante 7 días.
3. Azitromicina 1g vía oral monodosis.
4. Doxiciclina 100mg/12 horas durante 7 días.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

El tratamiento empírico actual de elección de la uretritis es ceftriaxona 500 mg IM dosis única + doxiciclina 100 mg/12 horas vo durante 7 días. Actualmente no se recomienda como primera opción la azitromicina en tratamiento empírico por mayor riesgo de inducir resistencias en *Mycoplasma genitalium*. En caso de disponer de tinción de Gram en un exudado en un paciente con clínica de uretritis si se visualizan diplococos Gram negativos intracelulares y/o se observan 5 leucocitos por campo en secreción uretral y/o 10 leucocitos/campo en sedimento de orina se debe administrar tratamiento con ceftriaxona 500 mg IM dosis única. Si no se visualiza lo previo: Tratamiento con doxiciclina 100 mg/12 horas vo durante 7 días. En estos casos se debe realizar control a la semana para ajustar el tratamiento en función de los resultados definitivos microbiológicos. Aunque diversas guías en nuestro entorno recomiendan tratamiento generalizado del gonococo con ceftriaxona 1g en dosis única, un reciente estudio ha demostrado que en nuestro medio, la tasa de resistencia a ceftriaxona sigue siendo insignificante, por dicho motivo, se recomienda dosis de ceftriaxona de 500 mg. Esta dosis es suficiente para alcanzar niveles efectivos en el caso del tratamiento de la uretritis. Tras el tratamiento se recomienda revisión a las 3 semanas. Si el paciente está asintomático no es necesario repetir cultivos de control.

122. Con respecto a la quimioprofilaxis en la meningitis meningocócica ¿cuál de las siguientes afirmaciones es CIERTA?:

1. En caso de que en un centro de estudios (diferentes a guarderías y escuelas infantiles) se diagnostiquen dos casos de meningitis meningocócica, se consideran contactos estrechos todos los alumnos y profesores del centro y deben recibir quimioprofilaxis.

2. Se consideran contactos estrechos y, por tanto, deben recibir quimioprofilaxis los niños menores de 6 años y personas que comparten un mismo aula que el caso índice.
3. El antibiótico de elección para la quimioprofilaxis es el ciprofloxacino.
4. En caso de recibir quimioprofilaxis no es necesario revisar el estado vacunal del contacto.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La quimioprofilaxis está recomendada en contactos estrechos. Se debe iniciar en las primeras 24h desde la aparición del caso índice. La vacunación se recomienda en contactos estrechos que están correctamente vacunados junto con la quimioprofilaxis. Se considera contacto estrecho: en guarderías y escuelas infantiles (hasta 6 años de edad): todos los niños y personal del aula. Si aparece otro caso en otra aula se considerará como contactos cercanos a todos los niños y personal de la guardería o de preescolar. En el resto de centros de estudio si aparece un caso en el centro se considerarán contactos cercanos a los compañeros que tengan un contacto frecuente. Si aparecen dos casos en el mismo centro, se considerarán contactos cercanos todos los alumnos de las aulas de donde proceden los casos y a sus profesores. Si aparecen tres o más casos en el plazo de un mes, en al menos dos aulas, se considerará como contactos cercanos a todos los alumnos y personal del centro.

123. Con respecto a la profilaxis preexposición (PrEP), señale la opción correcta:

1. La PrEP a demanda no ha demostrado ser coste-eficaz.
2. El uso de cabotegravir long-acting inyectable semanal es una opción que ha obtenido buenos resultados en la prevención del VIH.
3. Los programas de PrEP no deben incluir otras medidas, tales como el uso del preservativo, la circuncisión masculina...
4. El lenacapavir puede ser muy útil en usuarios con problemas de adherencia.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Se ha demostrado que el uso de cabotegravir im cada 2 meses (long acting) es superior frente a TDF/FTC para la prevención del VIH (opción 2 falsa). Además, en numerosos estudios se ha puesto de manifiesto que la PrEP con TDF/FTC diaria o a demanda resulta ser coste-eficaz (opción 1 falsa). En todo programa de PrEP se deben implementar otras medidas, tales como fomentar el uso del preservativo, promover la circuncisión masculina... (opción 3 falsa). El lenacapavir, un inhibidor de la cápsida del VIH, ha demostrado ser eficaz para prevenir la infección por VIH y es una buena opción para los pacientes con problemas de adherencia, ya que se administra cada 6 meses (opción 4 correcta). Sin embargo, aún no está aprobado para su uso en nuestro medio.

124. Existen algunas situaciones en las que se permite administrar lactancia materna en una mujer con infección por VIH. Señale cuál de los siguientes no es un criterio para ello:

1. Historia de adherencia a TAR excelente.
2. Supresión viral el mayor tiempo posible y, como mínimo, desde el segundo trimestre de embarazo.
3. Compromiso de vinculación postparto y posibilidad de apoyo en la lactancia y/o experiencia previa en lactancia.
4. Disposición a realizar un estrecho control analítico con carga viral plasmática mensual en la madre hasta finalizar el periodo de lactancia.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Actualmente, se puede no contraindicar lactancia materna en pacientes con VIH si cumple todos los criterios siguientes: 1. Historia de adherencia a TAR excelente. 2. Supresión viral el mayor tiempo posible, y como mínimo el tercer trimestre del embarazo. 3. Compromiso de vinculación postparto y posibilidad de apoyo en la lactancia y/o experiencia previa en lactancia. 4. Disposición de consultores de lactancia que eviten los problemas más frecuentes dentro de la lactancia y especialmente en los primeros meses. 5. Disposición a realizar un estrecho control analítico con CVp mensuales en la madre hasta finalizar el periodo de lactancia y recomendable una carga viral a los 2 meses del cese de la misma.

125. ¿Cuál de los siguientes es un criterio menor de DUKE?:

1. PET/TAC con imagen metabólica activa al segundo mes de implantación de una válvula protésica.
2. TAC cardiaco con aneurisma valvular.
3. Títulos de anticuerpos IgG anti fase I de *Coxiella burnetti* > 1:800.
4. 2 hemocultivos positivos para *Haemophilus* spp.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Recuerda en 2023 se actualizaron los criterios de DUKE, son criterios mayores aquellos criterios microbiológicos como los indicados en la opción 3 y 4. También son criterio mayor el hallazgo de una vegetación, perforación, aneurisma, pseudoaneurisma, insuficiencia, dehiscencia, absceso o fístula intracardiaca en pruebas de imagen. Con respecto al PET/TAC es criterio mayor cuando la captación sucede transcurrido los 3 meses de la implantación valvular, siendo criterio menor cuando la captación es dentro de los 3 primeros meses tras la cirugía.

126. Cuando se realiza un cribado de ITS, se debe incluir serología de VIH, sífilis, hepatitis y, además, técnicas moleculares para la detección

en muestras de localizaciones de prácticas sexuales (faringe, ano, vagina y orina) de:

1. Gonococo.
2. Linfogranuloma venéreo.
3. *Mycoplasma genitalium*.
4. Herpes simple.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

El cribado de ITS en población asintomática debe incluir siempre serología de VIH, sífilis y hepatitis en función de antecedentes (VHA y VHB/VHD) y criterios de riesgo (VHC), así como la realización de técnicas moleculares para la detección de gonococo y clamidia en las localizaciones determinadas por las prácticas sexuales (faringe, vagina, recto y orina). No se recomienda incluir en el screening: linfogranuloma venéreo, *Haemophilus ducreyi*, *Klebsiella granulomatis*, *Phthirus pubis*, *Sarcoptes scabiei*, *Mycoplasma genitalium* y virus del herpes simple.

127. ¿Cuál de las siguientes opciones NO cubre el Cefiderocol?:

1. *Pseudomonas*.
2. *S. mantophila*.
3. BLEEs.
4. Anaerobios.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

El cefiderocol es una cefalosporina de 6ª generación. Cubre la mayoría de carbapenemasas, las BLEEs, *Pseudomonas* y *S. mantophila*. No tiene actividad frente anaerobios.

128. Paciente de 28 años asintomático, su pareja habitual ha tenido una uretritis por *M. genitalium* por lo que se realiza cribado, siendo nuestro paciente positivo. Dada el aumento de resistencias a macrólidos en nuestro medio se determina la presencia de mutaciones, que confirma la resistencia a los macrólidos. Con esta información ¿cuál es la actitud más correcta?:

1. Dado que el paciente está asintomático no tiene indicación de tratamiento.
2. Doxiciclina 100 mg cada 12 horas durante 7 días, seguido de azitromicina 1 gramo vía oral en dosis única y posteriormente 500 mg vía oral cada 24 horas durante 3 días más.
3. Moxifloxacino 400 mg por vía oral una vez al día durante 7-14 días.
4. Doxiciclina 100 mg cada 12 horas durante 7-14 día.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Con respecto al *Mycoplasma genitalium* se debería realizar diagnóstico microbiológico en caso de sintomatología (UNG recurrente, cervicitis recurrente y en enfermedad

pélvica inflamatoria). En cambio no está indicado el cribado de infección por *M. genitalium* en personas asintomáticas, así como tampoco en muestras extragenitales. Únicamente está indicado el cribado en pacientes que hayan sido contacto sexual de un caso con diagnóstico confirmado de infección por *M. genitalium*. La resistencia a los macrólidos ha aumentado progresivamente en Europa, con tasas que superan el 50% en algunos países. Es por eso que siempre que sea posible se debe determinar la presencia de mutaciones 23S rRNA que confieren resistencia a los mismos. Tienen indicación de tratamiento en caso de sintomatología o pacientes asintomáticos con test positivo siendo pareja sexual de persona sintomática. El régimen recomendado para el tratamiento de la infección por *M. genitalium* no complicada (uretra, recto, cérvix) es, en caso de sensibilidad a macrólidos conocida o sensibilidad desconocida: doxiciclina 100 mg cada 12 horas durante 7 días, seguido de azitromicina 1 gramo vía oral en dosis única y posteriormente 500 mg vía oral cada 24 horas durante 3 días más. Si existe resistencia a macrólidos o si el tratamiento con azitromicina ha fracasado: moxifloxacin 400 mg por vía oral una vez al día durante 7-14 días.

129. Luis tiene 43 años, es un paciente que sigues en tu consulta de VIH. El paciente está en tratamiento con tenofovir + emtricitabina y rilpivirina. Tras presentar en varias analíticas carga viral detectable, recibes el test de resistencias en el que se confirma la resistencia farmacológica comprobada a varios antirretrovirales, ¿cuál es la estrategia recomendada?:

1. Monoterapia con un fármaco nuevo al que no sea resistente.
2. Combinación de al menos dos fármacos nuevos.
3. Suspender el tratamiento actual y repetir analítica en 2 meses.
4. Cambiar solo uno de los fármacos del régimen actual.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Ante un fracaso del tratamiento por resistencias se deben cambiar al menos dos fármacos. Recuerda que la monoterapia no es una opción válida de tratamiento ni se debe interrumpir el tratamiento.

130. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los opioides mayores es INCORRECTA?:

1. La morfina sigue siendo el estándar de oro en el tratamiento del dolor severo.
2. El fentanilo transdérmico es una opción segura en pacientes con insuficiencia renal avanzada.
3. La buprenorfina es un agonista total de los receptores opioides μ .
4. El tapentadol tiene un mecanismo de acción dual, útil en el dolor neuropático.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Recordad que la buprenorfina es un agonista PARCIAL de los receptores opioides μ . Las demás son correctas. La morfina sigue siendo un fármaco muy útil en el tratamiento de tercer escalón y generalmente es considerado “gold estándar” por su versatilidad y precio. El fentanilo transdérmico es seguro en insuficiencia renal y no precisa ajuste de dosis hasta alcanzar $FG < 10$ ml/min. El tapentadol además de ser agonista de receptores opioides μ , inhibe la recaptación de noradrenalina, lo que lo hace útil en el tratamiento del dolor neuropático.

131. Un varón de 72 años con antecedentes de cardiopatía isquémica hace años pero con FEVI del 35%, FA anticoagulada, Enfermedad Renal Crónica estadio III y DM tipo 2 insulínodépendiente, que acude para ser intervenido de resección colónica por neoplasia de colon. Es independiente para todo pero se fatiga con mínimos esfuerzos. ¿Cuál es la clasificación ASA más adecuada para este paciente?:

1. ASA II.
2. ASA II.
3. ASA IV.
4. ASA V.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La opción 4 la podemos descartar directamente porque un ASA V hace referencia a un paciente moribundo (generalmente pacientes que vienen vía urgencias muy graves). La opción 1 también la podemos descartar porque un ASA II engloba a aquellos pacientes con enfermedades más “leves” (HTA, DM, obesidad...). Podemos dudar entre ASA III y ASA IV ya que ambos grados de riesgo anestésico engloban las mismas enfermedades (cardiopatía isquémica, ERC avanzada, ICC, EPOC...) la diferencia viene dada por el “grado de esa enfermedad” es decir, si supone o no una amenaza CONSTANTE para la vida. Si la cardiopatía isquémica tuviese una FEVI preservada y si además el paciente no estuviese “descompensado” (nos dicen que se fatiga con mínimos esfuerzos) el paciente podría ser un ASA III; pero una FEVI reducida automáticamente se convierte en un riesgo constante para la vida, y más aún si la clínica sugiere descompensación (respuesta 3 verdadera). Recordamos además que el riesgo anestésico (valorado mediante la clasificación ASA) no tiene nada que ver con el tipo de cirugía a la que se va a someter el paciente.

132. Mujer de 81 años sin deterioro cognitivo e independiente para ABVD que acude a consulta por debilidad generalizada y dos caídas en el último mes. Refiere dificultad para subir las escaleras. En exploración se objetiva fuerza muscular reducida en extremidades inferiores. La bioimpedanciometría muestra

una disminución significativa del índice de masa muscular esquelética. Según el algoritmo diagnóstico de sarcopenia propuesto por el European Working Group on Sarcopenia in Older People (EWGSOP2), ¿cuál es el siguiente paso para confirmar el diagnóstico de sarcopenia severa?:

1. Solicitar una RNM muscular.
2. Valorar el rendimiento físico mediante el test de la velocidad de la marcha o el Short Physical Performance Battery (SPPB).
3. Realizar una densitometría ósea para descartar osteoporosis asociada.
4. Repetir la bioimpedanciometría tras una prueba de carga proteica.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Tenemos una paciente con sospecha inicial de sarcopenia que presenta fuerza muscular reducida en los test que se le hayan realizado (no nos los dice). Posteriormente se ha confirmado la sarcopenia mediante una prueba propiamente dicha, que en este caso ha sido la impedanciometría. Por lo tanto, el diagnóstico de sarcopenia YA ESTÁ confirmado. Ahora nos preguntan: ¿Cuál es el siguiente paso para confirmar el diagnóstico de sarcopenia SEVERA? Recordamos que una vez tenemos el diagnóstico de sarcopenia, para catalogarla como sarcopenia “a secas” o sarcopenia “severa” hay que someter al paciente a pruebas de rendimiento físico (velocidad de la marcha, SPPB o TUG). Por lo tanto, la respuesta correcta es la 2.

133. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre las instrucciones previas es correcta?:

1. Su cumplimiento depende de la aprobación del Comité de Ética Asistencial.
2. Pueden ser revocadas solo por decisión judicial.
3. El médico debe respetarlas, siempre que no sean contrarias a la ley o a la situación clínica del paciente.
4. Prevalece la opinión de la familia sobre el documento.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

El médico debe seguir las instrucciones previas siempre que sean legales y adecuadas al estado clínico actual, es decir, no se puede aplicar por ejemplo la eutanasia por mucho que lo haya pedido el paciente si este no cumple los requisitos legales para la misma. El documento prevalece sobre opiniones de terceros, incluida su familia. El Comité de Ética no tiene ninguna cabida en el testamento vital. Sus funciones son, asesorar en la toma de decisiones en procesos que planteen conflictos éticos, elaborar protocolos de actuación y formar en Bioética.

134. Varón de 82 años con demencia avanzada, sin capacidad para comunicarse ni tomar decisiones. Está institucionalizado y presenta un cuadro de neumonía nosocomial grave. El equipo médico valora no iniciar antibioterapia ni medidas invasivas. En su historia clínica consta un documento de voluntades anticipadas, en el que expresa que no desea medidas que prolonguen la vida si no hay posibilidad de recuperación funcional. La hija del paciente se muestra en desacuerdo y exige que se intente todo lo posible. ¿Cuál es la conducta médica más adecuada?:

1. Cumplir con la voluntad de la hija y comenzar antibioterapia intravenosa.
2. Aplicar la voluntad anticipada del paciente y registrar la AET en la historia clínica.
3. Solicitar autorización judicial para la suspensión del tratamiento.
4. Iniciar tratamiento paliativo y notificar a la familia que se aplicará sedación paliativa.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

El paciente no tiene capacidad conservada para la toma de decisiones en el momento actual (demencia avanzada) pero su voluntad anticipada prevalece según lo indicado en su testamento vital (respuesta 2 verdadera). El documento de voluntades anticipadas prevalece sobre la opinión de terceros, incluyendo familiares como su hija (1 falsa). Tampoco es necesario avisar el Juez al contar en este caso con el documento de voluntades previas. Además, en este caso clínico (demencia avanzada, fragilidad y cuadro grave con mala evolución), la AET está justificada, y se debe dejar constancia en la historia clínica, aunque la familia no esté de acuerdo. Lo que no es correcto es directamente iniciar una sedación paliativa. El hecho de no iniciar o retirar antibioterapia (es decir, adecuación) no implica que directamente tengamos que iniciar la sedación. La sedación paliativa se indica ante un síntoma REFRACTARIO que no podemos controlar de otra forma que no sea bajando el nivel de consciencia del paciente. Por ejemplo, en este caso, se podría indicar AET no iniciando antibioterapia y manteniendo solo tratamiento analgésico, antitérmico y control de disnea con morfina y O₂. Si a pesar de rescates de morfina el paciente presentara disnea no controlada se podría plantear entonces la sedación. También puede ocurrir con otro síntoma que no sea la disnea, como por ejemplo delirium a pesar de rescates de neurolépticos.

135. Acude a urgencias un varón de 67 años con carcinoma pulmonar metastásico en tratamiento paliativo. Acude a urgencias por disnea progresiva de una semana de evolución que en las últimas 24h se ha hecho de mínimos esfuerzos. Asocia dolor torácico y pleurítico derecho. A su llegada presenta TA 80/50 mmHg, FC 120 lpm, 30 rpm, SatO₂ 86% basal y T de 36,7°C.

En exploración evidenciamos extremidades frías, palidez y llenado capilar lento. Ruidos cardiacos apagados e ingurgitación yugular marcada. Se realiza ecocardiografía a pie de cama que muestra derrame pericárdico masivo con colapso diastólico de cavidades derechas. Respecto al tipo de Shock que presenta el paciente y su fisiopatología, señale la respuesta correcta:

1. Se trata de un shock hipovolémico con presión venosa central disminuida y gasto cardiaco elevado por taquicardia compensadora.
2. Se trata de un shock cardiogénico por disfunción directa del miocardio, con presión capilar pulmonar elevada y resistencia vascular periférica disminuida.
3. Se trata de un shock distributivo con gasto cardiaco bajo por vasodilatación sistémica y presión venosa central baja.
4. Se trata de un shock obstructivo con presión venosa central elevada, gasto cardiaco reducido y resistencia vascular periférica aumentada.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Nos están contando a un paciente que presenta un shock obstructivo por taponamiento cardiaco. Recordamos que en este tipo de shock vamos a encontrarnos una presión venosa central (PVC) elevada, una resistencia vascular periférica (RVP) aumentada (paciente pálido y frio) y un gasto cardiaco (GC) reducido, entre otras cosas (respuesta 4 verdadera). El resto de opciones son falsas porque nuestro paciente no tiene ni un shock hipovolémico, ni cardiogénico ni distributivo.

136. ¿Cuál de las siguientes combinaciones de fármacos es incorrecta según las recomendaciones generales?:

1. Tramadol + paracetamol.
2. Morfina + ibuprofeno.
3. Codeína + tapentadol.
4. Fentanilo + paracetamol.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Tanto el segundo como el tercer escalón de la escalera analgésica de la OMS pueden combinarse con el primero. Sin embargo, no deben mezclarse fármacos del segundo y tercer escalón, es decir, opioide menor con un opioide mayor. Existen excepciones, pero siempre deben realizarse por equipo experto y con estrecha monitorización.

137. Con respecto a la neurotoxicidad inducida por opioides (NIO), señala la opción correcta:

1. Las mioclonías provocadas por opioides no tienen tratamiento específico.

2. El delirium asociado a opioides se maneja principalmente con benzodiazepinas.
3. La hiperalgesia inducida por opioides (HIO) se sospecha cuando hay dolor intenso sin progresión de la enfermedad.
4. La rotación de opioides es una estrategia ineficaz en el manejo de la NIO.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La HIO es reacción paradójica en la que puede aparecer hiperalgesia (respuesta desproporcionada ante un estímulo doloroso) y/o alodinia (dolor provocado por estímulos que normalmente no causarían dolor). Se debe sospechar cuando hay mucho dolor en ausencia de progresión de enfermedad o dolores inexplicables y muy intensos. Las demás respuestas son falsas. Las mioclonías producidas en casos de NIO se pueden tratar con benzodiazepinas. El tratamiento del delirium se hace con neurolepticos. En el manejo de la NIO una de las opciones más útiles es la rotación de opioide (sobre todo eligiendo alguno que no tenga metabolismos activos).

138. ¿Cuál de los siguientes perfiles clínicos permite diferenciar con mayor precisión un síndrome simpaticomimético de un síndrome hipnótico-sedante, considerando también la respuesta autonómica y neuromuscular del paciente?:

1. Hipertensión, midriasis, diaforesis, hiperreflexia y agitación.
2. Hipotensión, miosis, depresión respiratoria, somnolencia e hipotonía.
3. Hipertensión, pupilas isocóricas, bradipnea e hiporreflexia.
4. Midriasis, taquicardia, sequedad de mucosas, retención urinaria y alucinaciones.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

La respuesta 1 nos describe claramente la sintomatología derivada de un síndrome simpático mimético que, como su propio nombre indica, cursa con una "hiperactivación" del sistema simpático (respuesta 1 verdadera). La respuesta 2 es falsa porque nos está describiendo sintomatología típica del síndrome hipnótico-sedante (bloqueo/inhibición del sistema simpático). La respuesta 3 es falsa porque no debería haber bradipnea sino taquipnea. Por último, la respuesta 4 es falsa porque nos están describiendo un síndrome anticolinérgico o síndrome seco; su mecanismo de acción no tiene nada que ver con el sistema simpático, sino con el parasimpático.

139. Un paciente de 42 años es encontrado en la calle tras haber pasado la noche a la intemperie con temperaturas bajo cero. En urgencias presenta una temperatura de 30°C, frecuencia cardiaca de 36 lpm, TA de 90/60 mmHg y frecuencia respiratoria de 8 rpm. Está bradipsíquico, responde con dificultad. El ECG muestra ondas

J de Osborn. ¿Cuál es la actitud terapéutica más adecuada?:

1. Administrar líquidos intravenosos y realizar recalentamiento externo pasivo con mantas térmicas.
2. Iniciar recalentamiento con líquidos intravenosos templados, oxígeno humidificado caliente y medidas de soporte.
3. La presencia de ondas J de Osborn obliga a iniciar RCP y preparar desfibrilador hasta que la temperatura aumente por encima de los 35°C, por riesgo elevado de fibrilación ventricular.
4. Administrar midazolam iv y posterior lavado gástrico con suero templado, además de sueroterapia iv templada.

Respuesta correcta: 2**Comentario:**

Un paciente con una temperatura de 30°C es un paciente con una hipotermia grave. El tratamiento implica soporte vital, calentamiento y tratamiento de las complicaciones. Tanto la opción 1 como la opción 2 podrían ser medianamente correctas; pero entendemos que la opción 2 es MUCHO más correcta ya que nos dicen que el líquido intravenoso tiene que ser “templado” (dato importante en el tratamiento de la hipotermia y que no nos dicen en la respuesta 1). La respuesta 3 es falsa ya que las ondas J de Osborn visibles en el ECG son simplemente muy específicas de la hipotermia, pero no nos dan información terapéutica ni hay que hacer nada con ellas. La respuesta 4 no tiene ningún sentido ya que no vamos a calentar un cuerpo metiendo una SNG con líquido templado si puedo administrarlo iv, y mucho menos si el paciente tiene bajo nivel de conciencia y puede broncoaspirarse.

140. ¿Qué característica tiene el documento de voluntades anticipadas o testamento vital?:

1. Permite al paciente expresar decisiones sobre su salud en caso de incapacidad futura.
2. Es obligatorio para todos los ciudadanos mayores de edad.
3. Solo es válido si se realiza ante notario.
4. Debe ser firmado exclusivamente por familiares del paciente.

Respuesta correcta: 1**Comentario:**

Pregunta para repasar conceptos básicos. En este documento el paciente (mayor de edad y en plenas facultades mentales) manifiesta su voluntad respecto a las decisiones que pudieran tomarse en un futuro sobre su salud, principalmente en torno a decisiones en el final de la vida, o en el caso de fallecimiento sobre el destino de su cuerpo y/o sus órganos, con el objeto de que esta voluntad se cumpla en el caso de que él no pueda decidir por sí mismo o no pueda expresarlo. NO es obligatorio (2 falsa). Deberán constar por escrito y pueden realizarse de 3 formas (3 falsa): ante notario, sin

ser necesario testigos, ante el personal de la administración pública o ante tres testigos mayores de edad y en plenas capacidades, dos de los cuales como mínimo no deberán ser familiares (hasta segundo grado), ni estar vinculados por matrimonio o similar, ni por intereses económicos. El documento debe ser firmado por el paciente (4 falsa) y se pueden designar representantes. En cualquier momento el autor puede modificar, sustituir o revocar sus instrucciones previas, dejando constancia por escrito. El médico deberá respetar las instrucciones previas establecidas por el paciente (siempre que sean acciones consideradas legales y no contraindicadas al estado o enfermedad del mismo). Dicho documento prevalece sobre la opinión de terceros.

141. Hombre de 75 años, sin alergias ni antecedentes médicos de interés, consciente y orientado, acude a urgencias con dolor abdominal. Se encuentra febril, con tendencia a la hipotensión y presenta abdomen en tabla a la exploración física. Se realiza una ecografía abdominal que confirma apendicitis aguda perforada. Se decide intervenir quirúrgicamente de forma urgente. El paciente comprende la situación pero se niega a firmar el consentimiento informado. ¿Qué debe hacerse en este caso?:

1. Pedir a su hija que firme en su lugar.
2. Respetar su decisión, documentando su negativa tras explicarle las consecuencias.
3. Solicitar autorización judicial urgente.
4. Iniciar la cirugía inmediatamente por tratarse de una urgencia.

Respuesta correcta: 2**Comentario:**

Si el paciente está capacitado, tiene derecho a aceptar o rechazar el tratamiento. Se debe explicar al paciente minuciosamente y de forma que sea capaz de comprender la información los detalles del diagnóstico, en qué consiste el tratamiento/procedimiento y cuáles son las posibles consecuencias de no realizarlo, incluyendo la posibilidad de evolución fatal si existe. Deben explicarse también posibles tratamientos alternativos si existen y su eficacia en comparación al tratamiento estándar ofrecido (por ej., en este caso, antibiótica intravenosa -menos efectiva que la cirugía en una apendicitis). Su negativa debe respetarse, tras documentarla adecuadamente.

142. Varón de 86 años con antecedente de HTA bien controlada, FA permanente, Enfermedad Renal Crónica con FG estimado de 22 ml/min e Hipertrofia Benigna de Próstata. Está en tratamiento con Amlodipino, Warfarina, Digoxina, Tamsulosina y Paracetamol. Acude a consulta refiriendo dos caídas en el último mes e hipotensión ortostática. El ECG realizado en consulta muestra un ritmo de FA a 65 lpm. La TA es de 150/80 mmHg. De acuerdo a los criterios STOPP/START, ¿cuál de las siguientes

actuaciones sería la más adecuada con respecto al manejo de este paciente?:

1. Retirar tamsulosina por riesgo de hipotensión ortostática y consiguientes caídas.
2. Añadir un IECA para optimizar el control de la tensión arterial, de acuerdo a criterios START.
3. Mantener digoxina antes que cambiarlo por un beta-bloqueante para el control de la frecuencia cardíaca.
4. Mantener anticoagulación con Warfarina por alto riesgo embólico, sin necesidad de revisión adicional.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

La respuesta correcta es la 1 porque, de acuerdo a los criterios STOPP, la tamsulosina (cualquier fármaco que sea un antagonista de los receptores alfa-1) hay que suspenderlos cuando el paciente presenta hipotensión ortostática (como nuestro paciente) o síncope. Vamos a ver porque el resto de respuestas son falsas. La respuesta 2 es falsa porque no hay motivo para AÑADIR un IECA ya que la TA del paciente es adecuada; si añadimos otro fármaco podríamos dejarle hipotenso. La respuesta 3 es falsa porque la digoxina no suele ser nunca el fármaco de elección para controlar la FC, siempre van por delante los beta-bloqueantes. La respuesta 4 es falsa básicamente por la última afirmación que dice "sin necesidad de revisión adicional". Efectivamente el paciente tiene una FA y debe estar anticoagulado (aunque la Warfarina no es el anticoagulante que más nos guste). No obstante, de acuerdo a los criterios STOPP, cuando un anciano empieza a tener caídas, muchas veces es preferible retirar la anticoagulación ya que el riesgo de sangrado post-traumatismo sobrepasa al riesgo de embolia por la FA. Por esta razón los pacientes anticoagulados y que empiezan a tener caídas, como mínimo hay que ir reevaluándoles en consulta cada cierto tiempo por si en algún momento consideramos que es mejor retirar ya la anticoagulación.

143. En la orquiepidimitis aguda , es falso que:

1. Es la causa más frecuente de escroto agudo en adultos.
2. Asocia sintomatología urinaria.
3. El dolor aumenta al elevar el testículo.
4. La doxiciclina es un tratamiento adecuado en los jóvenes.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La orquiepidimitis aguda constituye la principal causa de escroto agudo en varones adultos. La sintomatología urinaria es frecuente y en varones jóvenes debe siempre sospecharse ETS. No obstante la elevación del testículo no debería intensificar el dolor como sucede en la torsión.

144. En cuanto a la clasificación de los traumatismos renales según la asociación americana de

urología, ¿cuál de las siguientes correspondería a la gradación tipo III?:

1. Contusión o hematoma subcapsular no expansivo.
2. Hematoma perirrenal delimitado o laceración cortical renal que penetra <1cm en profundidad sin extravasación de urinaria.
3. Laceración cortical > 1 cm sin extravasación urinaria.
4. Laceración renal hacia el interior del sistema colector con extravasación urinaria o afectación arterial o venosa con hematoma contenido.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

En el traumatismo renal , la lesión grado 3 corresponde a una laceración superior a 1 cm sin extravasación urinaria.

145. ¿Cuál no es una complicación del alprostadil intracavernoso en el tratamiento de la disfunción eréctil?:

1. Dolor.
2. Erección prolongada.
3. Fibrosis de los cuerpos cavernosos.
4. Necrosis de glándula.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Entre los efectos secundarios descritos de derivados de prostaglandinas como el alprostadil se encuentra el dolor, la fibrosis peneana como consecuencia de la vía de administración intracavernosa, erección prolongada secundaria a su efecto vasodilatador. La necrosis de glándula es un efecto adverso poco frecuente que puede relacionarse con agentes vasoconstrictores o secundario a cirugía protésica del pene.

146. Varón de 69 años sin antecedentes de interés, salvo dislipemia. Presenta un tumor renal izquierdo de 65 mm en el polo inferior del riñón derecho, que en el estudio con TAC sugiere carcinoma de células renales con significativo crecimiento exofítico. La conducta más adecuada es:

1. Nefrectomía radical laparoscópica.
2. Vigilancia activa.
3. Nefrectomía parcial.
4. Biopsia del tumor.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Este paciente que presenta una lesión exofítica menor de 7 cm de diámetro localizada en el riñón podría ser candidato para una nefrectomía parcial.

147. Mujer de 32 años que presenta infección urinaria complicada por K. pneumoniae BLEE con

uropatía obstructiva que precisa colocar catéter doble J. Tras la resolución del cuadro y retirada del catéter sigue con orina con cultivo positivo por dicho germen, pero sin clínica infecciosa. ¿Cuál es la actitud a seguir?:

1. Tratar en pacientes ancianos.
2. Tratar en caso de embarazo o cirugía.
3. Tratar en portadores de catéter vesical.
4. No tratar.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La paciente persiste con bacteriuria asintomática tras resolución del cuadro agudo que únicamente se trataría si estuviera embarazada o fuera a someterse de nuevo a cirugía urológica.

148. ¿Cuál de estas complicaciones no se asocia clásicamente con la enfermedad renal crónica?:

1. Prurito.
2. Disfunción eréctil.
3. Tenesmo vesical.
4. Astenia.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Respuesta: 3. El tenesmo vesical se asocia a cistitis, cistocelos, radioterapia etc En la ERC en estadios avanzados es frecuente la poliuria que es indolora. El prurito se asocia a la ERC y es de causa multifactorial, la disfunción eréctil es frecuente debido a la alta calcificación vascular y la astenia en relación con la uremia y la anemia también está asociada a la ERC.

149. ¿Cuál de los siguientes no está descrito como un factor de riesgo de desarrollar ERC en pacientes previamente sanos?:

1. Enfermedad inflamatoria intestinal.
2. Bajo peso al nacer.
3. Diabetes gestacional.
4. Consumo de suplementos de creatina.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Respuesta: 4. Se ha objetivado en estudios observacionales la mayor prevalencia de ERC en individuos previamente sanos que desarrollan EII, DG o que tuvieron bajo peso al nacer. Existe controversia en cuanto al riesgo de ERC y consumo de suplementos de creatina pero parece que no hay un riesgo aumentado de ERC en población sana que consume estos suplementos. Sí que habrá que tener en cuenta que pueden presentar Creatininas séricas elevadas y por ende ser clasificados erróneamente con pacientes con ERC (para ello habrá que aplicar fórmulas que tengan en cuenta la creatinina sérica o el aclaramiento de creatinina en orina de 24 horas).

150. Un varón de 30 años con antecedentes de tabaquismo acude al servicio de Urgencias por un cuadro de astenia, náuseas, vómitos, disnea progresiva y hemoptisis ocasional desde hace 2 semanas. Ha recibido un ciclo antibiótico con mejoría parcial. Sin embargo su disnea progresa hasta hacerse de reposo con evidencia de insuficiencia respiratoria y hemoptisis persistente. Se procede al ingreso hospitalario. Se encuentra normotenso con una saturación basal de oxígeno de 89% que remonta a 95% con gafas nasales convencionales a 2lpm. Presenta crepitantes bibasales a la exploración con mínimo edema perimaleolar en miembros inferiores. En la analítica destaca Hb de 9 g/dL, plaquetas 340.000 u/L; leucocitos 6.500 u/L; Creatinina 7 mg/dL; Urea 190 mg/dL; Na 138 meq/L; K 5,7 mEq/L; HCO₃ 14 mmol/L. En el sedimento de orina presenta 20-30 hematíes por campo con cilindros hemáticos. En el sistemático de orina presenta 100 mg/dL de proteinuria. En la radiografía de tórax de objetiva un infiltrado alveolar bilateral. Se solicita estudio inmunológico con hallazgo de pANCA circulantes a título elevado y complemento normal. Una vez estabilizado el paciente se realiza una biopsia renal percutánea con presencia de semilunas epiteliales en un 30% de los glomérulos con presencia de necrosis fibrinoide. En la inmunofluorescencia directa se observa un depósito lineal de IgG en la membrana basal glomerular. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable?:

1. Poliangeitis microscópica.
2. Enfermedad de Goodpasture.
3. Granulomatosis con poliangeitis (Granulomatosis de Wegener).
4. Neumonía por Klebsiella Pneumoniae con nefropatía IgA dominante asociada a infección.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Respuesta: 2. Enunciado largo que presenta el caso de un síndrome renopulmonar (fracaso renal agudo con microhematuria de origen glomerular y hemorragia alveolar). La positividad de los pANCA nos puede hacer dudar entre la 1 y la 3 pero si seguimos leyendo vemos que la IF no es negativa, si no que hay un depósito lineal de IgG en la membrana basal glomerular, criterio diagnóstico de la enfermedad de Goodpasture. Hasta el 35% de los pacientes con glomerulonefritis antiMBG pueden tener pANCA circulantes. La respuesta 4 podría hacernos dudar por el antecedente de toma de antibioterapia y clínica respiratoria pero en la IF se tendrían que observar depósitos mensangiales de IgA. Por lo tanto la respuesta correcta es la 2.

151. Varón de 55 años natural de Huelva en tratamiento con ipilimumab desde hace 2 meses por diagnóstico reciente de melanoma estadio III. Hace 5 días refiere aparición de rash y dolor lumbar motivo por el que ha iniciado Ibuprofeno a dosis de 600 mg cada 8 horas. En la analítica se objetiva una Creatinina sérica de 2 mg/dL (previas en 1,2 mg/dL) con un cociente proteínas/creatinina de 800 mg/g de creatinuria. El sistemático de orina es anodino, sin presencia de bacterias y con mínima leucocituria. Se realiza ecografía abdominal que descarta patología obstructiva y muestra dos riñones de tamaño y características ecográficas normales. ¿Cuál es la mejor estrategia diagnóstica en este caso?:

1. Realizar una biopsia renal.
2. Solicitar un angioTC con contraste para descartar infarto renal.
3. Suspender ibuprofeno y repetir analítica en quince días.
4. Suspender ibuprofeno, mantener ipilimumab e iniciar prednisona a dosis de 1 mg/kg.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Respuesta: 1. El paciente presenta un fracaso renal agudo con proteinuria subnefrótica y leucocituria que orienta a síndrome tubular con el antecedente de toma de dos conocidos nefrotóxicos (AINEs e inmunoterapia, el ipilimumab es un anti CTLA-4). No hay datos de vasculopatía, manipulación endovascular o arritmias recientes, tampoco microhematuria que orienten a pensar en un posible infarto renal. En cambio, sí hay datos que orientan a nefritis tubulointersticial (rash, dolor lumbar posiblemente por infiltración, leucocituria etc). En este caso es preciso suspender tanto el ibuprofeno como la inmunoterapia, se podría plantear el inicio de corticoterapia sistémica si bien el diagnóstico final se obtiene a través del análisis histológico mediante biopsia renal que permite distinguir entre una nefritis tubulointersticial inmunomediada o inmunoalérgica, una necrosis tubular aguda u otras etiologías. Por lo tanto la respuesta correcta es la 1.

152. Una mujer caucásica de 42 años tiene antecedentes de hematuria microscópica y proteinuria de poca cuantía desde hace casi 20 años. En los últimos 5 años presenta peor control tensional y elevación progresiva de los niveles de creatinina sérica de 0,6 a 1,5 mg/dL (FGe 43 mL/min/1.73 m²). Su índice de masa corporal (IMC) es de 29 kg/m², pero no padece otras enfermedades crónicas. Se realiza una biopsia renal compatible con Nefropatía IgA con puntuación MEST-C M0, E0, S1, T1, C0. Su proteinuria ha aumentado recientemente de 0,3 a 1,9 gramos/día. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?:

1. Iniciar iSGLT2 en monoterapia.
2. Empezar una combinación de ciclofosfamida y prednisona porque su función renal se ha deteriorado.
3. Dado que tiene glomeruloesclerosis (S1) y atrofia tubular (T) no se beneficia de ningún tipo de tratamiento.
4. Realizar una evaluación de exhaustiva de su situación cardiovascular, aconsejar una dieta baja en sal, control de tensión arterial e iniciar inhibidores del eje renina angiotensina aldosterona.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Respuesta 4. Paciente con nefropatía IgA y proteinuria por encima de medio gramo al día. El primer paso (en ausencia de lesiones activas y rápido deterioro de la función renal) es el manejo del estilo de vida, control de TA, peso y tabaquismo así como iniciar tratamientos encaminados a disminuir la hiperfiltración (primero introducir iSRAA si el paciente los tolera, si no hay descenso de la proteinuria en 3 meses añadir iSGLT2). El MEST es un score pronóstico, no está validado para guiar el tratamiento médico por lo que la 3 es falsa. En ningún caso iniciar terapia inmunosupresora (no hay lesiones activas inflamatorias como semilunas epiteliales que lo justifiquen).

153. El uso generalizado de los inhibidores de la calcineurina ha permitido disminuir considerablemente la incidencia de rechazo de los trasplantes renal. Una de las siguientes no es un efecto adverso típicamente asociado al uso de esta medicación:

1. Microangiopatía trombótica.
2. Nefrotoxicidad.
3. Temblor.
4. Fragilidad capilar.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Respuesta: 4, la fragilidad se asocia más típicamente con el uso de corticosteroides en el trasplante, el resto son efectos secundarios descritos con el uso de inhibidores de la calcineurina.

154. En una zona del mundo donde la presión atmosférica es de 710 mmHg un paciente de 50 años se presenta en la sala de urgencias con una PaO₂ 40, una PaCO₂ 60 mmHg y un pH 7.20. Se calcula la presión alveolar de oxígeno que resulta ser de 42 mmHg. Entre las causas de insuficiencia respiratoria mencionadas más abajo, ¿cuál será la más probable?:

1. Una embolia de pulmón.
2. Tiene una crisis asmática grave.

3. Una neumonía extensa.
4. Una sobredosis de morfina.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

El paciente presenta una insuficiencia respiratoria. Lo primero para filiar el origen es conocer el valor de la PaCO₂, si esta elevada, como es el caso, implica hipoventilación. El segundo paso para saber si esa hipoventilación es de origen parenquimatoso o no es calcular el gradiente alveoloarterial. Al principio la pregunta asusta porque nos cambian la presión atmosférica, pero en este caso solo hay que restar la presión de O₂ alveolar (42mmHg) menos la PaO₂ 40. Por tanto, tenemos un gradiente de 2 mmHg, el cual es normal, por lo que nuestro paciente tiene un problema primario de hipoventilación. Las opciones de la 1 a la 3 describen patología parenquimatosa, por lo que la opción correcta será la 4, ya que la sobredosis de morfina produce una depresión respiratoria compatible con el caso clínico.

155. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con la fibrosis pulmonar idiopática (FPI)?:

1. Afecta principalmente a mujeres jóvenes, no fumadoras.
2. Presenta patrón radiológico en vidrio deslustrado difuso.
3. Es la EPID más frecuente y tiene mal pronóstico.
4. El lavado broncoalveolar suele mostrar eosinofilia marcada.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La FPI es la forma más común de EPID idiopática, afecta a varones mayores de 60 años, frecuentemente fumadores, y su patrón característico en TCAR es de panalización con patrón de neumonía intersticial usual (NIU). El pronóstico es malo y no responde bien a corticoides. El tratamiento es con antifibróticos.

156. En la neumonitis por hipersensibilidad, ¿cuál es el hallazgo celular típico en el lavado broncoalveolar?:

1. Predominio neutrófilos.
2. Predominio eosinófilos.
3. Cociente linfocitos CD4/CD8 aumentado.
4. Cociente linfocitos CD8/CD4 (invertido).

Respuesta correcta: 4

Comentario:

El lavado broncoalveolar en la neumonitis por hipersensibilidad suele mostrar un incremento de linfocitos, especialmente CD8+, es decir, se invierte el cociente de linfocitos siendo este caso CD8/CD4, lo cual ayuda a diferenciarla de otras EPID.

157. Acude a urgencias paciente de 53 años con disnea súbita y dolor torácico con los movimientos respiratorios. Su mujer nos comenta que esta mañana le han realizado una biopsia trasntorácica guiada por TAC de un nódulo pulmonar. Respecto al diagnóstico que usted sospecha, a la exploración física que esperaría encontrar:

1. Sibilancias bilaterales sobre todo inspiratorias.
2. Disminución del murmullo vesicular en el hemitórax derecho.
3. Estridor laríngeo.
4. Crepitantes secos bibasales.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta sobre semiología simple, el truco es saber de qué patología nos hablan. Si a un estudiante MIR le dicen paciente con disnea súbita y dolor torácico una voz en su interior le grita "TEP". Pero en esta ocasión hay que fijarse muy bien que se le acaba de realizar una biopsia pulmonar que nos debe hacer sospechar de neumotórax como complicación. Ante diagnóstico de neumotórax en la exploración física vamos a oír disminución de las vibraciones vocales o lo que es lo mismo disminución del murmullo vesicular (respuesta 2 correcta).

158. Paciente de 60 años, fumador de 30 paquetes/año, sin antecedentes relevantes, buena vida basal, derivado por su médico de familia por disnea y tos de meses de evolución. Se realiza TC de torax en el que se observa nódulo pulmonar espiculado, periférico, en lobulo inferior izquierdo. Se realiza espirometría con IT 69, FEV1 59%, DLCO 80%. Se realiza ergoespirometría objetivando VO2 max de 9 ml/kg/min. Se realiza estudio de extension donde se descarta afectación a distancia. Cual es la opcion correcta:

1. Puede ser un carcinoma epidermoide y dado que es un paciente con factores de riesgo y sin afectación a distancia, debemos realizar cirugía de resección.
2. Puede ser un adenocarcinoma y dado que es un paciente con factores de riesgo y sin afectación a distancia, debemos realizar cirugía de resección.
3. Puede ser un anaplasico, pero el paciente no es operable.
4. Puede ser un adenocarcinoma, pero no es reseccable.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Lo mas probable es que al ser un tumor periferico sea un adenocarcinoma o un tumor anaplasico (siendo mucho

mas frecuente un adenocarcinoma). Por otro lado hay que recordar la diferencia de resecabilidad y operabilidad --> El tumor puede o no ser RESECABLE por las características del TUMOR y el paciente puede o no ser OPERABLE por las características del PACIENTE. Un VO2 max < 10ml/kg/min o < 35% contraindica la cirugía, es un criterio de INOPERABILIDAD. A pesar de que en la opción 4 mencionan el tumor mas frecuente, en el caso clínico no hay datos de que irresecabilidad sino de INOPERABILIDAD.

159. Paciente varón de 55 años, que acude a Urgencias por fiebre de hasta 39°C, escalofríos, tos con expectoración verdosa, y dolor costal derecho que aumenta con la inspiración y con la tos. Se realiza analítica en la que se evidencia proteína C reactiva de 145 mg/L, leucocitosis con neutrofilia. Se realiza ecografía torácica observando broncograma aéreo dinámico en campo medio de hemitorax derecho asociado a derrame pleural de moderada cuantía. Se realiza toracocentesis en el que se objetiva LDH pleura/LDH suero 0,71, proteínas pleura/proteínas suero 0,60, pH 7,19, glucosa en líquido pleural 30mg/dL. ¿Cual sería el manejo mas adecuado?:

1. Se trata de una neumonía adquirida en la comunidad con derrame pleural paraneumónico, dado que es un paciente joven sin factores de riesgo, el tratamiento podría ser Amoxicilina/Clavulánico + Azitromicina.
2. Se trata de una neumonía adquirida en la comunidad + derrame pleural paraneumónico complicado, debemos iniciar tratamiento antibiótico y colocar un drenaje endotorácico.
3. Dado que tiene derrame pleural paraneumónico complicado debemos pautar antibioterapia con cobertura antipseudomónica como Piperacilina/Tazobactam.
4. Dado que tiene derrame pleural paraneumónico complicado debemos pautar antibioterapia y toracocentesis de repetición hasta objetivar resolución del mismo.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

El caso clínico se trata de un paciente con una neumonía adquirida en la comunidad + derrame pleural paraneumónico complicado, el tratamiento indicado es iniciar antibioterapia + colocación de un drenaje endotorácico. El líquido pleural tiene características de exudado según los criterios de light (LDH LP/LDH suero > 0.6, Prot. LP/Prot suero > 0,5) y además tiene criterios de complicación (pH < 7,20, Glucosa < 60 mg/dL). La opción 1 y 4 no son correctas porque además del tratamiento antibiótico debemos colocar un drenaje endotorácico, no realizar toracocentesis de repetición. La opción 3 es incorrecta porque el derrame pleural no es un criterio de cobertura antipseudomónica.

160. Mujer de 30 años con antecedentes de asma acude a urgencias por presentar tos, disnea intensa y sibilancias a pesar de tratamiento con agonistas Beta2 y corticoides inhalados. La gasometría de urgencias muestra pH 7,40 PaO2 60 mmHg PaCO2 55 mmHg. ¿Cuál es la actitud terapéutica más adecuada?:

1. Se debe administrar corticoterapia intravenosa y ver la respuesta.
2. Debemos añadir anticolinérgicos inhalados e intensificar el tratamiento con agonistas B2 y corticoides inhalados.
3. La primera medida a realizar será colocar oxigenoterapia.
4. Se debe contactar con una unidad de cuidados intensivos e iniciar tratamiento precoz.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta importante sobre la crisis asmática que debemos tener siempre presente. Uno de los criterios de extrema gravedad más importantes es la hipercapnia. Si una asmática tiene hipercapnia quiere decir que su sistema respiratorio está claudicando y necesitará ventilación mecánica, por lo que la primera medida será contactar con una unidad de cuidados intensivos (respuesta 4 correcta).

161. Varón de 22 años, previamente sano, que desarrolla en el último mes irritabilidad, dificultad de concentración y, más recientemente, alucinaciones visuales y auditivas, junto con marcada pérdida de memoria reciente. Presenta también movimientos anormales oro-faciales y en extremidades. Una RM craneal inicial es normal. ¿Cuál de las siguientes exploraciones complementarias es la MÁS útil para orientar el diagnóstico ante la sospecha que usted tiene?:

1. Electroencefalograma urgente.
2. Resonancia Magnética craneal de control precoz.
3. Estudio de autoanticuerpos específicos en líquido cefalorraquídeo (LCR) y suero.
4. Tomografía computarizada cerebral urgente.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

El caso clínico presentado sugiere fuertemente una encefalitis autoinmune. Pueden presentarse en pacientes jóvenes como cuadros clínicos que combinan síntomas psiquiátricos, alteraciones de la conducta, déficit de memoria y movimientos anormales. Es relevante que la resonancia magnética cerebral inicial puede ser normal en estos casos. Ante esta sospecha, la prueba complementaria más útil para orientar el diagnóstico, es el estudio de autoanticuerpos específicos en líquido cefalorraquídeo (LCR) y suero. La

positividad de los anticuerpos en sangre y LCR es la prueba más informativa para establecer el diagnóstico de encefalitis autoinmune.

162. Varón de 65 años que acude por un cuadro de rinorrea y tos sucedido de diplopía e inestabilidad. Se observa oftalmoparesia completa y ataxia cerebelosa. Los reflejos están abolidos. Señale la correcta:

1. Se trata de una encefalopatía de Wernicke desencadenada por un proceso viral.
2. Se trata de un síndrome de Miller Fisher.
3. Hay que evitar los sueros glucosados.
4. El tratamiento de elección son los corticoides.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

es la triada típica de Síndrome de Miller Fisher, ataxia, oftalmoparesia y arreflexia y el tratamiento son las IGIV o la plasmaféresis.

163. Señale la correcta en relación con enfermedades priónicas cerebrales:

1. La más frecuente es la enfermedad de Creutzfeldt Jakob esporádica.
2. Hay formas genéticas siendo la más frecuente el insomnio familiar fatal.
3. El tratamiento de elección son los corticoides y el rituximab que mejoran levemente el pronóstico.
4. La RM suele ser normal.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Hay formas genéticas, pero el IFF es raro, no tienen tratamiento y el pronóstico es infausto, la RM suele mostrar restricción en difusión en corteza y ganglios de la base.

164. Un paciente presenta pérdida de la sensibilidad termoalgésica en el hemicuerpo derecho y parálisis flácida de la hemilengua izquierda. ¿Dónde se localiza probablemente la lesión?:

1. Bulbo raquídeo izquierdo, afectando al nervio hipogloso y a las vías espinotalámicas.
2. Bulbo raquídeo derecho, afectando al nervio hipogloso y a las vías corticoespinales.
3. Hemisferio cerebral derecho, afectando a la corteza sensitiva y motora.
4. Médula cervical derecha, afectando al nervio hipogloso y a las vías espinotalámicas.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

La combinación de afectación de la hemilengua izquierda (nervio hipogloso) y pérdida termoalgésica contralateral (hemicuerpo derecho) indica una lesión a nivel del bulbo

raquídeo izquierdo, comprometiendo núcleos motores ipsilaterales y vías sensitivas cruzadas. Es un ejemplo de síndrome cruzado por lesión troncoencefálica (en concreto este es un síndrome bulbar medial o síndrome de Dejerine).

165. En la resonancia magnética cerebral, ¿qué hallazgo es más característico de la parálisis supranuclear progresiva (PSP) en fases moderadas?:

1. Atrofia del putamen con hiperseñal en T2.
2. Signo del “colibrí” en corte sagital.
3. Atrofia caudada bilateral.
4. Hiperseñal en sustancia negra en T2.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

El signo del “colibrí” en el corte sagital de la resonancia es característico de la PSP y refleja atrofia del mesencéfalo (donde se encuentran los núcleos encargados de los movimientos verticales, que característicamente se afectan en esta enfermedad) con preservación relativa de la protuberancia, configurando una imagen típica en fases moderadas de la enfermedad.

166. Varón de 10 años de edad que sufre un cuadro de fiebre sucedido de cefalea, afasia y crisis epilépticas y bajo nivel de conciencia. Se realiza RM que muestra afectación extensa de sustancia blanca en ambos hemisferios cerebrales. Señale la correcta en relación al diagnóstico de sospecha:

1. Son frecuentes las bandas oligoclonales.
2. El anticuerpo más frecuentes es antiMOG.
3. Esta enfermedad no suele producir crisis epilépticas porque la afectación no es cortical.
4. Es raro encontrar un desencadenante infeccioso.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Se trata de una encefalomiелitis aguda diseminada, cuadro más frecuente en la edad pediátrica que sucede típicamente después de una infección o vacunación, cursa típicamente con afectación multifocal y bajo nivel de conciencia, pudiendo haber crisis epilépticas. En el LCR se suele encontrar pleocitosis leve y las BOC son raras.

167. Un varón de 75 años, diabético e hipertenso, acude a urgencias 2 horas después de comenzar con sensación de debilidad en el hemicuerpo derecho y dificultad para hablar. En la exploración inicial presenta hemiparesia faciobraquiocrural derecha y disfasia. La tomografía computarizada (TC) craneal urgente no muestra signos de hemorragia ni infarto establecido. El estudio de angioTC de arterias cerebrales muestra un defecto de repleción a nivel de ACM izquierda, segmento M1 distal.

La tensión arterial es de 180/100 mmHg. ¿Cuál de las siguientes opciones representa la actitud terapéutica más adecuada en el manejo agudo de este paciente?:

1. Administrar labetalol intravenoso para reducir la tensión arterial por debajo de 140/90 mmHg inmediatamente previo a plantear tratamientos de permeabilización en fase aguda.
2. Administrar corticoides intravenosos para reducir el edema cerebral incipiente, y después realizar trombolisis intravenosa con tenecteplasa en bolo a dosis 0.25mg/kg.
3. Indicar trombectomía mecánica sin trombolisis intravenosa previa para evitar complicaciones hemorrágicas intracraneales durante la realización de procedimiento invadido intravascular.
4. Mantener la tensión arterial elevada, controlar la glucemia y la temperatura, y realizar trombolisis intravenosa seguida de trombectomía mecánica si ambas están disponibles.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

El paciente presenta un cuadro de ictus isquémico agudo con síntomas de inicio brusco y focalidad neurológica en la exploración. La llegada a urgencias en tan solo 2 horas desde el inicio de los síntomas y la ausencia de hemorragia en la TC craneal urgente lo sitúan dentro de la ventana temporal para las terapias de reperfusión en fase aguda. La angioTC revela un defecto de repleción a nivel de ACM izquierda, segmento M1 distal, lo que indica una oclusión de gran vaso. La trombectomía mecánica está indicada en pacientes con ictus por oclusión de gran vaso dentro de las primeras 6 horas desde el inicio de los síntomas (y hasta en las primeras 24 horas si contamos con estudios de perfusión favorables). El paciente cumple este criterio temporal. Además, también cumple criterios de tiempo para la trombolisis intravenosa (menos de 4.5 horas desde el inicio de los síntomas, si no contraindicaciones). La combinación de ambas terapias (trombolisis intravenosa seguida de trombectomía mecánica si hay oclusión de gran vaso susceptible) es el enfoque actual de manejo para pacientes elegibles. El control de la glucemia y la temperatura son medidas de soporte generales en el manejo del ictus agudo. Respecto a la tensión arterial, si bien la pregunta menciona “mantener la tensión arterial elevada”, las guías actuales recomiendan una hipertensión permisiva en la fase aguda del ictus isquémico (no reducirla agresivamente a menos que supere ciertos umbrales, generalmente >185/110 mmHg para trombolisis) para mantener la perfusión en el área de penumbra isquémica. Dado que la TA del paciente es 180/100 mmHg, no requeriría una reducción por debajo de umbrales bajos antes de la reperfusión.

168. Respecto a las medidas de manejo de la presión intracraneal, una de las siguientes opciones es falsa:

1. El método gold estándar para monitorizar la presión intracraneal es mediante un drenaje ventricular externo.
2. La hiperventilación con un objetivo de pCO₂ de 20-25mmHg debe considerarse en pacientes que no responden a medidas de primer nivel.
3. Dentro de las medidas de primer nivel se pueden considerar bolos de manitol al 20%.
4. Se puede considerar instaurar antiepilépticos de forma profiláctica durante una semana.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

El manejo de la presión intracraneal va encaminado a conseguir una adecuada perfusión cerebral (TAM - PIC), por ello el tratamiento considera medidas de distinto nivel. De forma resumida dentro de las de primer nivel se ha de tener una adecuada sedoanalgesia, se considerará instaurar antiepilépticos profilácticos, se pautarán bolos intermitentes de manitol o suero salino hipertónico y se implantará un drenaje ventricular externo en pacientes con hidrocefalia (opciones 3 y 4 correctas). En pacientes no explorables se debe monitorizar la PIC que se realiza mediante sensores principalmente a nivel intraparenquimatoso o intraventriculares, siendo estos últimos el gold estándar (opción 1 correcta) y aportando el beneficio de que permiten drenaje LCR en el caso de que esté indicado, aunque cuentan con un mayor riesgo de infección. Respecto a la hiperventilación, si que es una medida a considerar dentro de las medidas de segundo nivel, no obstante, debe ser una hiperventilación moderada manteniendo un pCO₂ entre 30-35mmHg, dado que con esto se consigue una vasoconstricción moderada que reduce el componente sanguíneo intracraneal y reduce secundariamente la PIC, minimizando el riesgo de isquemia cerebral secundario a dicha vasoconstricción (opción 2 falsa).

169. Mujer de 60 años con episodios repetidos de amnesia anterógrada y confusión. Se realiza EEG en uno de los episodios y se objetiva crisis epiléptica de lóbulo temporal medial. Señale la correcta a continuación:

1. La actividad epiléptica es irrelevante, se trata de amnesia global transitoria de repetición.
2. La RM mostrará una lesión estructural en el lóbulo temporal medial.
3. Se trata de una epilepsia generalizada idiopática con semiología temporal.
4. Levetiracetam, lacosamida y carbamazepina son buenas opciones terapéuticas.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

se trata de crisis epilépticas de lóbulo temporal que imitan una AGT, por ese motivo en AGTs de repetición merece la pena realizar EEG. La RM puede mostrar o no lesiones. La epilepsia es focal. La opción D es correcta.

170. ¿Cuál de los siguientes tratamientos actúa bloqueando directamente el receptor del CGRP en el tratamiento de la migraña episódica?:

1. Erenumab.
2. Fremanezumab.
3. Naratriptan.
4. Galcanezumab.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

El erenumab es un anticuerpo monoclonal que actúa bloqueando el receptor del CGRP, mientras que fremanezumab y galcanezumab bloquean el propio péptido CGRP. Naratriptan, como el resto de triptanes, se usa en el tratamiento de la crisis de migraña y bloquea el receptor de serotonina 5-HT_{1B} y 1D.

171. Mujer de 67 años que acude a urgencias por dolor intenso brusco en el ojo derecho, asociado a visión borrosa, halos alrededor de las luces, náuseas y vómitos. En la exploración oftalmológica, se observa inyección ciliar marcada en el ojo derecho, córnea edematosa y una pupila en midriasis media que no reacciona a la luz. Según su sospecha diagnóstica, señale la respuesta correcta:

1. Es necesario realizar una PCR de humor acuoso.
2. La presión intraocular estará elevada en el ojo derecho.
3. El defecto retiniano será contrario a la zona de visión borrosa.
4. Suele estar asociado a una enfermedad reumatológica.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta de dificultad media-baja. Un ojo rojo doloroso con pupila midriática y acompañado de síntomas vagales es el cuadro clínico típico de un glaucoma agudo (la presión intraocular estará muy elevada). A diferencia de las uveítis anteriores que tienen la pupila en miosis.

Recuerda que el glaucoma agudo tiene como factor de riesgo una longitud axial corta (hipermetropía) y tener desarrollada una catarata que ocupa espacio a nivel de la cámara posterior.

172. Mujer de 28 años que acude a Urgencias refiriendo enrojecimiento en su ojo izquierdo de inicio gradual durante las últimas 24 horas. También refiere sensación de arenilla, leve molestia y el ojo pegado por la mañana debido a las legañas. No refiere dolor intenso, cambios en la visión, fotofobia significativa ni antecedentes de traumatismo ocular. Al examen, se observa hiperemia conjuntival difusa en el ojo izquierdo, con algunos folículos pequeños en la conjuntiva

tarsal inferior. Refiere dolor preauricular en lado izquierdo. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable?:

1. Conjuntivitis viral.
2. Queratitis herpética.
3. Escleritis.
4. Iritis aguda.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta de dificultad media-baja. Un ojo rojo con legañas y folículos y una adenopatía preauricular nos tiene que hacer pensar en una conjuntivitis viral adenovírica. El resto de opciones no se acompañan de secreciones o legañas.

173. Varón de 73 años que acude a Urgencias por dolor ocular progresivo, enrojecimiento, disminución significativa de la visión y aumento de la secreción ocular en su ojo izquierdo. Cinco días antes había sido operado de catarata sin complicaciones. En la exploración se observa: edema palpebral, quemosis conjuntival, inyección ciliar intensa e hipopion. ¿Cuál es el manejo inicial más apropiado para este paciente?:

1. Iniciar tratamiento tópico con antibióticos de amplio espectro y corticosteroides, y programar una revisión en una semana para evaluar la respuesta.
2. Realizar un cultivo de exudado conjuntival y comenzar tratamiento antibiótico oral de amplio espectro de forma empírica.
3. Tomar muestras de humor acuoso y vítreo para cultivo, e iniciar inyecciones intravítreas de antibióticos de amplio espectro.
4. Administrar antibióticos intravenosos de amplio espectro y realizar una tomografía computarizada de órbita para descartar otras causas de inflamación.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta de dificultad alta. Un ojo rojo doloroso con hipopion y los antecedentes de cirugía intraocular previa nos tienen que hacer pensar en endoftalmitis. El tratamiento de las endoftalmitis es urgente y consiste en inyecciones intravítreas de antibióticos y vitrectomía. Pero antes, se deben tomar muestras de humor acuoso y humor vítreo para su cultivo. Las revisiones posteriores serán frecuentes, por lo que la opción 1 es falsa.

174. Paciente de 82 años que acude a Urgencias por cuadro de deterioro del estado general, otalgia y otorrea y afectación del VII par craneal. En los estudios de laboratorio presenta glucemia en ayunas de 356 mg/dL. La otoscopia muestra un conducto auditivo externo edematoso con tejido

de granulación en la unión osteocartilaginosa. Sobre la patología que sospecha señale la respuesta que no sea cierta:

1. Independientemente del cuadro clínico del paciente cualquier otitis externa que no responda al tratamiento empírico recomendado, y sobre todo si hay tejido de granulación en la exploración física, obliga a descartar una otitis externa maligna.
2. La presencia de parálisis facial durante el curso de una otitis externa es muy específico para el diagnóstico de otitis externa maligna.
3. En el caso clínico de la pregunta, la afectación del nervio facial es debido a la axonotmesis generada por el propio *Staphylococo Aureus*.
4. La presencia de una lesión granulomatosa o polipoidea en la unión osteocartilaginosa del conducto auditivo externo está presente en los pacientes con otitis externa maligna en aproximadamente un 80 % de los casos y refleja el proceso inflamatorio necrótico del hueso subyacente.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Ante un paciente que presenta diabetes (glucemia en ayunas de >126), otalgia y otorrea (sugestivo clínicamente de otitis externa) y parálisis facial nos obliga a orientar el caso clínico hacia una posible otitis externa maligna. Las respuestas nos hablan sobre las características de la enfermedad. Ante un paciente que tras el diagnóstico de otitis externa y con un tratamiento adecuado, no mejora o presente un dolor desproporcionado está recomendado descartar otitis externa maligna (respuesta 1 verdadera), al igual que la presencia de afectación de pares craneales bajos que presenta una alta especificidad y valor predictivo positivo para el diagnóstico (respuesta 2 correcta). El tejido de granulación en la exploración física nos orienta a la otitis externa maligna constituyendo la respuesta inflamatoria secundaria a la osteomielitis del hueso temporal (respuesta 4 correcta). La parálisis facial no es debida a la destrucción del nervio sino a las neurotoxinas producidas por el principal germen que genera la otitis externa maligna, la *Pseudomona Aeruginosa* (respuesta 3 falsa).

175. Sobre la maniobra de Dix Hallpike señale la respuesta cierta:

1. Es una maniobra diagnóstica para valorar la afectación del canal semicircular posterior en el vértigo posicional paroxístico benigno.
2. Se define como un test diagnóstico muy útil para evaluar la función de las máculas del utrículo y el sáculo.
3. Se considera positiva la maniobra de Dix Hallpike si aparece un nistagmo tras latencia que dura menos de 1 minuto y se mantiene estable en sucesivas repeticiones de la maniobra.

4. Si asociamos a la maniobra de Dix Hallpike, la maniobra diagnóstica de Epley podemos llegar a diagnosticar un vértigo posicional paroxístico benigno de cualquier canal.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

En esta pregunta nos comentan características propias de la maniobra DIAGNÓSTICA de Dix Hallpike: 1. La respuesta 1 es CORRECTA ya que la maniobra de Dix Hallpike es una maniobra diagnóstica para evaluar el VPPB en el canal más frecuentemente afectado, el canal semicircular posterior. 2. La respuesta 2 es falsa ya que es una maniobra que se utiliza para evaluar la presencia de otolitos en el canal semicircular posterior. La respuesta 3 nos define como es el nistagmo en el VPPB, que se caracteriza por presentar latencia (menos de 1 minuto), duración del nistagmo irritativo menor de 1 minuto, se invierte al incorporarse y se fatiga, es decir, se produce un nistagmo menos intenso conforme repetimos la maniobra (respuesta 3 falsa). La maniobra de Epley no es una maniobra diagnóstica sino que se utiliza para llevar a cabo el tratamiento del VPPB una vez que Dix Hallpike es positiva (respuesta 4 falsa).

176. En la disfonía espasmódica el tratamiento que ha sido recomendado en las últimas publicaciones en la infiltración en la musculatura afectada de toxina botulínica. En el caso de una disfonía espasmódica abductora, ¿qué músculo debe ser infiltrado?:

1. Cricoaritenideo posterior.
2. Cricotiroides.
3. Cricoaritenideo lateral.
4. Interaritenideo.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Aunque la pregunta haga referencia a la disfonía espasmódica, es una pregunta sobre anatomía funcional de la musculatura laríngea. Recordad que el único músculo que abre las cuerdas vocales es el cricoaritenideo posterior (respuesta 1 correcta).

177. Acude a su consulta de atención primaria un paciente de 20 años que solicita atención urgente. Comenta que presenta una otalgia derecha intensa que le impide la utilización de auriculares de unos dos días de evolución, sin otorrea. En la exploración física se evidencia una tumefacción eritematosa en la porción más externa del CAE en la región inferior, fluctuante que llega a obliterar la entrada del CAE pero permite evaluar el resto de la otoscopia, que aunque es dolorosa, presenta un tímpano normal. En cuanto a la patología que sospecha que presenta este paciente ¿cuál cree que es el manejo menos adecuado?:

1. Drenaje bajo anestesia local en la zona más fluctuante.
2. Cloxacilina oral 500 mg cada 6 horas durante 1 semana.
3. Observación domiciliaria, evitar entrada de agua en el oído derecho y tratamiento tópico con ciprofloxacino, e incluso usar unas gotas con corticoide y antibiótico para disminuir la inflamación de la lesión.
4. En esta patología, si la lesión no está fluctuante y no está muy extendida se podría usar ácido fusídico o mupirocina como tratamiento antibiótico tópico.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Se trata de un paciente que presenta otalgia, trago positivo (dolor con la movilización u otoscopia dolorosa) y tumefacción fluctuante en el tercio externo del CAE. Esta clínica es compatible con otitis externa circunscrita, patología generada por el *Staphylococo aureus* y que requiere en función de la gravedad drenaje del absceso formado (respuesta 1 correcta) y antibiótico oral y/o tópico (respuestas 2 y 4 correctas). El tratamiento con tópico con ciprofloxacino va orientado a pacientes con otitis externa difusa (respuesta 3 incorrecta).

178. En su primer día como médico general, acude una paciente para preguntarle dudas sobre su reciente diagnóstico: adenoma pleomorfo de glándula parótida derecha. ¿Cuál de las siguientes recomendaciones que puede hacer a la paciente es correcta?:

1. Es un tumor raro de las glándulas salivales y la cirugía presenta riesgo de lesionar el nervio facial, por lo que le recomendaría intervención si presenta una deformidad facial evidente.
2. Le recomendaría una valoración por el otorrinolaringólogo ya que es un tumor que tiene riesgo de malignizar, así que se debería valorar una parotidectomía.
3. Si en la exploración física de la paciente no presenta parálisis facial del mismo lado dudaría del resultado de las pruebas complementarias, ya que el adenoma pleomorfo tiene una alta incidencia de invasión perineural.
4. Explicaría a la paciente que es un tumor benigno exclusivo de la glándula parótida y que presenta una alta incidencia de recidiva a pesar de ser intervenido, por lo que dados los riesgos de la cirugía propondría realizar observación y valorar la progresión de la lesión con ecografías anuales.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

En esta pregunta nos evalúan nuestros conocimientos sobre el adenoma pleomorfo: es el tumor benigno más frecuentes de

las glándulas salivales y donde más frecuentemente asienta es en la glándula parótida, aunque no es exclusivo, ya que puede aparecer en glándulas salivales menores (por ejemplo en paladar blando). Al ser un tumor benigno no producen infiltración perineural del nervio facial y no generan parálisis facial (respuesta 3 falsa). Como características especiales del tumor, es una lesión muy frecuente en mujeres y que tiene hasta un 5-6 % de riesgo de malignizar por lo que ante el diagnóstico se recomienda realizar parotidectomía superficial con conservación del nervio facial (respuesta 2 correcta).

179. Señala la opción falsa acerca del Trastorno obsesivo-compulsivo:

1. Suele tener un curso crónico.
2. La presencia comórbida de trastorno depresivo mayor aumenta el riesgo de suicidio.
3. Existe una alteración en la transmisión dopaminérgica fundamentalmente.
4. Las ideas obsesivas se caracterizan por ser reconocidas por el paciente como intrusivas y, en la mayoría de los casos como irracionales o absurdas.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

En el Trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) suele tener un curso crónico (respuesta 1 incorrecta). Las ideas obsesivas se experimentan como intrusivas y, en la mayoría de los casos siendo conscientes o comprendiendo la irracionalidad de las mismas (respuesta 4 incorrecta). Es frecuente la comorbilidad con trastorno depresivo, que aumentará el riesgo de suicidio en personas con TOC (respuesta 2 incorrecta). Otra comorbilidad muy frecuente es con trastornos de ansiedad. Existen alteraciones en la transmisión serotoninérgica, motivo por el cual, en el tratamiento farmacológico estarían indicados antidepresivos ISRS o clomipramina (respuesta 4 correcta).

180. Fernando es un hombre de 40 años que presenta dificultades significativas para mantener relaciones interpersonales estables. A lo largo de su vida, sus relaciones amorosas, de amistad y laborales han terminado de manera conflictiva. Se trata de una persona que necesita constantemente ser el centro de atención en cualquier situación. Busca que le halaguen, y cuando no recibe la admiración que espera, se muestra irritado y se siente menospreciado. Habitualmente actúa con confianza, si bien, en algunos momentos muestra una gran preocupación por lo que los demás piensen de sí mismo, pero no por lo que sienten, presentando en algunos momentos sensación interna de vacío. Suele exagerar sus logros y talentos y le cuesta reconocer las contribuciones de los demás. ¿Cuál de las siguientes sería la orientación diagnóstica?:

1. Trastorno narcisista de la personalidad.
2. Trastorno histriónico de la personalidad.
3. Trastorno esquizoide de la personalidad.
4. Trastorno límite de la personalidad.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta de dificultad media acerca de los trastornos de la personalidad. Nos plantean un hombre cuyos rasgos de personalidad interfieren de forma significativa a nivel laboral y en sus relaciones personales. Nos indican que quiere ser el centro de atención, con lo que nos quieren confundir con trastorno histriónico, pero que lo hace para buscar el halago y admiración (grandiosidad) del resto (en el caso de trastorno histriónico buscan más ser aceptados y amados). Además, nos indican que tiende a exagerar sus logros y critica o minusvalora las aportaciones de los demás, muy típico del narcisista. Por último, habitualmente muestra confianza en sí mismo, pero por debajo se encuentra inseguro y le preocupa lo que piensen los demás. Con el término vacío, junto a relaciones conflictivas, nos intentan confundir con trastorno límite, pero no cumple ninguna otra característica de este trastorno.

181. Varón de 32 años que acude a urgencias muy angustiado. Presenta cuadro de unas horas evolución consistente en dolor ocular y desviación de la mirada hacia arriba. Refiere reciente inicio de tratamiento con risperidona. ¿Cuál le parece que sería la conducta a seguir con este paciente?:

1. Diazepam 10mg vía sublingual.
2. Retirada de tratamiento antipsicótico.
3. Tratamiento con clozapina.
4. Biperideno intramuscular.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Se trata de un cuadro de distonía aguda secundario al inicio de tratamiento con antipsicóticos (efecto secundario extrapiramidal). El tratamiento adecuado es la administración de biperideno intramuscular (respuesta 4 correcta). Recuerda que las benzodiacepinas se utilizarán en casos de acatisia (respuesta 1 incorrecta). La clozapina se reserva para casos de esquizofrenia resistente o discinesia tardía (respuesta 3 incorrecta). La retirada de tratamiento antipsicótico no está indicada en estos casos (respuesta 2 incorrecta).

182. ¿Cuál de los siguientes fármacos tiene una interacción significativa con el litio, aumentando el riesgo de intoxicación por litio?:

1. Ibuprofeno.
2. Paracetamol.
3. Risperidona.
4. Amoxicilina.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

El ibuprofeno y otros antiinflamatorios no esteroides (AINEs) pueden aumentar los niveles de litio en la sangre al disminuir la excreción del mismo a nivel renal. El paracetamol, la amoxicilina y la risperidona no aumentan los niveles de litio.

183. Acude a consulta una adolescente de 16 años por autolesiones en forma de cortes superficiales en brazos con finalidad, referida por la paciente, no autolítica realizadas en contexto de desbordamiento emocional:

1. Ignoramos autolesiones dado que no hay intención de suicidio y podríamos fomentar nuevas autolesiones.
2. Derivamos a servicio de urgencias para hospitalización ya que las autolesiones son siempre un signo de una condición grave.
3. La paciente refiere haberse realizado las autolesiones en contexto de desbordamiento emocional por lo que basamos la intervención en iniciar tratamiento farmacológico con lorazepam de rescate para momentos de desbordamiento emocional.
4. Realizamos evaluación emocional y trabajamos sobre regulación emocional y manejo de estrés.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta de dificultad baja-media sobre autolesiones sin finalidad autolítica en adolescencia, las cuales a menudo se relacionan con la dificultad para manejar las emociones. Por ello, el abordaje se debe iniciar con una buena evaluación emocional para comprender los factores subyacentes que llevan a la autolesión y ofrecer técnicas de manejo de estrés que permita a la persona afrontar situaciones difíciles sin recurrir a la autolesión (respuesta 3 correcta). El uso de medicamentos puede ser útil y necesario pero el abordaje a nivel emocional y abordaje psicológico es la base de la intervención (respuesta 4 falsa). Aunque son un factor de riesgo para intento de suicidio, las autolesiones sin finalidad y sin ideación autolítica no requiere, a priori, de ingreso hospitalario (respuesta 2 falsa). No se deben ignorar las autolesiones ya que son una manifestación de un sufrimiento emocional y puede transmitir el mensaje de que el comportamiento no es relevante (Respuesta 1 falsa).

184. ¿Cuál de las siguientes medidas no estaría indicada en el caso de querer prevenir el síndrome confusional agudo en un paciente de edad avanzada ingresado por patología orgánica?:

1. Evitar el uso de benzodiacepinas.
2. Evitar la movilización del paciente.
3. Evitar el aislamiento sensorial del paciente.
4. Evitar las tomas de medicación en horario de descanso nocturno.

Respuesta correcta: 2**Comentario:**

Pregunta acerca de medidas de prevención del síndrome confusional agudo en paciente anciano hospitalizado. Se debe evitar el uso de medicaciones que puedan favorecerlo, tales como las benzodiazepinas o antidepresivos tricíclicos (efectos anticolinérgicos) (respuesta 1 incorrecta). Se deben favorecer medidas de orientación como calendarios o relojes, audífonos, gafas... (respuesta 3 incorrecta). Así como respetar en la medida de lo posible los horarios de descanso nocturno (respuesta 4 incorrecta). Deben evitarse las inmovilizaciones prolongadas y limitar en el tiempo todo aquello que impida una pronta movilización del paciente (sondajes, aparatos de suero con los que no pueda desplazarse, etc.) (respuesta 2 correcta).

185. Mujer de 72 años con antecedentes de hipertensión arterial, que consulta por cuadro de 2 días de evolución de dolor intenso articular en muñecas, rodillas y metacarpofalángicas de forma simétrica bilateral con rigidez matutina de 3 horas de duración. La exploración física muestra inflamación articular significativa en las articulaciones afectadas. El factor reumatoide y los ACPA son negativos. Se realiza una radiografía de carpos donde se observan calcificaciones en el ligamento triangular del carpo. ¿Qué esperas encontrar en el líquido articular?:

1. Líquido sinovial de características inflamatorias con cristales en forma de aguja con birrefringencia fuertemente negativa.
2. Líquido sinovial de características inflamatorias con cristales romboidales con birrefringencia débilmente positiva.
3. Líquido sinovial de características inflamatorias sin presencia de cristales.
4. Líquido sinovial de características mecánicas con cristales romboidales con birrefringencia débilmente positiva.

Respuesta correcta: 2**Comentario:**

Nos presentan un caso clínico de una poliartritis aguda simétrica de manos, carpos y rodillas en una mujer mayor, con unas radiografías de carpos donde se observa calcificaciones en el ligamento triangular del carpo, hallazgo típico de los depósitos de cristales de pirofosfato cálcico, por lo que debemos sospechar una condrocalcinosis en su forma "pseudorreumatoide". Se parece mucho en su forma de presentación a la artritis reumatoide de inicio en el anciano, que constituye uno de sus principales diagnósticos diferenciales. El líquido sinovial en el brote agudo de la condrocalcinosis es de características inflamatorias, y encontramos los cristales de pirofosfato cálcico de morfología romboidal con birrefringencia débilmente positiva (opción 2 correcta, opción 4 incorrecta), a diferencia de los cristales de urato que tienen forma de aguja y birrefringencia

fuertemente negativa (opción 1 incorrecta). En este caso, la negatividad de factor reumatoide y ACPA y los hallazgos radiográficos nos hacen descartar la artritis reumatoide (opción 3 incorrecta).

186. Un varón de 58 años con antecedentes de artrosis acude a urgencias por dolor intenso, tumefacción y calor local en la rodilla derecha de aparición brusca. Refiere fiebre de 38,5 °C. La articulación ofrece una movilidad muy limitada por el dolor. ¿Cuál de los siguientes hallazgos en el análisis del líquido articular es más sugestivo de artritis séptica?:

1. Líquido claro, con <200 leucocitos/ μ L y glucosa normal.
2. Líquido turbio, con 65000 leucocitos/ μ L y glucosa baja.
3. Líquido viscoso, con 15000 leucocitos, glucosa normal y cuerpos bipiramidales birrefringentes.
4. Líquido hemorrágico, con 9500 leucocitos y glucosa normal.

Respuesta correcta: 2**Comentario:**

Intensa de una articulación grande es muy sugestiva de artritis séptica, cuyo hallazgo más característico en el análisis del líquido articular es una apariencia turbia u opaca, más de 50.000 leucocitos/ μ L con predominio de neutrófilos y glucosa baja por consumo bacteriano y leucocitario; las demás opciones son improbables por corresponder a líquido sinovial normal (claro, <200 leucocitos/ μ L, glucosa normal), a patología microcristalina (cristales bipiramidales birrefringentes, leucocitos moderados y glucosa normal) o a una posible artropatía postraumática o inflamatoria crónica (líquido hemorrágico con leucocitos moderados y glucosa normal).

187. Varón de 67 años que acude a consulta por fiebre recurrente, lesiones cutáneas tipo dermatosis neutrofilica y artralgiás de 8 meses de evolución. Ha sido diagnosticado previamente de policondritis recidivante sin respuesta a corticoides a dosis medias. En la analítica presenta anemia macrocítica, trombopenia y PCR 70 mg/L. ¿Cuál le parece la actitud más correcta?:

1. Se trata de una policondritis recidivante refractaria, añadiría metotrexato al tratamiento actual.
2. Sospecho un síndrome de VEXAS, solicitaría estudio genético para identificar la mutación en el gen UBA1.
3. Es probable una vasculitis asociada a ANCA, solicitaría determinación de anticuerpos ANCA y biopsia de piel.
4. Se trata de un síndrome mielodisplásico con manifestaciones autoinflamatorias, iniciaría estudio medular convencional.

Respuesta correcta: 2**Comentario:**

Respuesta correcta 2, nos muestran un caso con características muy sugestivas del síndrome de VEXAS: varón mayor de 50 años, sobre todo mayor de 60, con fiebre, policondritis refractaria a tratamiento, lesiones cutáneas tipo síndrome de Sweet y artralgias, resistente al tratamiento convencional. Además nos indican datos analíticos característicos de esta entidad como son la trombopenia, anemia macrocítica y elevación de reactantes de fase aguda. Recuerda que el diagnóstico definitivo requiere la identificación de la mutación en el gen UBA1. Aunque la biopsia de médula ósea puede mostrar vacuolas características en células precursoras mieloides, no es diagnóstica por sí sola.

188. Una paciente con diagnóstico previo de Síndrome de Sjögren presenta positividad para anticuerpos anti-mitocondriales. Usted pensaría que co-existe con:

1. Lupus eritematoso sistémico.
2. Esclerosis sistémica cutánea limitada.
3. Colangitis biliar primaria.
4. Dermatomiositis.

Respuesta correcta: 3**Comentario:**

La asociación entre el síndrome de Sjögren y la colangitis biliar primaria está bien documentada en la literatura médica. Ambos son enfermedades autoinmunes que frecuentemente coexisten en los mismos pacientes debido a similitudes en sus manifestaciones clínicas e inmunopatogénesis. El síndrome de Sjögren y la colangitis biliar primaria comparten características inmunológicas, como la presencia de anticuerpos antinucleares (ANA) y anticuerpos antimitocondriales (AMA), que son comunes en ambas enfermedades. La prevalencia de CBP en pacientes con SS es significativa, con estudios que muestran que hasta el 6.6% de los pacientes con SS pueden desarrollarla. Recuerda que el Sjögren está frecuentemente asociado a la Artritis Reumatoide (es la entidad con la que más se asocia) pero ese vínculo no va marcado por la presencia de antimitocondriales.

189. Avacopan es un medicamento aprobado para el tratamiento de la granulomatosis con poliangéitis y la poliangéitis microscópica. ¿Cuál es su mecanismo de acción?:

1. Bloqueo del receptor de la C5a de complemento, inhibiendo la activación de la cascada del complemento.
2. Inhibición de la interleucina-6 (IL-6) mediante la unión a su receptor.
3. Inhibición de la fosfodiesterasa 4 (PDE4) en células inflamatorias.
4. Bloqueo de la interleucina-1 (IL-1) para reducir la inflamación articular.

Respuesta correcta: 1**Comentario:**

Avacopan es un inhibidor del receptor C5a del complemento, que actúa específicamente bloqueando la unión de la C5a a su receptor (C5aR) en las células neutrófilas y otras células inflamatorias. La C5a es una proteína clave en la activación del sistema de complemento, y su interacción con el receptor C5aR promueve la activación de neutrófilos y otras células del sistema inmune, lo que contribuye a la inflamación en enfermedades autoinmunes como la granulomatosis con poliangéitis y la poliartritis microscópica.

190. Varón de 30 años, sin antecedentes médicos de interés, acude por visión borrosa en ambos ojos y dolor ocular intenso. En la exploración destaca una panuveítis bilateral con vasculitis retiniana y edema macular. El paciente refiere además úlceras orales y genitales recurrentes en los últimos dos años, y un episodio de trombosis de la vena cava inferior el año pasado. La prueba de patergia es positiva. Tras iniciar corticoides sistémicos, la clínica ocular mejora transitoriamente pero recidiva al reducir la dosis. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto al manejo de este paciente?:

1. El uso de anticoagulación está formalmente indicado para prevenir nuevas trombosis en la enfermedad de Behçet.
2. La azatioprina está indicada solo en formas cutáneas o articulares, pero no en la afectación ocular ni vascular.
3. El tratamiento con antagonistas del TNF α debe considerarse en fases refractarias, una vez descartada tuberculosis latente.
4. La presencia de HLA-B51 negativo descarta el diagnóstico de Behçet, siendo más probable una espondiloartritis.

Respuesta correcta: 3**Comentario:**

Este paciente presenta una enfermedad de Behçet con afectación ocular grave y afectación vascular previa (trombosis de la vena cava inferior). La combinación de panuveítis bilateral con vasculitis retiniana y clínica mucocutánea clásica hace el diagnóstico prácticamente evidente. Ante la refractariedad a corticoides, se debe escalar el tratamiento inmunosupresor. En estos casos, los anti-TNF α (como infliximab o adalimumab) son tratamientos de elección según guías EULAR, especialmente eficaces en la uveítis y la trombosis venosa. Es imprescindible descartar tuberculosis latente antes de iniciarlos. La azatioprina, al contrario de lo que sugiere la opción 2, sí es útil en Behçet, y se puede emplear en manifestaciones articulares, mucocutáneas e incluso oculares leves o moderadas, pero no es suficiente como única terapia en formas graves o refractarias como esta. La anticoagulación no está formalmente indicada de manera sistemática, ya que el mecanismo de trombosis

es inflamatorio, no embólico. Finalmente, la ausencia de HLA-B51 no excluye el diagnóstico, ya que no forma parte de los criterios diagnósticos internacionales, siendo solo un factor de susceptibilidad.

191. Usted realiza el seguimiento en consulta externa de una una paciente de 54 años diagnosticada de de lupus eritematoso sistémico desde los 30 años de edad. En los últimos 5 años no se han descrito incidencias clínicas ni cambios analíticos de interés que hayan motivado cambios en su tratamiento habitual (hidroxicloroquina y azatioprina). ¿Cuál de las siguientes vacunas está desaconsejada?:

1. Fiebre amarilla.
2. Gripe.
3. Tétanos.
4. Neumococo.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Las vacunas vivas atenuadas como la fiebre amarilla deben evitarse en pacientes inmunodeprimidos con enfermedades autoinmunes. Tanto la vacuna de la gripe como del neumococo están firmemente recomendadas. Los pacientes con enfermedades autoinmunes deberían recibir la vacuna del tétanos de acuerdo a las recomendaciones para la población general.

192. En relación a las características radiológicas que permiten diferenciar un tumor de células gigantes de un condroblastoma en la epífisis, señale la respuesta INCORRECTA:

1. El condroblastoma aparece en pacientes más jóvenes (10-25 años) que el tumor de células gigantes (20-40 años).
2. El tumor de células gigantes suele tener bordes menos definidos que el condroblastoma.
3. El condroblastoma suele presentar calcificaciones puntiformes en su interior.
4. El tumor de células gigantes afecta preferentemente a la epífisis distal del radio.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta sobre diagnóstico diferencial radiológico entre tumor de células gigantes y condroblastoma, ambos de localización epifisaria. La opción 4 es incorrecta porque aunque el TCG puede afectar al radio, su localización predominante es la rodilla (región epifisaria de fémur distal o tibia proximal). Las otras opciones son correctas: el condroblastoma (opción 1) afecta a pacientes más jóvenes, durante el crecimiento esquelético (10-25 años) mientras que el TCG aparece en adultos jóvenes con esqueleto maduro (20-40 años); el tumor de células gigantes (opción 2) tiene márgenes menos definidos, bordes geográficos y aspecto "lítico" que destruye y "borra" el hueso; y

el condroblastoma (opción 3) presenta calcificaciones puntiformes características de la matriz condroide.

193. Respecto a las pruebas diagnósticas utilizadas en el estudio de la escoliosis, señale la respuesta INCORRECTA:

1. El test de Adams es positivo cuando el paciente presenta una giba costal al flexionar el tronco.
2. El test de Risser evalúa la madurez esquelética mediante la osificación de la cresta ilíaca.
3. La medición del ángulo de Cobb en radiografías dinámicas de flexión lateral permite valorar la flexibilidad de la curva.
4. La monitorización neurofisiológica intraoperatoria con potenciales evocados somatosensoriales tiene una sensibilidad superior al 95% para detectar lesiones neurológicas.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta que puede responderse por descarte. La opción 4 es incorrecta porque la monitorización neurofisiológica intraoperatoria con potenciales evocados somatosensoriales (PESS) tiene una sensibilidad limitada, inferior al 95%. Se usa en conjunto con otras monitorizaciones en cirugías de escoliosis para ver si se genera lesión neurológica yatrogénica intraoperatoria, para corregir el problema rápidamente.

194. Adolescente de 14 años, deportista, que consulta por dolor en cara anterior de la rodilla derecha de varios meses de evolución. Empeora con la actividad deportiva y al subir escaleras. A la exploración presenta dolor a la palpación del polo inferior de la rótula y tuberosidad tibial anterior, sin derrame articular ni inestabilidad. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial más probable entre las siguientes entidades?:

1. Enfermedad de Osgood-Schlatter vs. síndrome de Sinding-Larsen-Johansson.
2. Síndrome de la plica sinovial vs. condromalacia rotuliana.
3. Osteocondritis disecante vs. enfermedad de Blount.
4. Tendinitis rotuliana vs. síndrome de compresión patelofemoral.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

La presentación clínica descrita (dolor en el polo inferior de la rótula y tuberosidad tibial anterior, sin derrame ni inestabilidad, en un adolescente deportista) es compatible tanto con enfermedad de Osgood-Schlatter como con síndrome de Sinding-Larsen-Johansson (opción 1). Ambas son osteocondrosis por tracción: la enfermedad de Osgood-Schlatter afecta a la tuberosidad tibial anterior (inserción distal del tendón rotuliano), mientras que el síndrome de

Sinding-Larsen-Johansson afecta al polo inferior de la rótula (inserción proximal del tendón rotuliano). Las otras opciones incluyen patologías que no se corresponden con la presentación clínica descrita o que no suelen presentarse simultáneamente como diagnóstico diferencial.

195. Adolescente de 14 años con obesidad que consulta por dolor en cara anterior de muslo y rodilla izquierda de 3 semanas de evolución. Refiere empeoramiento progresivo, cojera y dificultad para la movilidad del miembro. No recuerda traumatismo previo. A la exploración presenta dolor a la rotación interna y externa de la cadera izquierda, con limitación de la rotación interna. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?:

1. Enfermedad de Perthes.
2. Condrolisis idiopática de cadera.
3. Epifisiolisis femoral proximal.
4. Artritis séptica de cadera.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La epifisiolisis femoral proximal (opción 3) es el diagnóstico más probable dada la edad del paciente (adolescente), el sexo masculino, la obesidad (factor de riesgo), la presentación clínica con dolor referido a rodilla y la limitación de la rotación interna de cadera. La enfermedad de Perthes (opción 1) afecta a niños más pequeños (4-9 años).

196. Paciente de 35 años que acude a urgencias tras sufrir un traumatismo indirecto en el tendón de Aquiles jugando al pádel. Refiere haber oído un chasquido y presenta dolor intenso en la región posterior del tobillo. A la exploración se observa un defecto palpable en el tendón y la prueba de Thompson es positiva. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?:

1. Inmovilización con férula suropédica en equino durante 8 semanas.
2. Reparación quirúrgica del tendón.
3. Tratamiento conservador con rehabilitación precoz.
4. Infiltración local con corticoides.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta sencilla sobre el tratamiento de la rotura aguda del tendón de Aquiles. El caso describe una rotura completa del tendón de Aquiles (chasquido audible, defecto palpable, prueba de Thompson positiva). En pacientes jóvenes y activos, como el del caso (35 años), el tratamiento de elección es la reparación quirúrgica (opción 2), que proporciona mejores resultados funcionales, menor tasa de re-rotura y retorno más rápido a la actividad deportiva. El tratamiento conservador con inmovilización (opción 1) puede considerarse en pacientes mayores o con comorbilidades importantes, hay que saber que tiene buenos resultados, pero tiene mayor tasa de re-rotura.

197. Paciente varón de 12 años que sufre una caída con el brazo en extensión. Presenta dolor e impotencia funcional en el antebrazo izquierdo, con deformidad evidente. La radiografía muestra una fractura diafisaria de cúbito y luxación anterior de la cabeza radial. A las 24 horas de la cirugía, el paciente refiere imposibilidad para la extensión del pulgar. ¿Cuál es la complicación más probable?:

1. Lesión del nervio interóseo posterior.
2. Lesión del nervio mediano.
3. Rotura del extensor largo del pulgar.
4. Síndrome compartimental del antebrazo.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

En el contexto de una lesión a nivel del antebrazo sospechamos una neuroapraxia del nervio que presenta el déficit, en este caso, la extensión del pulgar depende del nervio interóseo posterior (rama motora del nervio radial). El nervio discurre próximo al cuello del radio y puede lesionarse tanto en el traumatismo como en la cirugía. Su lesión no muestra afectación sensitiva (por ser una rama exclusivamente motora). A nivel del antebrazo no suelen verse lesiones tendinosas (3 falsa) ya que se encuentran los vientres musculares.

198. Mujer de 76 años que sufrió una caída con traumatismo directo sobre cadera izquierda hace 3 semanas. Portadora de prótesis total de cadera implantada hace 5 años por coxartrosis. Acude a urgencias por dolor súbito e impotencia funcional tras sentir un “chasquido” al levantarse de una silla. La radiografía muestra una fractura de fémur proximal a nivel de la punta del vástago femoral. Los componentes protésicos no muestran signos de aflojamiento. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?:

1. Recambio del componente femoral por un vástago más largo.
2. Reducción abierta y fijación interna con placa periprotésica.
3. Artroplastia de resección tipo Girdlestone.
4. Tratamiento conservador con descarga durante 8 semanas.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Se trata de una fractura periprotésica de fémur alrededor del vástago femoral con implante estable. En estos casos, el tratamiento de elección es la osteosíntesis sin recambio (opción 2), habitualmente mediante placa bloqueada +/- cerclajes. El recambio del componente femoral (opción 1) estaría indicado si existiera aflojamiento del vástago.

199. Señale la asociación INCORRECTA entre fármaco y contraindicación:

1. Romosozumab - Antecedentes de infarto de miocardio.
2. Teriparatida - Radioterapia previa en esqueleto.
3. Denosumab - Filtrado glomerular < 30 ml/min.
4. Bifosfonatos orales - Esofagitis.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Preguntas sencillas que repasan las principales contraindicaciones de estos fármacos, recuerda el antecedente de IAM o ictus en romosozumab, neoplasias o metástasis óseas o radioterapia en esqueleto en teriparatide y abaloparatide, esofagitis en los difosfonatos orales (no en el zoledrónico iv). Una de las ventajas de denosumab es que lo podemos usar en pacientes con insuficiencia renal.

200. Paciente de 68 años que acude a consulta por imposibilidad para la extensión del pulgar derecho desde unas semanas. No dolía demasiado por lo que inicialmente no acudió a urgencias. Como antecedente destaca una fractura de radio distal hace 2 años, tratada mediante reducción cerrada e inmovilización con yeso durante 6 semanas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?:

1. Síndrome de De Quervain.
2. Rotura del extensor largo del pulgar.
3. Síndrome del túnel carpiano.
4. Artrosis trapecio-metacarpiana.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta sencilla sobre una complicación típica de las fracturas de radio distal. La rotura del tendón extensor largo del pulgar (opción 2) es una complicación reconocida que puede aparecer tras fracturas de radio distal, típicamente después de la lesión inicial. Se debe generalmente a atricción del tendón sobre el tubérculo de Lister. El síndrome de De Quervain (opción 1) se caracteriza por dolor en la región lateral de la muñeca y no por déficit de extensión del pulgar.

201. Respecto a los valores concretos que indican tratamiento con corsé en la escoliosis idiopática del adolescente, señale la respuesta correcta:

1. Ángulo de Cobb entre 20-30° con Risser 0-2.
2. Ángulo de Cobb entre 40-50° con Risser 3-5.
3. Ángulo de Cobb entre 30-40° con cualquier grado de Risser.
4. Ángulo de Cobb superior a 50° independientemente del Risser.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta sobre indicaciones de corsé en escoliosis idiopática del adolescente. El tratamiento con corsé está indicado en

curvas entre 20-30° con potencial de crecimiento (Risser 0-2) o en curvas entre 30-40° con cualquier grado de Risser. La opción 2 es incorrecta porque curvas entre 40-50° con Risser 3-5 tienen indicación quirúrgica, no de corsé. La opción 3 es parcialmente correcta (curvas entre 30-40°) pero incompleta, ya que en este rango también influye la madurez esquelética y la progresión documentada. La opción 4 es incorrecta porque curvas superiores a 50° tienen indicación quirúrgica, no de corsé, independientemente del Risser.

202. Mujer de 80 años, ingresada por fractura de cadera secundaria a caída, en su día 5 post operatorio de colocación de prótesis de cadera. En analítica TFG 30 ml/min. Durante el ingreso presenta disnea súbita, al examen físico se evidencia taquicardia de hasta 106lpm, TA 89/80mmHg persistente, SatO2 94% con FiO2 35%. Según el diagnóstico de sospecha, ¿cual de las siguientes opciones es correcta?:

1. El tratamiento es fibrinólisis sistémica.
2. El tratamiento es enoxaparina a dosis mg/kg cada 12 horas.
3. Dado que es una paciente con fracaso renal el tratamiento es con heparina no fraccionada.
4. Se puede iniciar tratamiento Apixaban 5mg cada 12 horas.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

El caso clínico se trata de una paciente con tromboembolia de pulmón. Para decidir el tratamiento de la paciente, se debe estratificar el riesgo, en el caso clínico estamos ante una paciente que se encuentra inestable hemodinámicamente (TAS < 90mmHg persistente), además taquicardia y necesidad de oxigenoterapia para mantener SatO2 en rango de la normalidad, por lo que se trata de un TEP de riesgo alto, el tratamiento indicado sería fibrinólisis sistémica.

203. Acude a servicio de urgencias un varón de 25 años sin antecedentes de interés por cefalea. Refiere caída al suelo desde su propia altura con TCE occipital asociado sin pérdida de conocimiento. Desde entonces presenta leve cefalea sin náuseas asociadas. Presenta un GCS de 15 y la exploración neurológica es normal. Respecto al enunciado anterior, señale la opción correcta:

1. Al tratarse de un TCE con golpe a nivel occipital es necesario realizar una prueba de neuroimagen que descarte el desarrollo de lesiones por contragolpe.
2. Debe mantenerse en observación durante al menos 24h, y en caso de deterioro neurológico habría que realizar una prueba de neuroimagen.
3. Al ser un paciente joven se debe priorizar realizar una RMN cerebral con la finalidad de reducir la exposición a radiación.

4. El paciente puede ser dado de alta con recomendaciones.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

En esta pregunta nos preguntan la indicación de TC en TCE. Lo que debemos recordar es principalmente que, en un paciente joven con un mecanismo de baja energía y una exploración neurológica normal, se puede dar alta con recomendaciones y no está indicada la realización de pruebas de neuroimagen (opción 4 correcta, opciones 1 y 2 falsas). En TCE, y en general en patología urgente, la prueba de elección es una TC craneal (opción 3 falsa).

204. Respecto a las características farmacológicas de los antiagregantes plaquetarios, señale la respuesta correcta:

1. La posología de prasugrel y ticagrelor es de 1 dosis diaria (cada 24h).
2. En el contexto del síndrome coronario agudo el clopidogrel debe reservarse para los pacientes de más de 75 años.
3. Si un paciente con FA anticoagulada presenta un SCA, además del AAS deberá administrarse como segundo antiagregante clopidogrel, no estando indicados el prasugrel ni el ticagrelor.
4. El prasugrel está contraindicado en pacientes con antecedente de hemorragia intracranial, pero no de ictus isquémico.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Debes conocer las generalidades de los antiagregantes plaquetarios. En el contexto del SCA, debemos administrar AAS y como segundo antiagregante de elección es el prasugrel, en segundo lugar el ticagrelor (cuando el prasugrel está contraindicado por edad >75 años, peso <60kg o antecedente de ictus de cualquier tipo). Dejaremos el clopidogrel para aquellos pacientes con alto riesgo hemorrágico, ya que de los segundos antiagregantes es el menos potente. Recuerda que un SCA tratado de forma conservadora también debe ir con doble antiagregación, pudiendo utilizarse ticagrelor o clopidogrel, este último si el riesgo hemorrágico es alto (que suele serlo en aquellos pacientes que por fragilidad se decide estrategia conservadora). La posología del prasugrel y clopidogrel es de una toma diaria, mientras que el ticagrelor es dos veces al día (cada 12h). Como particularidad, en aquellos pacientes que estén anticoagulados previamente o vayan a precisar anticoagulación indefinida, tras ICP deberemos administrar además de la anticoagulación AAS y clopidogrel, pudiendo suspender al de 1 semana o 1 mes el AAS, y manteniendo durante 6-12 meses en función del riesgo hemorrágico el clopidogrel. Como el paciente tiene indicación de ACO permanente, estará con su anticoagulante de por vida, sin necesidad de añadir antiagregantes salvo nuevos eventos o revascularizaciones. Por el contrario, lo que no podemos tener es a un paciente con indicación de ACO exclusivamente antiagregado.

- 205. Mujer de 52 años, sin antecedentes de enfermedad hepática conocida, acude por astenia progresiva y malestar general. En la analítica destaca una elevación mantenida de transaminasas (GOT 120, GPT 135), bilirrubina normal e hipergammaglobulinemia. Los autoanticuerpos revelan ANA positivo a títulos bajos. No toma fármacos hepatotóxicos ni consume alcohol. ¿Qué prueba es más útil para confirmar el diagnóstico sospechado?:**

1. Cuantificación de ceruloplasmina.
2. Detección de anti-LKM1.
3. Dosificación de ferritina.
4. Biopsia hepática.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La sospecha clínica es una hepatitis autoinmune por el perfil de transaminasas elevadas, ANA positivo e hipergammaglobulinemia. La biopsia hepática es clave para confirmar el diagnóstico, ya que muestra la clásica inflamación portal con infiltrado linfoplasmocitario. La ceruloplasmina se usa para descartar enfermedad de Wilson (poco probable en este contexto). Los anti-LKM1, aunque útiles, son muy específicos de hepatitis autoinmune tipo 2, más frecuente en niños. La ferritina se relaciona con hemocromatosis, cuyo perfil clínico y analítico es distinto.

- 206. ¿Qué parámetro no actúa como predictor temprano de preeclampsia en el primer trimestre de embarazo?:**

1. Tensión arterial materna elevada.
2. PIGF disminuido.
3. Multiparidad.
4. Índice de pulsatilidad de las arterias uterinas elevado.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

El cribado de preeclampsia se realiza teniendo en cuenta factores clínicos maternos (tales como antecedente de trastorno hipertensivo, DM 1 o 2, LES, SAF, nuliparidad.), así como la tensión arterial media materna, el índice de pulsatilidad de las arterias uterinas y un marcador proangiogénico (el PIGF). El cálculo combinado de riesgo identificará aquellas pacientes con alto riesgo de desarrollar una preeclampsia, las cuales se beneficiarán de la administración de ácido acetilsalicílico hasta la semana 36. La multiparidad no constituye un factor de riesgo de preeclampsia.

- 207. Paciente de 52 años que acude a la consulta refiriendo cefalea y mareos ocasionales, junto con prurito generalizado. A la exploración física destaca eritrosis facial y esplenomegalia palpable. En la analítica encontramos: Hematocrito 61%, Hb 15 g/dl, leucocitos 14.000/mm³, plaquetas 373.000/mm³. La saturación de oxígeno es del**

96%. Señale la afirmación verdadera sobre la enfermedad que sospecha en esta paciente:

1. La histamina suele estar elevada en sangre.
2. El clorambucil se ha demostrado muy útil en el control de la enfermedad.
3. La fosfatasa alcalina granulocítica suele estar disminuida.
4. La volemia suele estar disminuida.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

El cuadro clínico descrito es compatible con una policitemia vera (PV), panmielopatía clonal adquirida en la que existe una hiperplasia de las 3 series en médula ósea, con predominio de la serie roja. Hay un incremento de los hematíes, con VCM disminuido, que conduce a un aumento del volumen plasmático e hiperviscosidad sanguínea (resp. 4 incorrecta), lo cual predispone a fenómenos trombóticos. El volumen eritrocitario mayor del 25% del normal (calculado con técnicas isotópicas) es un criterio diagnóstico mayor de PV. Hay leucocitosis, fundamentalmente a expensas de los neutrófilos, que presentan un aumento de la actividad de la fosfatasa alcalina leucocitaria, al contrario de lo que se observa en la leucemia mieloide crónica (resp. 3 incorrecta). Hay trombocitosis por hiperplasia de la serie megacariocítica. Pero existe tendencia a las hemorragias por disfunción plaquetaria. Sin la realización de un trasplante de médula ósea, la PV es incurable, aunque en muy raras ocasiones requiere este procedimiento. El tratamiento de elección en casos asintomáticos son las flebotomías repetidas. En casos sintomáticos se da quimioterapia con hidroxiurea, un citostático (resp. 2 incorrecta). El clorambucil es el tratamiento clásico de la leucemia linfática crónica. Entre las manifestaciones clínicas de la PV podemos encontrar prurito por hipersecreción de histamina, secundaria al aumento en el número total de basófilos (resp. 1 correcta).

208. Paciente de 35 años que sufre un traumatismo durante un partido de fútbol, tras caerse hacia atrás y golpearse fuertemente la parte posterior de la cabeza contra el suelo. Acude al Servicio de Urgencias de tu hospital, refiriendo diplopía vertical de unas horas de evolución, tras la caída. En la exploración, encontramos su ojo derecho en hipertropía (hacia arriba) y un torticolis compensador con la cabeza inclinada hacia el hombro izquierdo. ¿Que esperarías encontrar en este paciente?:

1. Parálisis del musculo recto inferior del ojo derecho.
2. Maniobra de Bielchowsky + sobre su hombro derecho.
3. Maniobra de Bielchowsky + sobre su hombro izquierdo.
4. Atrapamiento del musculo recto superior de su ojo derecho, por posible fractura del techo de la orbita.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

El paciente refiere diplopía vertical, es decir, ve doble en vertical con los 2 ojos abiertos tras un traumatismo de la parte posterior de su cabeza. El ojo derecho del paciente está más alto que su ojo izquierdo, puesto que el traumatismo occipital, le ha producido una parálisis del IV par craneal de su ojo derecho, ya que es el par craneal más largo y da doble vuelta al tronco del encéfalo y es el que más fácilmente se puede lesionar en un traumatismo occipital. Al tener una parálisis del oblicuo superior del OD, ese ojo no puede bajar a la punta de la nariz, por eso está en hipertropía (más alto) y, como es un músculo inciclotorsor, el torticolis compensador del paciente es hacia el hombro contrario (hombro izquierdo) y la maniobra diagnóstica, la maniobra de Bielchowsky, es + hacia el hombro del ojo parético, en este caso, el hombro derecho.

209. Señale la respuesta correcta en relación a la respuesta inmune:

1. Los 3 principales tipos de tejido linfoide periférico son el bazo, los nódulos linfáticos y el tejido linfoide asociado a mucosa (MALT).
2. Los linfocitos y las líneas mieloides derivan de una célula madre mesenquimal pluripotencial.
3. Los mastocitos están especializados en la respuesta inmune contra virus y secretan sustancias que alejan a los eosinófilos y basófilos del lugar de inflamación.
4. Los linfocitos T maduran en la médula ósea.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Los mastocitos intervienen principalmente en las reacciones de hipersensibilidad tipo I y secretan distintos mediadores entre los que destacan los factores quimiotácticos (atren) a eosinófilos y basófilos. Los linfocitos T proliferan en la médula ósea pero maduran en el TIMO. Los linfocitos y líneas mieloides derivan de la célula madre multipotente de la médula ósea pero no mesenquimal. Por tanto la verdadera es la 1. Pregunta clave ya que repasa varios conceptos básicos de la inmunología.

210. Una paciente de 45 años refiere palidez digital llamativa, en ocasiones con cianosis, tras la exposición al frío. Desde hacía tiempo refería edema en ambas manos con sensación de "tirantez" en la piel, que está áspera y seca. Asimismo presenta caries frecuentes, dificultad para tragar y a la exploración llama la atención su cara, con escasa expresión y una boca "pequeña". Ocasionalmente tiene poliartritis simétrica en las manos. Hace meses que las actividades diarias le provocan disnea y tos seca. Su médico de cabecera la remite al hospital para el estudio. ¿Cuál es su diagnóstico más probable?:

1. Polimiositis con dermatomiositis.
2. Esclerosis sistémica.
3. Enfermedad mixta del tejido conectivo.
4. Lupus eritematoso sistémico.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

En la esclerosis sistémica tienen lugar alteraciones a nivel del endotelio vascular, del sistema inmune y del tejido conectivo, que dan lugar a la proliferación de fibroblastos y depósito de colágeno con la consiguiente esclerosis de piel y órganos internos. Además de la induración, tirantez y signos atróficos de la piel pueden afectarse diversos órganos y tejidos. La afectación vascular se manifiesta en forma de fenómeno de Raynaud, la musculoesquelética en forma de miopatía y artritis, la gastrointestinal como disfagia y reflujo gastroesofágico, la pulmonar como alveolitis y fibrosis, además de hipertensión pulmonar aislada no asociada a afectación parenquimatosa, la cardíaca en forma de bloqueos y arritmias, y la renal con la crisis renal esclerodérmica.

MEDICINA AMIR

